

【一目了然学中医丛书】



脉诊

一学就通

让你轻松学习中医精华的人门书

◎林政宏博士 编著



广东人民出版社
广东科技出版社
全国优秀出版社

脉诊 一学就通



【一目了然学中医丛书】

- 一目了然学方剂
- 中医入门一学就通
- 图解针灸一学就通
- 黄帝内经一学就通
- 图解中医诊断入门
- 99味常用中药入门
- 针灸甲乙经一学就通
- 中医养生 洞悉肥胖症与高脂血症
- 脉诊一学就通
- 濒湖脉学一学就通



ISBN 978-7-5359-4276-0



9 787535 942760 >

定价：28.00 元

【一目了然学中医丛书】

脉诊 一学就通

林政宏博士 编著

广东省出版集团
广东科技出版社
· 广州 ·

前言

脉诊又称切诊。脉诊在中医诊断上占有极为重要的分量。所谓“望、闻、问、切”四诊合参，以笔者多年的经验认为，脉诊在临床诊断时，可以比喻为具有“画龙点睛”、“临门一脚”的作用，也就是说，“望、闻、问”三诊所推断出来的病证，如果可以从脉诊中得到印证，那么，对于疾病的诊断，就可以避免误诊而更为精确。

然而，由于脉学的理论精深而复杂，经过几千年来江湖术士的吹嘘与误导，使得一般人很难认识脉学的真象，误以为当代高明的医生，必须具备有神通的本领，不需经过“望、闻、问”三诊，只要凭着脉诊，双手一“切”，就应该要能说出患者一切的病证，这实在是对中医的误解。

客观地说，对于某些典型的病证，例如肝血虚的病人，左关部会出现濡脉或虚脉，此时的确可以从脉诊得知，但这并不代表只要是左关部出现濡脉或虚脉，就能说是肝血虚。

这是因为病证存在着真、假、虚、实的分别，而病证与脉象之间，又可以分为证脉相符与证脉不符的两种类型。人的体质各有差异，病情也各有不同，对于一个具有责任感与科学态度的医生来说，不选择以“望、闻、问、切”客观地来诊断病情，反而仅凭着脉诊来炫耀自己的医术，这不是显得太武断、也太冒险了吗？

就如汉末著名医家王叔和在《脉经》中所说：这以后学医的人，由于对脉理的认识蒙昧不清，彼此之间又存在着偏见，因此为了炫耀一己之能，反而使轻病变得更为严重，甚至断绝了生机，这确实是有原因的。

王叔和说：如果把沉脉诊断为伏脉，治疗就会出错；如果把缓脉诊断为迟脉，危险的结果就会立即到来。更何况，同一种病证通常兼具几种不同的脉象，或是不同的疾病却具有相同的脉象，怎么能不细心审度呢？

因此，在古代，即使王叔和与扁鹊的医术相当高明，诊断时尚且需要思考；张仲景虽然擅于辨证，也要用心诊察病证，如果发现任何疑惑不明时，就会详加查核以求得验证。

这就是说明一个科学的态度。

如果把脉诊视为中医诊断的最高境界，过度夸大了切诊的作用，而把“望、闻、问”三诊抛之脑后，就好比想画龙，却只画上龙的眼睛，而不画龙的身体一样地可笑。

本书的编撰，详细描绘了28脉的脉形，列举临床上常见的病证，并摘录《脉经》第八卷的部分内容，用来进一步说明脉诊的应用，总之，是为使初学者能对脉学建立起正确的认识，并且，再次强调，脉诊再怎么重要，也不能取代中医诊断的全部。

中医历史源远流长，本人才疏学浅，编著此类书籍时，不胜惶恐，盼前辈们能不吝赐教，感激不尽。

林政宏 博士
herbdrin@hotmail.com

contents

目 录

一、脉诊的起源与发展

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1 脉学的先行者：扁鹊···1 | 8 脉学的实行家：《伤 |
| 2 脉学的老先知：医缓···1 | 寒杂病论》···3 |
| 3 脉学的始祖论著：
《脉法》和《阴阳脉
死候》···1 | 7 脉学的大一统：《脉
经》···3 |
| 4 脉学的奠基石：《黄
帝内经》···2 | 9 脉学之歌：《脉诀》···4 |
| 5 脉学的革命家：《难
经》···2 | 9 脉学的评论：《脉诀
刊误》···4 |
| | 10 脉学的终结者：《濒
湖脉学》···4 |

二、十八脉的判别

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1 切诊···5 | 5 诊脉断病···6 |
| 2 脉象原理···5 | |
| 3 诊脉部位···7 | |
| 4 寸口诊法···7 | 6 脉象的至数···10 |
| 5 寸口诊法所候脏气···8 | 7 正常的脉象···11 |
| 6 切诊的注意事项···9 | 8 其他的特殊事项···13 |
| 7 脉象的归类···14 | |
| 1 浮类脉···15 | 9 数类脉···18 |
| 2 沉类脉···16 | 10 虚类脉···19 |
| 3 迟类脉···17 | 11 实类脉···20 |
| 4 28种脉象的主病与特征···21 | |
| 5 28种脉象的分布···23 | |
| 1 浮类脉···23 | 4 数类脉···24 |
| 2 沉类脉···23 | 5 虚类脉···25 |
| 3 迟类脉···24 | 6 实类脉···25 |
| 7 脉象的主病与鉴别···26 | |
| 1 浮脉···26 | 8 散脉···33 |
| 2 洪脉···27 | 9 芤脉···35 |
| 3 濡脉···31 | 10 革脉···36 |

7 沉脉	40	18 动脉	62
8 伏脉	42	19 虚脉	64
9 牢脉	44	20 微脉	66
10 弱脉	46	21 细脉	68
11 迟脉	48	22 代脉	70
12 缓脉	50	23 短脉	72
13 涩脉	52	24 实脉	74
14 结脉	54	25 长脉	77
15 数脉	56	26 滑脉	79
16 疾脉	58	27 弦脉	82
17 促脉	60	28 紧脉	85

三、实例说明 87

1 头身发热	94	8 慢性肝炎	119
2 咳嗽	101	9 糖尿病	121
3 支气管炎	104	10 慢性肾炎	126
4 高血压	107	11 坐骨神经痛	128
5 心脏病	109	12 妇女痛经	131
6 胃溃疡	113	13 妇女带下	134
7 肝硬化	116	14 更年期综合征	136

四、脉经《卷八》 138

1 平卒中厥脉证第一	138	7 平消渴小便利淋脉证第七	158
2 平痉湿喝脉证第二	140	8 平黄疸寒热疟脉证第九	160
3 平阳毒阴独百合狐惑脉证第三	145	9 平胸痹心痛短气贲豚脉证第十	166
4 平霍乱转筋脉证第四	149	10 平腹满寒疝宿食脉证第十一	168
5 平中风历节脉证第五	150	11 平惊悸衄吐下血胸满瘀血脉证第十三	174
6 平血痹虚劳脉证第六	154		

一、脉诊的起源与发展

1. 脉学的先行者：扁鹊

脉诊究竟起源于何时，至今仍缺少明确的证据，但根据有关历史资料的记载，脉诊最早可以追溯到公元前6世纪之前。

创始人为秦越人（公元前6世纪），是战国时期著名的医家，世称扁鹊。

扁鹊以“诊脉”的专长闻名于世，因此汉朝司马迁在《史记》里有“至今天下言脉者，由扁鹊也”的赞誉。由此可以推断，早在公元前6世纪时，扁鹊已经能运用诊脉法来诊断疾病。

2. 脉学的老先知：医缓

医缓，春秋时期秦国人。据《左传》记载，秦桓公（公元前603～577年）派遣医缓到晋国，为晋国国君景公治疗。医缓在诊断后，直言不讳地对晋景公说：“疾不可为也”，这是因为病情已严重到“在膏之上，膏之下”的末期，就算以砭石、针灸攻治也不及，即使以药物来治疗，药物也达不到病所，已经毫无生机可言了。这也是成语“病入膏肓”的由来。

膏肓之疾，在于脏腑之内，医缓是怎么诊断得知的呢？仅凭着“望、闻、问”三诊，就能作出这样大胆的结论吗？

由此可以推断，医缓在诊断时，必定配合了脉诊的参考，才敢冒死在国君面前说出这么肯定而又晦气的话。

当然，这也说明脉诊在诊断上所起到的作用。

3. 脉学的始祖论著：《脉法》和《阴阳脉死候》

1973年初至1974年初，长沙市马王堆三号汉墓出土的帛书

中，有《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》甲本、《脉法》、《阴阳脉死候》、《五十二病方》、《却谷食气》、《阴阳十一脉灸经》乙本、《导引图》、《养生方》、《杂疗方》和《胎产书》等11种医书。据考证得知，成书年代均不晚于秦汉之际（公元前3世纪末），甚至早于《黄帝内经》。

其中的《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》甲、乙本，全面论述了人体十一条经脉的循行走向及所主治的疾病，为目前发现最早有关经脉学说的文献。

《脉法》和《阴阳脉死候》则有论述脉象与诊断的简单记载，可能是后来《黄帝内经》的最早版本。

4. 脉学的奠基石：《黄帝内经》

《黄帝内经》包括《灵枢》和《素问》两部分，各卷81篇，共80余万字。

《黄帝内经》的著作年代，至今尚无定论，不过应不晚于战国时期。从其内容看，并非成于一人一时，可能是历代医家托名于黄帝及其臣子岐伯、雷公、鬼臾区、伯高等所成之作。

《黄帝内经》可能是由《脉法》和《阴阳脉死候》基础上发展而来。在其《素问·三部九候论》中，首先确立了三部九候诊法的诊脉方法，对于脉学理论与脉象的临床运用。在《素问·脉要精微论》、《素问·平人氣象论》、《素问·玉机真脏论》、《素问·三部九候论》、《素问·经脉别论》、《素问·通评虚实论》、《素问·大奇论》等篇中均有详细的阐述。

5. 脉学的革命家：《难经》

《难经》的成书年代晚于《黄帝内经》，相传为扁鹊所作，但后人考证后认为，应是经由历代医家修改补充所成，而非成于一人一时。

《难经》是在《黄帝内经》的基础上，以问答的方式来阐述《灵枢》和《素问》的精华，全书分为八十一难，其中第一难至第二十二难，是讨论脉象的疑难问题。

《难经》的主要特色是提出了“三部九候”法崭新的论点，比如《难经》根据脏腑表里的关系，把大肠归于右寸，小肠归于左寸，手厥阴心包络及手少阳三焦经归于右尺，与《黄帝内经》的论点并不相同，因此也导致后世医家对“三部九候”法所候的脏腑部位产生了不同的意见。

6. 脉学的实行家：《伤寒杂病论》

《伤寒杂病论》是东汉末年张仲景（公元150～219年）所作。

《伤寒杂病论》继承了《黄帝内经》与《难经》的理论基础，将诊脉法应用于临床诊断上，创立了“辨证论治”的治疗法则，其中《平脉法》与《辨脉法》两篇，详细论述了脉学的临床运用。

《伤寒杂病论》在诊治外感内伤杂病时，其处方用药的法则，皆以脉象的变化来作为辨证的基础。该书除了以约1/3的条文记载脉学的内容外，还将脉象分为阴阳两类，以此来诊断疾病的进退与顺逆。如《伤寒论·辨脉法》曰：“凡脉大、浮、数、动、滑，此名阳也；脉沉、涩、弱、弦、微，此名阴也”。“凡阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死”。

7. 脉学的大一统：《脉经》

《脉经》是汉末至西晋由王叔和（公元201～280年）所撰，是中医史上第一部的脉学专著。

《脉经》首先确立了“浮、芤、洪、滑、数、促、弦、紧、沉、伏、革、实、微、涩、细、软、弱、虚、散、缓、迟、结、代、动”等24种脉象的名称，并且描述了各个脉象的脉形与相似脉象的鉴别。

《脉经》所提出的24种脉象，除了软脉改名为濡脉，以及新增加的长、短、牢、疾4种脉象之外，其余的脉象全部被后世医家沿用至今。

8. 脉学之歌：《脉诀》

《脉诀》是六朝人高阳生所撰，是第一部以歌诀方式阐述脉学的医书。

《脉诀》计有歌诀200余首，由于文字通俗易懂，便于诵读记忆，因此深受初学者欢迎，对于后世脉学的普及有很大的帮助。

9. 脉学的评论：《脉诀刊误》

《脉诀刊误》由元朝戴起宗所撰，是第一部脉学批判的专著。

由于《脉诀》中的某些论点并不完整，因此历代均有医家提出异议。其中以元朝的《脉诀刊误》的内容最为详细。

《脉诀刊误》根据《黄帝内经》、《难经》、张仲景及王叔和的脉学理论，针对《脉诀》的不足，在脉形的描述与脉形的主病等方面均提出全新的论点。

10. 脉学的终结者：《濒湖脉学》

《濒湖脉学》为明朝李时珍所撰（1564年）。《濒湖脉学》延续了《脉经》的理论基础，总结了明朝之前历代脉学的经验而写成。内容主要分为《四言诀》和《七言诀》两大部分。

《四言诀》相当于该书的简介，讲述了经脉的生理、脉象形成的机理，诊脉的方法，诸脉的形态，各脉的主病，以及诸病脉象等内容。

《七言诀》是相当于该书的各论，分别记述了27脉的形态、主病及相似脉象的鉴别。

李时珍强调四诊合参，反对单以脉诊决定病情。至于论脉方面，将24脉分为七表、八里、九道，把“浮、大、数、动、滑”归类为阳，“沉、短、涩、弱、微”归类为阴。



二、二十八脉的判别

(一) 切诊



中医师解说

H E A L T H F U L

中医之诊断为“望、闻、问、切”这四诊，其中切诊指的是脉诊，又称切脉。切诊从最初的“遍诊法”（即切诊头部、手部、足部的动脉），发展为目前以寸口脉（即手部桡骨动脉处，为肺经通过的部位），就能判断疾病所属表里、寒热、虚实的变化。

1. 脉象原理

心主血脉：由于心脏推动血液在脉管内运行，使脉管产生搏动，于是形成了脉搏。此处应该注意的是，血液在脉管中运行，除了心脏的搏动外，还必须要有肺、脾、肝、肾的配合。

肺朝百脉：全身的血脉，都汇聚于肺，肺主气，透过肺气的舒布，血液才能布散全身。

脾主统血：血液在脉管内循行而不至于溢出脉外，必须靠脾气的统摄。

肝主藏血：肝可以调畅气机和调节血量的大小。

肾主藏精：精可以化生为气，是人体阳气的根本，同时精还能化生为血，是生成血液的物质基础之一。

因此，脉象的形成，与脏腑气血有密切的相关。



相关的原理

H E A L T H F U L



2. 诊脉断病



中医师解说

由于脉象的形成，和脏腑的气血变化有关，因此当人生病时，血脉的运行必然受到影响，使得脉象产生变化，虽然病情的变化十分复杂，但是从脉象的变化中，还是可以分辨疾病的病位、性质与邪正的盛衰。

当切诊的脉象为浮脉时，通常为表证；如果为沉脉，通常为里证。

如果切诊的脉象为迟脉，通常为寒证；如果为数脉，通常为热证。

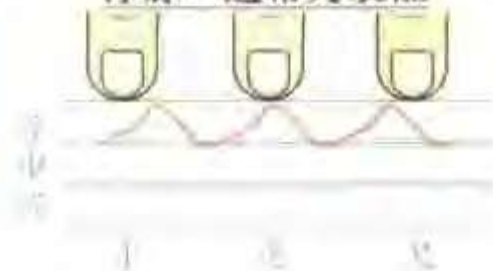
如果切诊的脉象虚弱无力，通常为虚证；如果脉象实而有力，通常为实证。



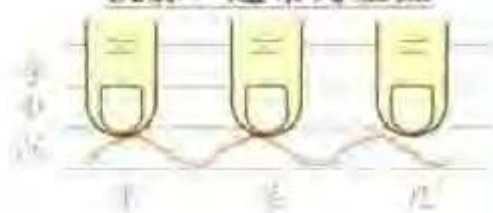
相关的原理

HEALTHY

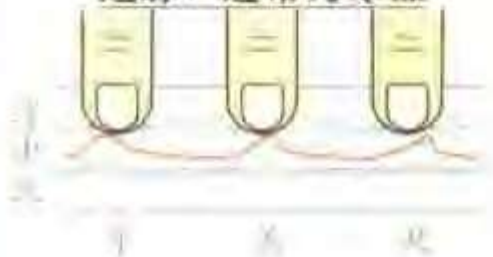
浮脉：通常为表证



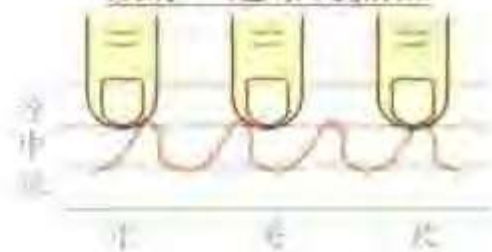
沉脉：通常为里证



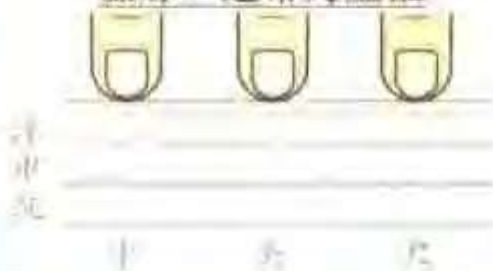
迟脉：通常为寒证



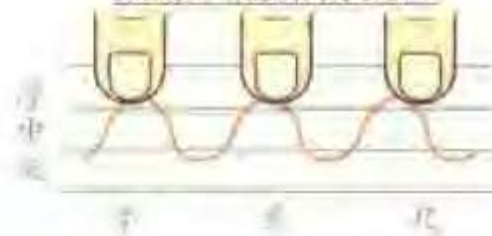
数脉：通常为热证



虚脉：通常为虚证



实脉：通常为实证



(二) 诊脉部位

1. 寸口诊法



中医师解说

寸口分寸、关、尺三部，掌后高骨（桡骨茎突）为关，关前为寸，关后为尺。两手各分寸、关、尺三部，共六部脉。

寸口分寸、关、尺三部，掌后高骨（桡骨茎突）为关，关前为寸，关后为尺。两手各分寸、关、尺三部，共六部脉。

寸关尺三部又可以分为浮、中、沉三个部位来按脉，因此称为三部九脉。



2. 寸口诊法所候脏气



历代的医家，对于寸口诊法所候脏气的看法略有差异，但是大体来说，右手的寸关尺可以分别候：肺、脾和肾（命门）；左手的寸关尺可以分别候：心、肝和肾。

★名词解释

命门：命门为人体生命的根本因而得名，在人体五脏中除了肾具有两枚以外，其余肝、心、脾和肺都仅有一枚，因此有些医家认为左肾属阴，因称为肾；右肾属阳，因而为命门。



3. 切诊的注意事项

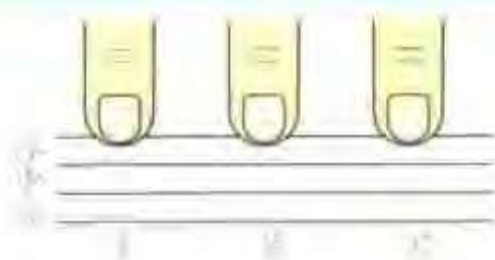
诊脉前必须让病人休息，保持安静，避免外界干扰，使病人气血平静。切脉时，病人的手臂应与心脏保持同一高度，掌心朝上平放，使血流通畅，医生先以中指按病人的高骨定“关”，食指定“寸”，无名指定“尺”。

当把位置取准后，三个指头应略呈弓形使指头平齐，以指腹接触脉体，用轻、中、重三种指力，分别在三部探寻脉象，称为“举按寻”。用轻指力按在皮肤上叫“举”，又叫浮取或轻取；用重指力按在筋骨间叫“按”，又称沉取或重取；手指不轻不重地移动或改变力道仔细求取脉象叫“寻”。

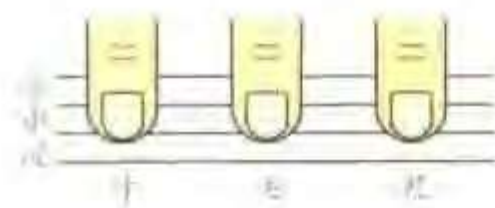


相关的原理

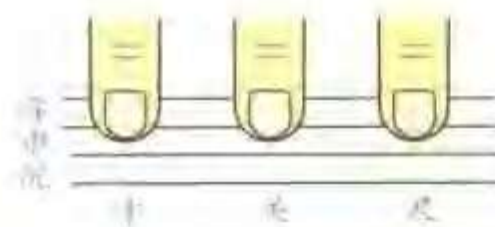
H E A L T H I S F U L



举：用轻指力按在皮肤上



按：用重指力按在筋骨间



寻：指力不轻不重仔细求之

4. 脉象的至数

HEALTHFUL



中医师解说

诊脉时，医生的呼吸要均匀，用一呼一吸的时间去计算病人脉搏的至数。

一呼一吸称一息，正常人通常一呼气脉搏有二至，一吸气脉搏也有二至，一呼一吸之间有一至，因此，正常的脉象是一息四至或五至（正常人的呼吸每分钟约17~18息，相当于脉搏每分钟72~80次）。



正常的脉象是一息四至或五至

切诊时，通常要求必须切满五十动，主要是为诊断有无促脉、结脉或是代脉。

但是，在临床切脉时，可以视个别情况，适当地调整诊脉的时间，如果太拘泥于形式，反而显得食古不化。



相关的原理

HEALTHFUL

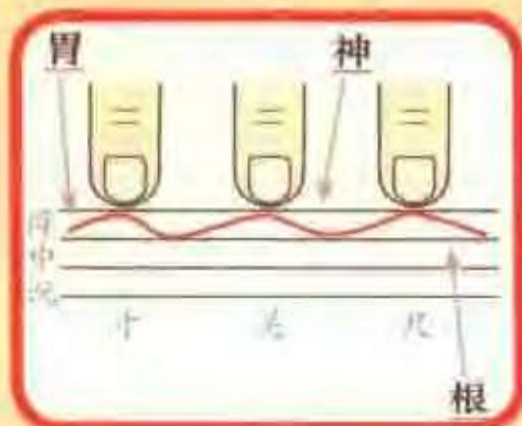
5. 正常的脉象

HEALTHFUL



中医师解说

正常的脉象
必须具备有胃、
有神、有根三个
特点。

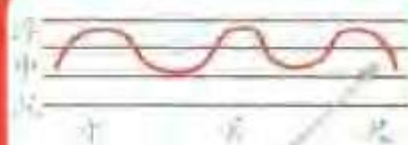


中医师解说

HEALTHFUL

有胃：胃是人体后天气血的来源，因此有胃气，表示脉象有力有神，无胃气则代表脉象无力无神。

正常的脉象不浮不沉，不快不慢，从容和缓，便可以称为有胃气。



有胃：从容和缓
的脉象

甚至当人生病时，
不论脉象是浮沉迟数，
只要仍具有和缓的脉
象，也算是胃气。



相关的原理

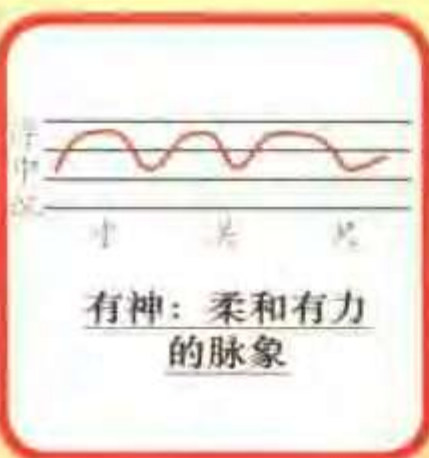
HEALTHFUL

HEALTHFUL



中医师解说

有神：心主血而藏神，血气充盈，脉象自然有神。有神的脉象，柔和有力，节律一致。



当人生病时，即使是弦实的病脉，只要弦实之中仍有柔和感；或是病脉虽然微弱，但在微弱中还不至于全然无力时，都称为有神。



相关的原理

HEALTHFUL

HEALTHFUL

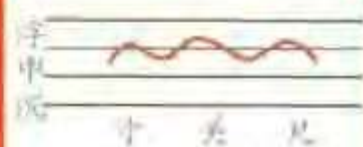


中医师解说

有根：肾为先天之本，肾气充足，脉自然有根。切诊时，尺部可以候肾，沉取也可以候肾。

如果“寸关尺”三部的脉象都沉取有力，甚至只要尺脉沉取有力时，都算是有根的脉象。

因此当人生病时，如果还有肾气，就可以从尺脉感到肾气，表示先天之本尚未绝灭，仍具有生机。



有根：尺部沉取有力的脉象

6. 其他的特殊事项



中医师解说

HEALTHFUL

1. 由于受气候的影响，正常脉也会随季节而有春弦、夏洪、秋浮、冬沉的变化。

春季阳气已升，
但寒气未尽除，
气机仍有约束之象，
故脉稍弦。



夏天阳气隆盛，
脉气来势盛而去势衰，
故脉稍洪。

秋天阳气收敛，
脉象来势减弱而轻，
故脉稍浮。



冬天阳气潜藏，
脉气来势沉而搏指。

2. 性别：妇女脉象通常比男子略快。妇女婚后怀孕，脉常见滑数而平和。
3. 年龄：年龄越小，脉搏越快，婴儿每分钟脉搏120~140次；五六岁的幼儿每分钟脉搏90~110次。
4. 体形：身材高大的人，脉象的形态通常比较长；矮小的人，脉象的形态相对较短；瘦子的肌肉薄，脉象偏浮；胖子的皮下脂肪厚，因此脉象通常比较沉。



相关的原理

HEALTHFUL

5. 奇脉：有些人的脉象，六脉虽然沉细却没有病象，称为“六阴脉”；也有些人的脉象，六脉虽然洪大也没有病象，称为“六阳脉”。

还有些人，脉象比较奇怪。比如，寸口诊不到脉，却出现在从尺部斜向手背的位置，称为“斜飞脉”；或者脉象出现在寸口的背侧，就称为“反关脉”。

总之，以上这些位置的变异，都不算是病脉。



相关的原理

H E A L T H F U L

(三) 脉象的纲领



中医师解说

H E A L T H F U L

脉象总共有28种，学习脉诊，可以先将脉象分类为浮、沉、迟、数、虚、实6种脉。先把这6种脉象弄明白，然后再细分二十八脉，就比较容易记忆了。

1 浮类脉：共有浮、洪、濡、散、芤、革6种脉，脉位皆浮。

2 沉类脉：共有沉、伏、牢、弱4种脉，脉位皆沉。

3 迟类脉：共有迟、缓、涩、结4种脉，脉率皆慢。

4 数类脉：共有数、疾、促、动4种脉，脉率均快。

5 虚类脉：共有虚、微、细、代、短5种脉，脉皆无力。

6 实类脉：共有实、长、滑、弦、紧5种脉，脉皆有力。

浮类脉：共有浮、洪、濡、散、
芤、革6种脉，脉位皆浮。

浮类脉的特点：脉象都位于皮肤表浅处（洪脉除外）。

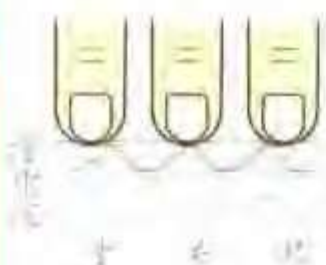
也就是说，只要把指头轻轻按在皮肤上，就能感觉到脉搏的搏动，如果用力重按，反而会觉得脉搏减弱，或是脉搏有空虚的感觉。



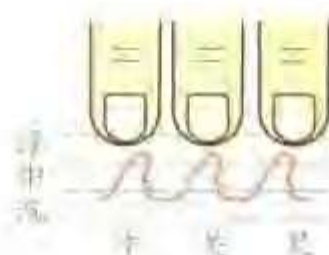
相关的原理

H E A L T H F U L

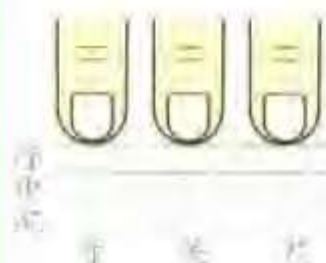
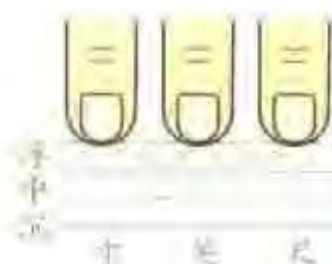
浮脉轻取即得，
重按稍减而不空。



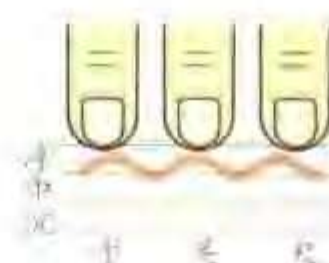
洪脉极大，
来盛去衰。



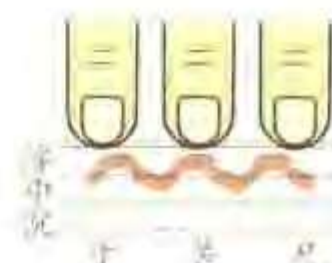
濡脉浮而细软。



散脉浮大无根，
至数不齐。



芤脉浮大中空，
如按葱管。



革脉弦急中空，
如按鼓皮。

2 沉类脉：共有沉、伏、牢、弱4种脉，脉位皆沉。

沉类脉的特点：脉象位于筋骨深处。

也就是说，当指头轻按在皮肤上时，脉搏的搏动很不明显，必须用力重按到筋骨深处，才能感觉到脉搏的搏动。

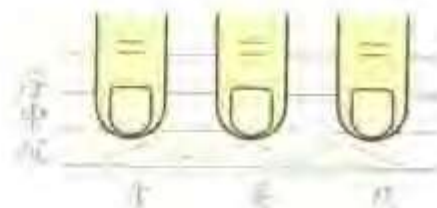
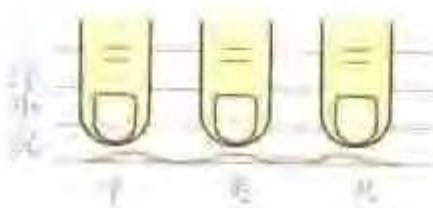
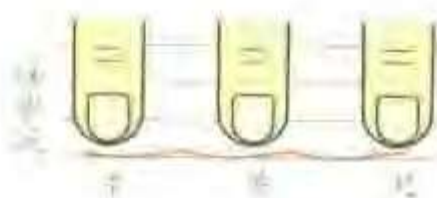
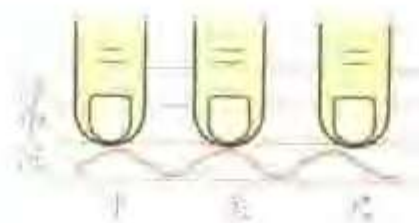


相关的原理

H E A L T H F U L

沉脉轻取不应，重按始得。

伏脉贴着筋骨重按才得。



牢脉沉按实大弦长。

弱脉沉而柔细。



迟类脉：共有迟、缓、涩、结4种脉，脉率皆慢。

迟类脉的特点：脉搏的频率很缓慢，因此使得脉搏的至数减少。

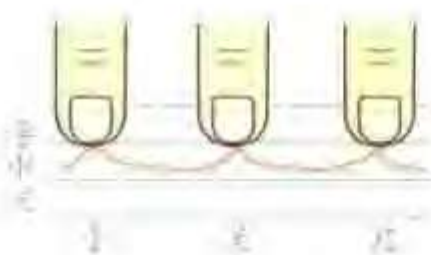
至于脉象的部位，在“浮中沉”三部都可以诊得到脉搏。



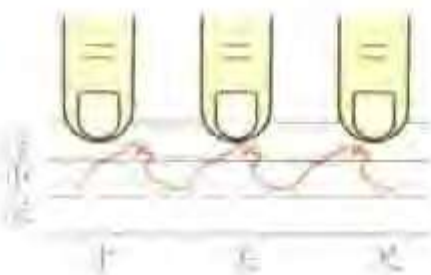
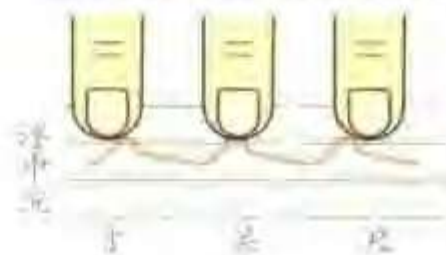
相关的原理

H E A L T H F U L

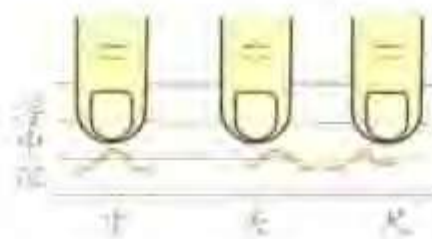
迟脉来去迟慢，一息三至。



缓脉比迟脉稍快，一息四至，脉来怠缓。



涩脉迟细而短，往来艰涩。



结脉迟缓而时止，止无定数。

4

数类脉：共有数、疾、促、动
4种脉，脉率均快。

数类脉的特点：脉搏的频率很快，因此使得脉搏的至数过多。

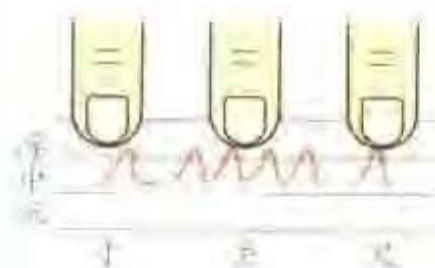
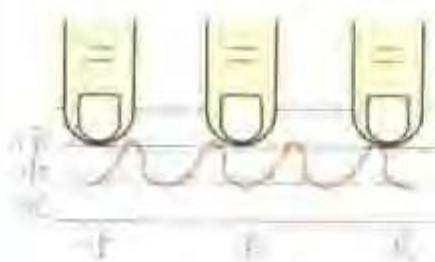
至于脉象的部位，在“浮中沉”三部都可以诊得到脉搏。



相关的原理

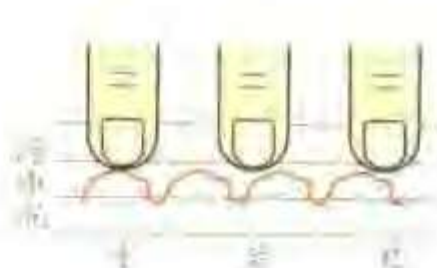
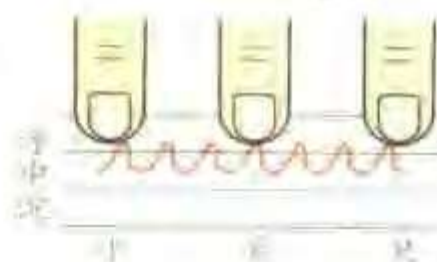
H E A L T H F U L

数脉一息五至以上。



促脉数而时止，
止无定数。

疾脉一息七八至，
脉来急疾。



动脉滑数有力，
脉形如豆，振振动摇。

5 虚类脉：共有虚、微、细、代、短5种脉，脉皆无力。

虚类脉的特点：脉象柔软无力。

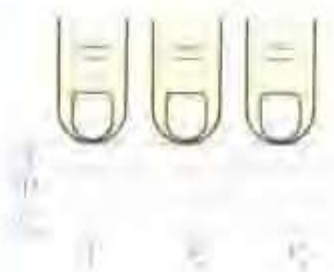
虚类脉所包含的范围很广，无论是浮位或沉位，无论频率的快慢，只要脉搏的搏动很弱，脉体软的，都属于虚类脉。



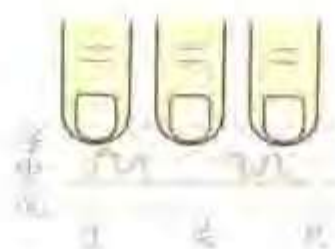
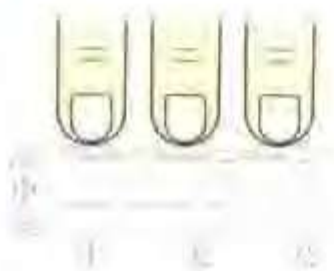
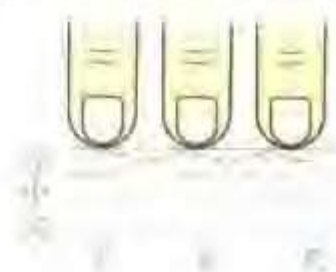
相关的原理

H E A L T H F U L

虚脉举之无力，按之空虚。



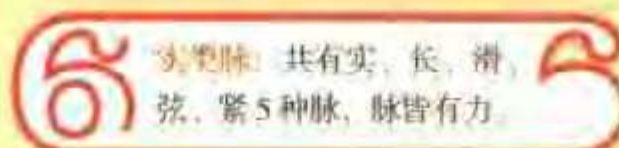
微脉极细极软，似有似无，至数不明。



细脉脉细如线，但应指明显。

代脉脉来动而一止，止有定数，良久方来。

短脉首尾俱短，不及本位。



实类脉的特点：脉象强劲有力。

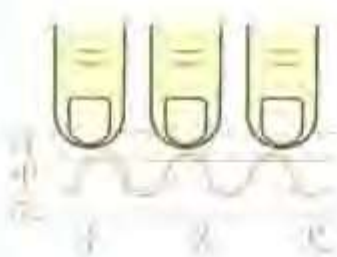
实类脉所包含的范围很广，无论是浮位或沉位，无论频率的快慢，只要脉搏的搏动很强，脉体大的，都是属于实类脉。



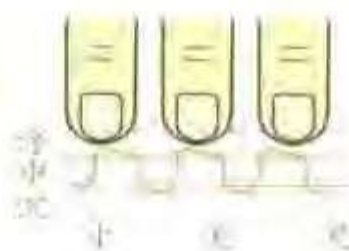
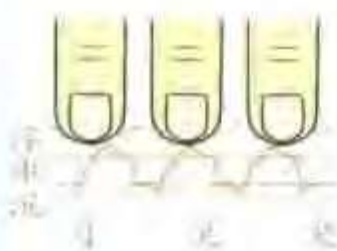
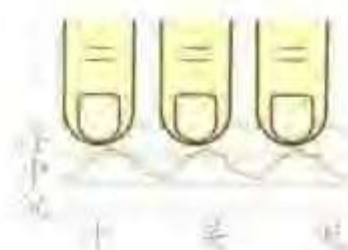
相关的原理

HEALTHFUL

实脉浮中沉三部举按均有力。



长脉首尾端直，超过本位。



滑脉往来流利，应指圆滑，如盘走珠。

弦脉端直以长，如按琴弦。

紧脉脉来绷急，状如牵绳转索。

(四) 28种脉象的主病与特征

一 浮类脉主病		特征
1	浮脉主表证(脉必浮而有力) 也可见于风水	浮脉轻取即得,重按稍减而不空
2	洪脉主热证	洪脉极大,来盛去衰
3	濡脉主阴阳气血诸虚	濡脉浮而细软
4	散脉主元气离散	散脉浮大无根,至数不齐
5	芤脉主失血或阴伤	芤脉浮大中空,如按葱管
6	革脉主亡血、失精	革脉弦急中空,如按鼓皮
二 沉类脉主病		特征
7	沉脉主里证 沉而有力为里实 沉而无力为里虚	沉脉轻取不应,重按始得
8	伏脉主邪闭,厥证,痛证	伏脉贴着筋骨重按才得
9	牢脉主阴寒内盛	牢脉沉按实大弦长
10	弱脉主气血亏虚	弱脉沉而柔细
三 迟类脉主病		特征
11	迟脉主寒证 迟而有力为寒实证(注:或为实热证) 迟而无力为虚寒证	迟脉来去迟慢,一息三至
12	缓脉主湿,或主脾虚	缓脉比迟脉稍快,一息四至,脉来怠缓
13	涩脉主精伤,血少,气滞,血瘀	涩脉迟细而短,往来艰涩
14	结脉主阴盛气结,也主气血虚衰	结脉迟缓而时止,止无定数

(续上表)

四	数类脉主病	特征
15	数脉主热。数脉亦主虚证	数脉一息五至以上
16	疾脉主阳极阴竭，元气将脱	疾脉一息七八至，脉来急疾
17	促脉主阳盛实热，血气痰饮， 宿食停滞。促脉也主元气虚衰	促脉数而时止，止无定数
18	脉主痛，主惊	动脉滑数有力，脉形如豆，振振动幅
五	虚类脉主病	特征
19	虚脉主虚证	虚脉举之无力，按之空虚
20	微脉主气血诸虚	微脉极细极软，似有似无，至数不明
21	细脉主气血两虚，诸虚劳损	细脉脉细如线，但应指明显
22	代脉主脏气衰微	代脉脉来动而一止，止有定数，良久方来
23	短脉主气病 短而无力主气虚证 短而有力主气实证	短脉首尾俱短，不及本位
六	迟类脉主病	特征
24	实脉主实证 实脉也可见于阴寒厥冷之证	实脉浮中沉三部举按均有力
25	长脉主阳证，如肝阳有余，或阳盛 内热之证	长脉首尾端直，超过本位
26	滑脉主痰饮，宿食，实热，蓄血	滑脉往来流利，应指圆滑，如盘走珠
27	弦脉主肝胆病，主痰饮，主诸痛， 主疟疾，弦脉亦主虚	弦脉端直以长，如按琴弦
28	紧脉主寒，主痛，主宿食	紧脉脉来绷急，状如牵绳转索

(五) 28种脉象的分类

1 浮类脉：共有浮、洪、濡、散、芤、革6种脉，脉位皆浮。

风水：主要病因为风邪侵袭人体，又因平素脾肾阳虚所引起的水湿不化的病症。主要症状为发病较为急骤，身体发热且恶风，骨节疼痛，身体浮肿，并以头面部较为明显。



浮脉主表证（脉必浮而有力）。洪脉主热证。濡脉主阴阳气血诸虚。



散脉主元气离散。芤脉主失血或阴伤。革脉主亡血，失精。

2 沉类脉：共有沉、伏、牢、弱4种脉，脉位皆沉。

亡血：泛指体内各项出血的症候，如吐血、衄血（鼻出血）、尿血、便血等。



沉脉主里证，沉而有力为里实；沉而无力为里虚。



伏脉主邪闭，厥证，痛证。



牢脉主阴寒内盛。



弱脉主气血亏虚。

3

迟类脉：共有迟、缓、涩、结
4种脉，脉率皆慢。



迟脉主寒证。

迟而有力为寒实证（注：或为实热证）。

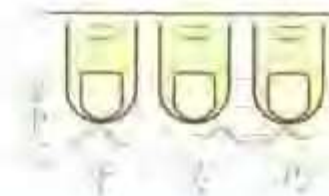
迟而无力为虚寒证。



**涩脉主精伤，血少，
气滞，血瘀。**



缓脉主湿，或主脾虚。



**结脉主阴盛气结，
也主气血虚衰。**

4

数类脉：共有数、疾、促、动
4种脉，脉率均快。



数脉主热；数脉亦主虚证。



**促脉主阳盛实热，血气痰饮，
宿食停滞；促脉也主元气虚衰。**



疾脉主阳极阴竭，元气将脱。



动脉主痛，主惊。

5 虚类脉：共有虚、微、细、代、短5种脉，脉皆无力。



虚脉主虚证。



微脉主气血诸虚。



细脉主气血两虚；
诸虚劳损。



代脉主脏气衰微。



短脉主气病。
短而无力主气虚证。
短而有力主气实证。

6 实类脉：共有实、长、滑、弦、紧5种脉，脉皆有力。



实脉主实证，
实脉也可见于阴寒厥冷之证。



长脉主阳证，如肝阳有余，
或阳盛内热之证。



滑脉主痰饮，宿食，
实热，蓄血。



弦脉主肝胆病，主痰饮，
主诸痛，主疟疾，弦脉亦主虚。



紧脉主寒，
主痛主宿食。

(六) 脉象的主病与鉴别

1. 浮脉



浮脉主表证（脉必浮而有力）也可见于风水。

★名词解释

表证：是指邪气侵袭人体的肌表后，所出现恶寒、发热、四肢酸痛、舌苔薄白、脉浮等症状。

(1) 脉象：浮脉轻取明显，重按稍减而不空。



中医师解说

H E A L T H F U L

切脉时，用指轻按在肌表上就可以感到搏动；当用力重按时，反而感到指下的搏动减弱，但脉体并没有空虚的感觉。

(2) 脉理：

1. 当外部有致病之气侵袭肌表时，人体卫气与外邪互相斗争，因此脉气搏动有力，脉位浮而明显。
2. 当人体因久病而虚衰时，由于体内的气血亏虚，阳气不能附于阴液而浮越于外，此时的脉象就显得浮大而无力的。



相关的原理

H E A L T H F U L

(3) 鉴别：



中医师解说

H E A L T H F U L

浮脉与芤、洪、紧、数4种脉象类似。这些脉象的特点是脉位都位于肌表浅处，因此很容易与浮脉混淆。



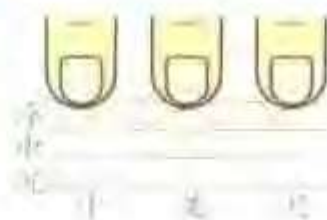
中医师解说

H E A L T H F U L

脉象的鉴别：

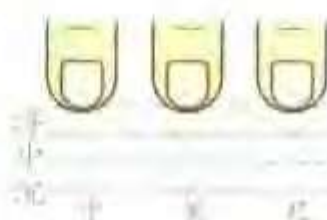
1. 浮脉的脉形不大不小，轻取明显，重按稍减，脉体没有空虚感。
2. 芤脉的脉位浮，脉体形大却有空虚感，如同按在葱管上。
3. 濡脉的脉位浮，脉形细小而柔软。
4. 虚脉的脉象软弱无力，脉形细小并且有空虚感。
5. 散脉的脉位浮，好像没有根基的浮萍一样散乱，脉形细小并且至数不齐。

芤脉浮大中空
如按葱管。



濡脉浮而
细软。

虚脉举之无，
按之空虚。



散脉浮大
无根。

(4) 主病:

1. 浮脉通常主表证时，则脉象有力，不大亦不小。
2. 当浮脉主虚证时，则脉象表现为浮大却无力。
3. 浮脉也可能出现于风水或皮水的患者，也就是说，当风邪夹着水湿壅积于肌表时，也会出现浮脉。



相关的原理

★名词解释

虚证：是指由于人体的气血不足，脏腑机能衰退所引起的症候。

皮水：为脾胃阳虚所引起的水湿不化，泛溢于皮肤肌表的病症。主要症状为发病较为缓慢，全身的皮肤冰冷、浮肿，肢体疼痛或沉重。

(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	症状表现
浮紧	伤寒
浮缓	中风
浮数	风热
浮虚	伤暑
浮洪	热盛
浮弦	头痛
浮滑	风痰

★名词解释

热证：指风邪与热邪相结合而侵袭人体的病邪。临床表现为热重，恶寒轻，口燥咽干，舌边尖红，苔微黄，脉浮数等症候。

风痰：指风邪与痰浊相结合而侵袭人体的病邪。

2. 洪脉



洪脉主热证。

★名词解释

热证：是指由于外感侵袭人体，入里而化热，所引起如发热、面红、口渴、烦躁、便秘、舌苔厚黄等的症状。

(1) 脉象：洪脉极大，脉形如波涛般汹涌，来盛去衰。



中医师解说

HEALTHFUL

洪脉的脉体浮大，有如波涛般汹涌，来势强而有力，之后就逐渐衰减，因此脉象在去时比来时显得势缓而力弱。

(2) 脉理：

当人体内的邪热炽盛时，由于邪热会灼伤阴液，以至于阳气独盛而充击血脉，此时因脉管中的血液远远不及阳气的强盛，因此导致脉管扩张，出现脉来洪大，脉去稍减的洪脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

洪脉与实脉类似，脉象都是强盛有力。

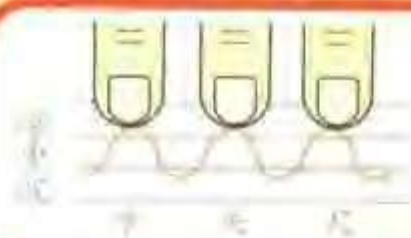


中医师解说

H E A L T H P U L S E

脉象的鉴别:

1. 洪脉轻取时如波涛般汹涌，重按去数，沉取时反而满为实邪。
2. 实脉虽然不如洪脉狂急，但在浮取或沉取时，脉极为有力，不论来去都十分流畅。



实脉浮、中、沉三部举按均有力。

(4) 主病:



中医师解说

H E A L T H P U L S E

洪脉主热证，通常是由于阳热亢盛至极，或是由于阳明经有火热内蕴，所产生如烦渴、面红、身热等症状，因而会出现如波涛般汹涌，来盛去衰的洪脉。

(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	浮洪	沉洪	洪滑	洪数	洪大而长
症状表现	表热	里热	痰热	热盛	暑温兼湿

★名词解释

表热:是指人体于感受风热后，出现发热、恶风、有汗或无汗、口渴、舌红、苔薄白或黄、脉浮数等表证的状态。

里热:是指由于体内的邪热炽盛，通常是指胃肠实热、肺胃实热，或是肝胆湿热。临床表现为高热、口渴、烦躁、口苦、便秘、舌苔厚黄、干燥或起芒刺、脉洪数有力等。

痰热:痰浊与邪热相互搏结所形成的病邪。

3. 濡脉



(1) 脉象：脉位浮，脉形细小而柔软。



中医师解说

HEALTHFUL

濡脉的脉形细小柔软，浮取时才能感到微弱的搏动；如果用指力重按，反而感受不到搏动。

(2) 脉理：

1. 濡脉主气血诸虚。当体内的气血亏损时，由于阳气衰弱而无力运行血液，以至于血液冲击脉管的力道不足，因此会出现浮软而无力的脉象。
2. 当湿邪蕴阻于内时，由于气血的输布受到阻碍，此时也会出现濡脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

HEALTHFUL

濡脉与微脉，弱脉类似，都属于柔软无力的脉象。

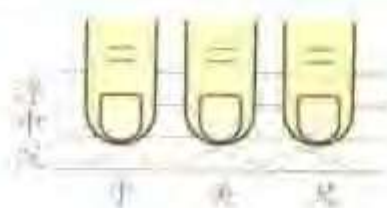


中医师解说

H E A L T H F U L

脉象的差别：

1. 濡脉的脉位浮，轻取就能感觉得到。
2. 沉脉的脉位沉，必须重按才得。
3. 微脉的脉位可以在浮位或沉位，虽然细而柔软，却模糊不清，好像是若有若无，欲绝非绝的形态。



弱脉沉而柔细。

微脉极细极软，
似有似无，至数不明。

(4) 主病：

1. 濡脉主阴阳气血诸虚。
2. 濡脉也主湿邪内蕴：凡是由于湿邪壅滞于体内，以至于阻遏阳气而不能正常输布，产生如头重如裹，脘闷困重，肌肤浮肿，胸膈腹胀等症状时，都会出现濡脉。



相关的原理

H E A L T H F U L

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	濡迟	濡数	濡涩	濡缓
症状表现	虚冷	阴精亏耗或湿热	亡血	寒湿

4. 散脉



散脉主元气离散。

★名词解释

元气离散：当人体于重病或大失血等生命垂危时，由于阴阳离绝，元气将无所依附而离散。

(1) 脉象：浮散无根，至数不齐。



中医师解说

HEALTHFUL

散脉浮散无根，浮取时脉象时快时慢，来去不明，重按时反而摸不着脉。

(2) 脉理：

当脏腑元气即将绝竭时，由于心力衰竭，阳气离散，以至于血液难以正常运行，因此会出现脉象浮散而无根，时快时慢，没有规律的散脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

HEALTHFUL

散脉与濡、虚、芤脉类似，都属于脉位浮的脉象。

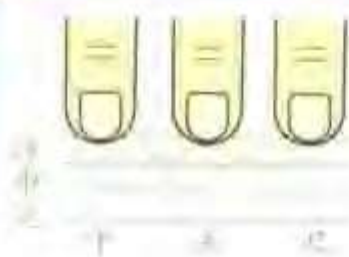
HEALTHFUL



中医师解说

脉象的鉴别：

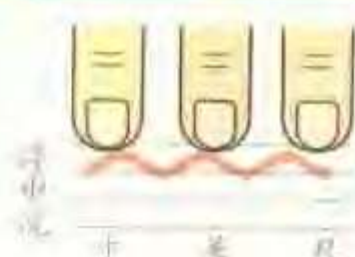
1. 散脉浮散无根，没有应指。
2. 濡脉的脉位浮，细小而柔软，且有脉体。
3. 虚脉的脉位浮大，浮中沉三部都软弱无力，却仍有根。
4. 芤脉的脉位浮大，浮取时脉管中空，大而柔软。



濡脉浮而细软。



虚脉举之无力，
按之空虚。



芤脉浮大中空，
如按葱管。

(4) 主病：

散脉主元气离散，如果人体于精血严重损伤时，由于阴阳离绝，脏腑气血即将衰竭，因而会出现散脉。



相关的原理

HEALTHFUL

5. 芤脉



芤脉主失血或阴伤。

★名词解释

失血：由于外伤或内因等因素，导致人体内的血液流失，则称为失血。

阴伤：由于体内的高热不退或是因过服温燥的药物，都会耗损阴液导致阴液损伤。

(1) 脉象：浮大中空，如按葱管。



中医师解说

HEALTHFUL

轻聚时脉管柔软中空，脉形大，像在按葱管。

脉管周围力道较强，脉管中空处显得无力；重按时脉象减弱。

(2) 脉理：

当人体因失血过多或是因体液大伤时，由于体内的血量突然减少，使得阴血不足以充润脉管，因而导致脉管空虚，此时阳气没有阴液可以依附而浮越在外，于是形成脉管浮大中空之芤脉。

相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

芤脉与革、虚两脉类似，三者都具有脉管中空之脉象。

HEALTHY



中医师解说

脉象的差别：

1. 芤脉浮大中空，如同按在葱管上，周围的脉管较为柔软。
2. 革脉也是浮大中空，却搏指有力，如同按在鼓面上，周围的脉管较为刚硬。
3. 虚脉的脉位浮大，浮中沉三候均软弱无力，却促有根。



革脉弦急中，如按鼓皮。



虚脉举之无力，按之空虚。

(4) 主病：

芤脉主失血或阴液耗损等症候。比如吐血、崩中、尿血等出血证，或是吐泻、大汗等因素，使得体内的津液大伤时，都会出现芤脉。



相关的原理

HEALTHY

★名词解释

崩中：又称为“崩漏”，是指妇女不在行经期间，阴道内大量出血，或持续出血，淋漓不断的病症。如果出血量多而来势急骤的，称为“血崩”。如果出血量较少，但持续不断的，称为“漏下”。

(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	浮芤	芤数	芤虚	芤迟
症状表现	气阴两伤	阴虚	亡血失精	失血正虚

★名词解释

失精：又称为“遗精”，主要病因为肾气不固，或是相火炽盛（肾中阴虚所致的虚火炽盛），或是湿热下注等因素所引起。如果于做梦中而遗精的，称为“梦遗”；如果于白天时而精自滑出的，称为“滑精”。

6. 革脉



(1) 脉象：浮而搏指，中空外坚，如按鼓皮。



HEALTHFUL

革脉脉象浮大中空，却搏指有力，如同按在鼓皮上。周围的脉管显得较为刚硬，脉管中空且无力；重按时脉数减弱。

中医师解说

(2) 脉理：

当体内的精血严重亏损时，由于阴血不足以充润脉管，因而造成脉管空虚，此时阳气没有阴液可以依附而浮越在外，于是形成脉管浮大中空之革脉。

一般来说，革脉的脉象比芤脉更强而有力，显示革脉的阳气比芤脉更为强盛。

HEALTHFUL



相关的原理

(3) 鉴别：



HEALTHFUL

革脉与芤、虚两脉类似。三者都具有脉管中空的脉象。

中医师解说

H E A L T H F U L



中医师解说

脉象的差别：

1. 革脉浮大中空，如搏指有力，如同按在鼓皮上，周围的脉管较为刚硬。
2. 芤脉的脉象浮大中空，如同按在葱管上，周围的脉管较为柔软。
3. 虚脉的脉位浮大，浮中沉三候均软弱无力，却仍有根。



芤脉浮大中空，如按葱管。



虚脉举之无力，按之空虚。

(4) 主病：

革脉主亡血、失精的症候，当人体因气血亏虚，精液损耗严重时，都会出现革脉。



相关的原理

H E A L T H F U L

7. 沉脉



沉脉主里证，
沉而有力为里实，
沉而无力为里虚。

★名词解释

里证：是病邪气侵袭人体的肌表后，邪气内传入里，所出现的各种症状。

里实：是指由于外邪侵袭人体，入里而化热，或是由于气滞血瘀、感邪、食积等壅聚于胃肠，临床表现为壮热、烦渴、便秘等症状。

里虚：是指由于人体的气血不足，脏腑机能衰退所引起的虚证。

痰饮：痰饮是多种水饮病的总称，泛指体内水液由于运化不利，停积于脏腑经络或四肢等处的病证。其主要病因多与脾、肺、肾三脏的功能失调有关。

(1) 脉象：轻手不应，重按乃得。



中医师解说

HEALTHFUL

沉脉在浮位和中位都不明显，只有重按接近筋骨时，才能感觉到搏动。

(2) 脉理：

1. 里实证：当病邪入里时，如果患者的气血充盛，能与病邪对抗，正气与邪气相互斗争，以至于出现沉而有力的脉象，称为里实证。
2. 里虚证：如果患者的气血亏虚，无力输布气血，以至于出现沉而无力的脉象，称为里虚证。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

沉脉与伏、牢、结等类似，四者的脉位都在沉部，重按时才可得。

H E A L T H F U L



中医师解说

脉象的鉴别:

1. 沉脉位于筋骨处，重按才可得。
2. 伏脉比沉脉的脉位更深，位于筋骨内，即使重按也不可得，必须贴骨按才能诊到脉象。
3. 牢脉与沉脉很类似，但脉形比较弦长，像是附着在筋骨上，似乎要牢不移。
4. 弱脉也位在沉位，但脉柔软而无力。



伏脉贴着筋骨重按才得。 牢脉沉按实大弦长。 弱脉沉而柔细。

(4) 主病:

沉脉主里证，沉而有力：表示为里实证，常见于痰食、气滞、寒邪积滞，或是下痢、水肿等症候。

沉而无力：表示为里虚证，常见于气弱血虚，阳气衰微等症候。



相关的原理

★名词解释

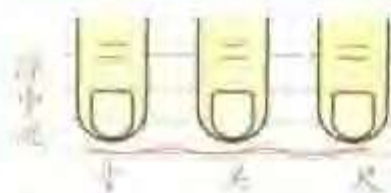
痰食：痰浊与食积相互结聚而为病。

H E A L T H F U L

(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	沉迟	沉数	沉缓	沉涩	沉滑	沉弦	沉紧
症状表现	里寒	里热	水湿	气郁	痰食或湿热	内痛	冷痛

8. 伏脉



伏脉主邪闭，
厥证，痛证。

★名词解释

邪闭 邪病发展的过程中，由于人体的正气不足，致使邪气更为深入而难出。由于邪气阻遏阴阳气血的散布，因而出现脏腑功能闭塞不通的病症。

厥证 为平素因元气虚弱，或是因肝阳偏旺，或是因精神遭受过度刺激等因素，致使气机逆乱，所引起意识心神的症状。主要表现为突然昏倒，不省人事，四肢厥冷等症状。

痛证 由于体内的气滞血瘀，或是痰饮，食积等因素，阻遏气血的运行，气血不通则疼痛内生。

(1) 脉象：贴着筋骨重按才得。



中医师解说

HEALTHFUL

伏脉位于筋骨内，即使重按也不可得，必须贴着筋骨才能诊到脉息。

(2) 脉理：

1. 当体内的邪气炽盛时，容易阻遏气血的运行，以至于脉气无法正常运行，因此会出现脉象深伏的伏脉。



相关的原理

2. 如果因久病不愈而正气衰微时，阳气不足以鼓动血脉，也会出现伏脉。

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

伏脉与沉脉类似。

H E A L T H F U L



中医师解说

脉象的差别：

1. 伏脉比沉脉的脉位更深沉，几乎是贴着筋骨。
2. 沉脉在浮位和中位都不明显，只有重按到筋骨时，才能感觉到搏动。



伏脉轻贴着筋骨，
重按才得。

(4) 主病：

1. 伏脉主邪闭、厥证、痛证。凡是实邪内伏，如气闭、寒闭、热闭、火闭、痛极、腹内积块造成脏痛的积聚、体内水液长期留滞所形成的留饮、脾胃消化不良，食物留积胃中之宿食、霍乱吐衄等病症，都容易出现伏脉。
2. 伏脉亦主阳衰。凡是心阳衰弱，阳气欲绝而出现神昏厥逆时，也会出现脉伏而无力。



相关的原理

H E A L T H F U L

★ 名词解释

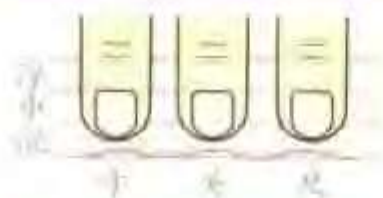
气闭、寒闭、热闭、火闭：当人体的正气不足时，气滞、寒凝、热邪、火邪皆会引起闭证。

积聚：气滞、血瘀，或是痰饮、食积等因素皆会导致积聚的产生。

留饮：指长期滞留于体内而难以消散的水湿痰饮。病因为脾胃阳虚，运化水湿的功能减退，导致津液凝滞所致。主要表现为呼吸气短、口渴或口不渴、胃脘容易胀满等症状。

宿食：又称为“食积”或“积食”。主要病因为脾胃运化失常，食物消化不良而停积于胃肠的病症。主要症状为脘腹满闷，食欲不振，口臭口苦，舌苔厚腻等症状。

9. 牢脉



牢脉主阴寒内盛。

(1) 脉象：沉按实大弦长，坚牢不移。



HEALTHFUL

牢脉附着在筋骨上，
坚牢不移，因此脉形比较
弦长。

中医师解说

(2) 脉理：

当体内的阴寒亢盛时，由于寒邪的特性为收引凝滞，以至于阳气潜藏而难以升张，因此会出现沉而弦长，坚牢不移的牢脉。

HEALTHFUL



相关的原理

(3) 鉴别：



HEALTHFUL

牢脉与沉脉，伏脉类似。

中医师解说

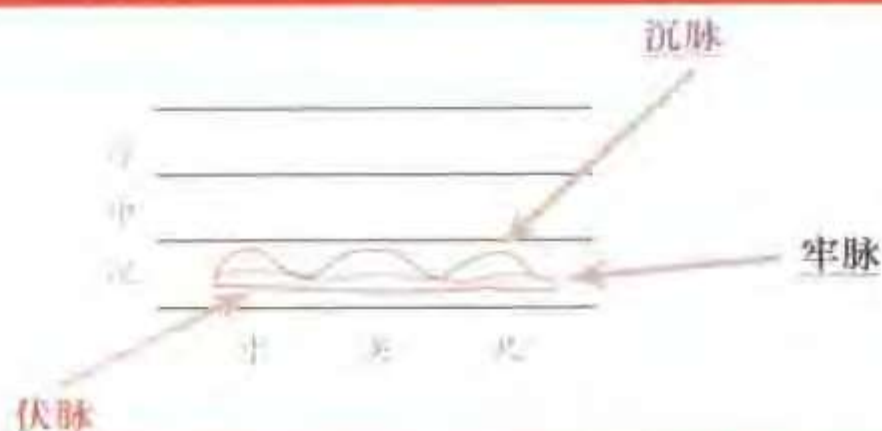
H E A L T H F U L



中医师解说

脉象的差别：

牢脉比沉脉深沉，几乎是贴着筋骨固定不移的搏动，但是相对来说，牢脉还比不上伏脉来得深沉。



(4) 主病：

牢脉主体内的阴寒之邪亢盛；比如阴寒内盛所致的心腹疼痛，风痉拘急等症候，都会出现牢脉。



相关的原理

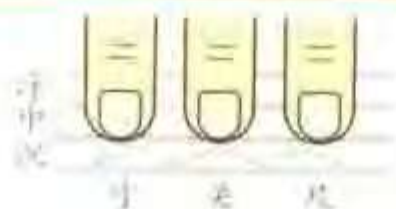
HEALTHFUL

★名词解释

痉病：主要病因为外邪侵袭人体后，从燥而化或从风而化所致。的症状。如果因热盛伤阴，或是误吐、误汗、误下时，也会引起痉病的产生。痉病的临床表现为身热足寒（恶寒时觉头热、面赤、目赤），颈项强急，背强反张，口噤不开，脉沉细或疾数等症候。

风痉拘急：由于风邪所引起的痉病。

10. 弱脉



弱脉主气血亏虚。

(1) 脉象：极软而沉细。



中医师解说

HEALTHFUL

弱脉轻取不得，必须重按才能诊得，并且显得柔软而无力。

(2) 脉理：

当体内的气血不足时，由于血液不能充盈脉道，阳气无力推动血液的运行，因此会出现沉而细软的弱脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

HEALTHFUL

弱脉与濡脉，微脉类似，都是细软而无力。



中医师解说

脉象的鉴别:

1. 弱脉在沉位。
2. 濡脉在浮位。
3. 微脉可以出现在浮位或沉位，脉身如模糊不清，若有若无，应指非应。
4. 细脉的脉形细小，如应指明显，不似微脉的脉象模糊不清。



微脉极细极软，似有似无，至数不明。

细脉脉细如线，但应指明显。

(4) 主病:

弱脉主气血亏虚。如果因久病不愈而耗伤元气，或是因失精亡血，虚劳久咳，或是因脾虚泄泻，胃弱纳呆，筋骨痿弱等症候，都会出现弱脉。

相关的原理

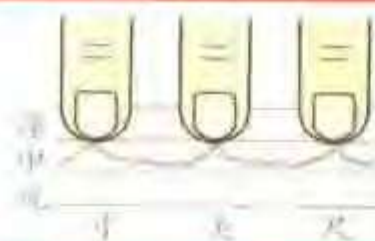
★名词解释

胃弱纳呆：又称为“胃呆”。主要病因胃的受纳与降浊的功能呆滞，主要表现为消化不良，食欲不振等症候。

(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	涩弱	弱微	弱数
症状表现	血虚、血瘀	气衰	阴虚、血虚

11. 迟脉



迟脉主寒证，
迟而有力为寒实证。
(注：或为实热证)，
迟而无力为虚寒证。

★名词解释

寒实：指人体的正气并不虚衰，但体内有寒邪停聚的病证。表现为身肢不温，畏寒肢冷，小便清长，腹痛，便秘，舌苔白，脉沉弦等症候。

虚寒：指人体的正气虚衰，且体内有寒邪的病证。表现为食欲不振，畏寒肢冷，面色苍白，大便稀薄，舌淡白，脉微细等症候。

(1) 脉象：脉来迟缓，一息三至。



中医师解说

HEALTHFUL

正常人脉搏的主数，一息四至到五至，而迟脉一息只有三至，此外，迟脉的脉位，不论浮取或沉取都可得。

(2) 脉理：

迟脉不仅主寒证，也主热证。这是因为当体内的寒邪或热邪炽盛时，由于气血的运行受到阻滞，此时，如果出现迟而无力的脉象，则表示为虚寒；如果出现迟而有力的脉象，则表示为寒实证或为实热证，因此，对于迟脉的鉴别，应当谨慎鉴别。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

迟脉与结脉、涩脉类似，三者的脉率都比正常脉稍慢。

★名词解释

实热：是指由于外邪入体，入里而化热，此时由于邪气亢盛而人体的正气亦充足，邪气与正气相互搏击，因而引起的发热症状，临床表现为高热、口渴、烦躁、口苦、便秘、舌苔厚黄、干燥或起芒刺，脉滑数有力等。

H E A L T H F U L

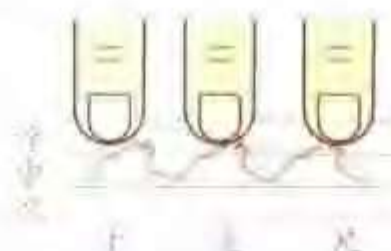


中医师解说

脉象的差别：

1. 迟脉一息只有三至
2. 缓脉比迟脉略快，一息四至
3. 迟脉的脉形细弱且短促，往来艰涩，因此迟脉比正常脉稍慢。

缓脉比迟脉稍快，
一息四至，脉来怠缓。



缓脉一息四至。

迟脉一息三至。

濡脉迟细而短，
往来艰涩。

(4) 主病：

1. 迟脉主寒证，迟而有力为寒实证（注：或为实热证），迟而无力为虚寒证。
2. 迟脉也可主热证；这是因为当体内有热邪凝结时，由于脉管中的血流不畅，以至于瘀热相互搏结于血室，此时就会出现迟脉。



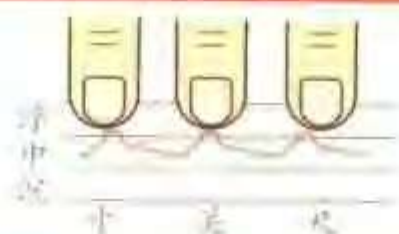
相关的原理

H E A L T H F U L

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	浮迟	沉迟	迟滑	迟涩	迟细
症状表现	表寒	里寒	痰饮	血瘀或血虚	气虚

12. 缓脉



缓脉主湿，或主脾虚。

(1) 脉象：一息四至，来去怠缓。



中医师解说

HEALTHFUL

缓脉比迟脉略快，一息四至。缓脉的脉位，浮取或是沉取都可得。

(2) 脉理：

当体内的脾气虚弱或是湿邪内困时，由于气血的运行不畅，气血不足以充盈脉管，此时就会出现脉来怠缓的缓脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

缓脉与迟脉、涩脉类似。

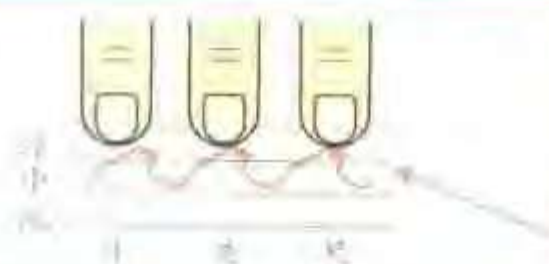
HEALTHFUL



HEALTHFUL

脉象的差别：

1. 缓脉比起脉略快，一息四至。
2. 迟脉一息只有三至。
3. 涩脉的脉形偏细且短促，往来艰涩，因此脉率比正常脉稍慢。



缓脉一息四至。
迟脉一息三至。

涩脉迟细而短，
往来艰涩。

(4) 主病：

缓脉主里有湿邪
积滞，或是主脾气虚
损。



相关的原理

HEALTHFUL

(5) 兼脉主病：

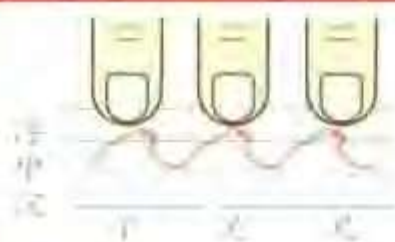
兼脉脉象	浮缓	沉缓	缓而滑	缓弱
症状表现	伤风或风湿	寒湿或湿痹	脾热	气虚

★名词解释

风湿：指风邪和湿邪相结合而侵袭人体的病邪。

湿痹：为风、寒、湿三邪气侵袭人体所引起的痹证，而以湿邪最为偏盛，因此称为“湿痹”，主要症状为肌肤麻木，关节不灵活，痛处固定不移。

13. 涩脉



涩脉主精伤，血少，
气滞，血瘀。

★名词解释

精伤：由于先天禀赋不足，或因久病伤及肾阴肾阳，或因房劳过度，致使肾精的生成受阻。

气滞：是指人体内气机运行不畅，所引起的胀满或疼痛等症状。

(1) 脉象：迟细而短，往来艰涩，极不流利。



中医师解说

HEALTHFUL

涩脉的脉形细短，如同轻刀刮竹一般，往来艰涩，极不流利。

(2) 脉理：

当体内由于精伤、血少、气滞、血瘀等因素阻碍气血运行，导致脉气往来艰涩时，就会出现往来艰涩的涩脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

HEALTHFUL

涩脉与结脉类似，两者的脉象都比较迟滞。

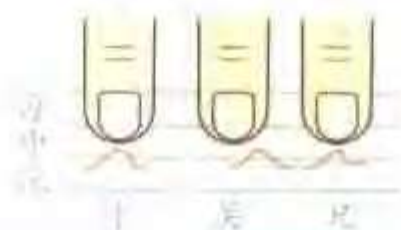
H E A L T H F U L



中医师解说

脉象的差别：

1. 涩脉是因为脉象不流利，往来艰涩，感觉比较迟滞。
2. 结脉的脉象迟滞，虽然没有往来艰涩感，但会突然歇止，并且每次歇止的间隔也没有一定的规律。



结脉迟缓而时止，
止无定数。

(4) 主病：

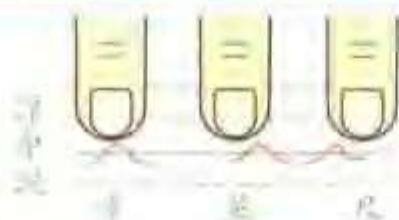
涩脉主精伤，血少，气
滞，血瘀。



相关的原理

H E A L T H F U L

14. 结脉



结脉主阴盛气结，
也主气血虚衰。

(1) 脉象：脉来缓，时而一止，止无定数。



中医师解说

HEALTHFUL

结脉来势迟缓，在搏动时偶尔有一次歇止，然后又开始搏动，每次歇止的间隔没有一定的规律。

(2) 脉理：

如果是因为体内有瘀血，痰饮，宿食，或气滞等因素阻碍气血运行，致使阴液独盛而阳气潜藏不和，此时就会出现脉来迟缓，时而一止的结脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

结脉与促脉、代脉类似，三者都具有突然歇止的脉象。

★名词解释

气滞：是指人体内的气机运行不顺畅，所引起的胀满或疼痛等症状。

H E A L T H F U L

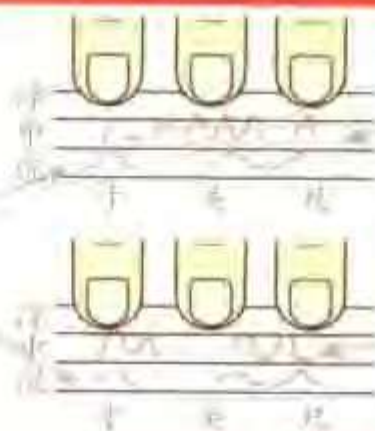


中医师解说

脉象的差别：

1. 结脉的脉象迟缓，每次歇止的间隔没有一定的规律，歇止的时间比较短暂。
2. 促脉的脉象急数，每次歇止的间隔也没有一定的规律，歇止的时间比较短暂。
3. 代脉比促脉迟缓，每到一定的规律就突然歇止，每次歇止的时间较长。

结脉没有一定的
歇止规律。



促脉没有一定的
歇止规律。

代脉有一定的
歇止规律。

(4) 主病：

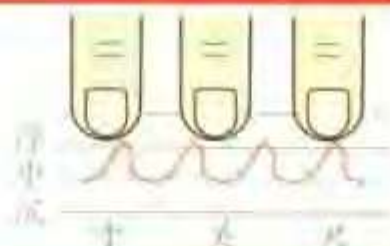
1. 结而有力：结脉主体内的阴液偏盛而气机凝结，比如血瘀，痰饮，宿食，气郁等症状，此时会出现结而有力的脉象。
2. 结而无力：结脉也主气血虚衰，比如当虚劳成疾，久病不愈时，此时则会出现结而无力的脉象。



相关的原理

H E A L T H F U L

15. 数脉



数脉主热
数脉亦主虚证。

(1) 脉象：一息脉来五至以上。



中医师解说

HEALTHFUL

数脉的搏动比正常脉快，在一息（一呼一吸之间）的时间内，脉来超过5次以上，相当于每分钟90次以上。

(2) 脉理：

1. 当体内的邪热炽盛时，由于热邪灼伤阴液，使得阳气亢奋，气血急速地运行，因此会出现数脉。



相关的原理

2. 如果是阴虚严重的患者，由于阴液亏虚以至于虚热内生，此时也会出现虚而无力的数脉。

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

数脉与疾脉、滑脉、脉类似，四者的脉率都比较快。

★名词解释

虚热：是指由于体内的阴液不足或是阳气亏虚所引起的发热症状，临床表现为低热、烦热，或午后潮热，手足心灼热，口干，盗汗，唇舌红，脉虚数等。

H E A L T H F U L



中医师解说

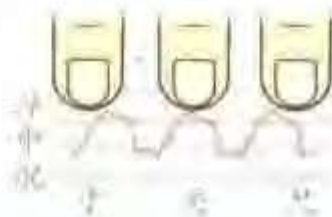
滑数的差别：

1. 数脉在一息之间、脉来超过5次以上。
2. 疾脉的脉率比数脉更快，一息七八至以上，相当于每分钟140次以上。
3. 数脉如豆般圆滑，脉象滑劲而有力，但却摇摆不定。
4. 滑脉往来十分流利，应指圆滑流利，如圆珠般反复旋转。

数脉一息脉来
超过5次以上。



疾脉比数脉更快，
一息七八至以上。



动脉滑数有力，脉形如豆，振振动摇。滑脉往来流利，应指圆滑，如盘走珠。

(4) 主病：

1. 数脉主里有蕴热，如胃热消谷，肠热下利，肺病胁痛、外感邪热，或阴虚火旺等症候，都会出现数脉。
2. 数脉亦主虚证，凡是虚劳亏损的症候，也会出现数脉，此时的脉象以数而无力为特点。



相关的原理

H E A L T H F U L

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	浮数	沉数	数洪	细数	数弦数滑
症状表现	表热	里热	热盛	阴虚内热	肝火痰热

16. 疾脉



★名词解释

阳极阴竭：人体内的实热特别炽盛，以至于阴液严重亏损不足。

(1) 脉象：脉来急疾，一息七八至。



(2) 脉理：



(3) 鉴别：



H E A L T H F U L



中医师解说

脉象的鉴别：

1. 疾脉的脉率比数脉更快，一息七八至以上，相当于每分钟140次以上。
2. 数脉在一息之间，脉来超过5次以上。
3. 动脉如豆形圆滑，脉来滑利而有力，但细短促不定。
4. 滑脉往来十分流利，圆滑流利，如圆珠般反复旋转。

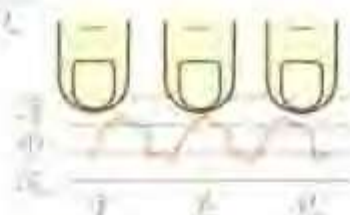
疾脉比数脉更快，
一息七八至以上。



数脉一息脉来超过
5次以上。



动脉滑数有力，
脉形如豆，振振动摇。



滑脉往来流利，
应指圆滑，如盘走珠。

(4) 主病：

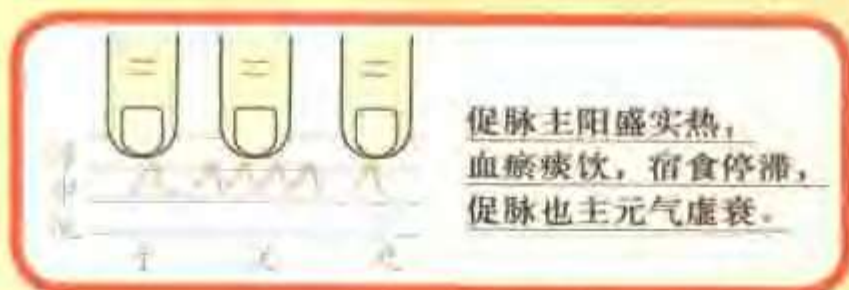
疾脉主阳气亢盛至极而
阴液衰竭，元气即将亡脱的
症候。



相关的原理

H E A L T H F U L

17. 促脉



★名词解释

痰饮：泛指体内的水液由于运化不利，停积于脏腑经络或胸腔等处的病症。其主要病因多与脾、肺、肾三脏的功能失调有关。

宿食：主要病因为脾胃运化失常，食物消化不良而停积于胃肠的病症。主要症状为脘腹胀满，食欲不振，口臭口苦，舌苔厚腻等征状。

(1) 脉象：脉来数，时而一止，止无定数。



(2) 脉理：



(3) 鉴别：





中医解解说

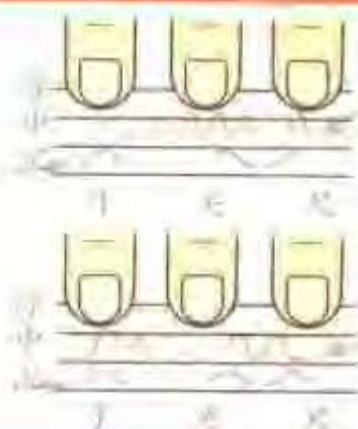
H E A L T H F U L

脉象的类别

1. 促脉的脉象急数，每次歇止的间隔没有一定的规律，歇止的时间比较短暂。
2. 结脉的脉象迟涩，每次歇止的间隔没有一定的规律，歇止的时间比较短暂。
3. 代脉比较急数，每到一定的脉率就突然歇止，每次歇止的时间较长。

结脉的脉象迟缓，
没有一定的歇止规律。

结脉没有一定的
歇止规律。



促脉没有一定的
歇止规律。

代脉有一定的
歇止规律。

(4) 主病:

促脉主阳气亢盛，里有蕴热，或是体内有血瘀、痰饮、宿食停滞等症候；促脉也主元气虚衰。



相关的原理

H E A L T H F U L

(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	浮而促	促而有力	促而无力
症状表现	阳明温病	实邪郁滞	真元虚衰

★名词解释

真元：指元气。元气发源于肾，为先天之精所化生而成，包括元阴之气和元阳之气，主要功能为推动脏腑组织活动，为人体生化动力的源泉。

18. 动脉



动脉主痛，主惊。

(1) 脉象：脉形如豆，振振动摇，滑数有力。



中医师解说

HEALTHFUL

动脉的脉形如豆般圆滑，滑数而有力，然而脉体却摇撼不定。

(2) 脉理：

1. 当体内有瘀血，气滞等痛证时，容易导致阴阳失调；或是当惊恐慌张时，则容易导致气血紊乱，这些因素会使得体内气血的运行升降失常，此时就会出现振振动摇，滑数有力的动脉。
2. 如果人体的气血失去约束而窜动，以至于阴阳气血在脉管中相互搏击，就会出现脉管随着气血窜动而摇撼不定的动脉。

相关的原理

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

动脉与数脉，疾脉，滑数相似，四者的脉率都比较快。

HEALTHFUL



中医师解说

数脉的鉴别：

1. 动脉如豆圆滑，指下滑数而有力，但却摇摆不定。
2. 数脉在一息之间，脉来超过5次以上。
3. 数脉比数脉更快，一息七八至以上，相当于每分钟140次以上。
4. 滑脉往来十分流利，圆滑流利，如圆珠反复旋转。

数脉一息脉来
超过5次以上。



数脉一息五至以上。



疾脉比数脉更快，
一息七八至以上。



滑脉往来流利，应指圆滑，如盘走珠。

(4) 主病：

动脉主里有瘀血。气滞等病证，或是主心中惊悸的症候。

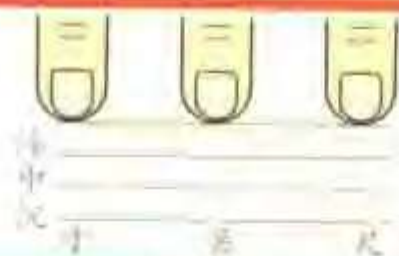


相关的原理

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	动弱	动数	动实	动滑
症状表现	惊悸	热	痛	痰湿

19. 虚脉



虚脉主虚证。

(1) 脉象：三部脉举之无力，按之空虚。



中医师解说

HEALTHFUL

虚脉无论是浮中沉取时，脉象均软弱无力，脉势细小并且有空虚感。

(2) 脉理：

1. 当体内阳气亏虚时，由于推动血液运行的力量薄弱，因此出现软弱无力的虚脉。



相关的原理

2. 当血液不足时，由于阳气没有阴液可以依附而浮越于外，此时也会出现脉管形体虚大而软的虚脉。

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

虚脉与浮脉、芤脉、濡脉、微脉类似。这些脉象的主要特点都是位于肌表浅处。



中医师解说

脉象的类别：

1. 虚脉是在轻浮中沉取弱，脉象细软无力，脉形偏小并且有空虚感。
2. 浮脉的脉形不大不小，脉势明显，重按稍减，脉体没有空虚感。
3. 芤脉的脉位浮，脉体的外形很大但中间中空，如同按在葱管上有空虚感。
4. 濡脉的脉位浮，脉形细小而柔软。
5. 散脉的脉位浮，好像没有根一般散乱，脉形细小并且至数不齐。

浮脉轻取即得，
重按稍减而不空。芤脉浮大中空，
如按葱管。

濡脉浮而细软。

散脉浮大无根，
至数不齐。

(4) 主病：

虚脉主气弱血
虚，元气亏损等的
里虚证。

相关的脉神

HEALTHFUL

★名词解释

自汗：指人体于白天时，身体不自觉地汗自出的症状。主要病因为肺气虚弱、卫气不固所致。

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象

症状表现

浮虚

气虚

表虚

自汗

沉虚

里虚

虚湿

血虚

虚数

阴虚

虚迟

虚寒

20. 微脉



微脉主气血诸虚。

(1) 脉象：极细极软，按之欲绝，似有若无。



中医师解说

HEALTHFUL

微脉出现在浮位或沉位，脉象模糊不清，若有若无，欲绝非绝。

(2) 脉理：

当体内阳气或阴液亏虚严重时，由于阳气不足以推动血液的运行，以至于血液不能充润脉管，因此出现模糊不清，若有若无，欲绝非绝的微脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



可以鉴别

HEALTHFUL

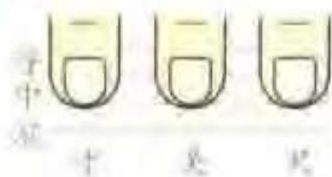
微脉与弱脉、濡脉、细脉类似，都是细软而无力。



中医师解说

脉象的差别：

1. 微脉出现或浮位或沉位，脉象模糊不清，若有若无，似有非有。
2. 弱脉在沉位。
3. 濡脉在浮位。
4. 细脉的脉形细小，初应指明显，不似微脉的脉象模糊不清。



弱脉沉而柔细，
弱脉在沉位。



濡脉浮而细软。



细脉脉细如线，
但应指明显。

(4) 主病：

微脉主虚
弱脉主虚
细脉主虚



相关的原理

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	浮微	沉微	微涩
症状表现	气衰	阴虚	亡血

21. 细脉



细脉主气血两虚，
诸虚劳损。

(1) 脉象：脉细如线，但应指明显。



中医师解说

HEALTHFUL

细脉的脉形细小，却
明显跳动，不似微脉的脉
象模糊不清，若有若无，
欲绝非绝。

(2) 脉理：

1. 当人体气血亏虚时，由于血液不能充润脉管，阳气也不足以鼓动血液，因此就会出现脉体细小而无力的细脉。
2. 当湿邪壅阻于内，或是邪热深入于营血时，也会出现细脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

HEALTHFUL

细脉与弱脉、濡脉、微脉类似，都是细软而无力。

H E A L T H Y H E L P U L



中医师解说

脉象的名称：

1. 细脉的特征细小，脉动明显，不似微脉的脉象模糊不清。
2. 弱脉在沉位。
3. 濡脉在浮位。
4. 微脉出现在浮位或沉位，脉象模糊不清，若有若无，数绝非绝。

弱脉



弱脉在沉位，
沉而柔细。

濡脉



濡脉在浮位，
濡脉浮而细软。

微脉



微脉极细极软，
似有似无，至数不明。

(4) 主病：

细脉主气血两虚，诸虚劳损的症候。细脉也可以主里有湿邪积滞；当湿邪侵袭人体，或是湿邪内困于脾胃，或是湿邪留滞于经络时，都会出现细脉。



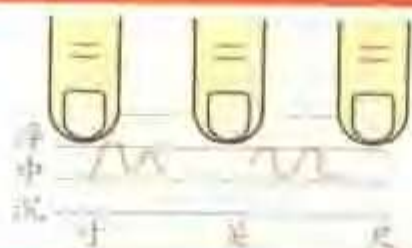
相关的原理

H E A L T H Y H E L P U L

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	细弦	细数	细涩	细微	沉细
症状表现	肝肾阴虚	阴虚或 血虚有热	血虚 或血瘀	阳虚阴盛	里虚 或湿痹

22. 代脉



代脉主脏气衰微。

(1) 脉象：脉来时见一止，止有定数，良久方来。



中医师解说

HEALTHFUL

1. 代脉的脉象为迟滞或是急数，主要依病情而定。
2. 代脉每到一定的规律就突然歇止，每次歇止的时间较长。

(2) 脉理：

1. 当人体气血亏虚，脏气衰微时，或是因为伤风证、痛极、惊恐、跌打损伤等因素，以至于脉气无法连续搏动，此时就会出现代脉。
2. 如果妇女于怀孕时出现代脉，这是因为体内的气血用于养胎的缘故。

相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

代脉与结脉、促脉类似，三者都具有突然歇止的脉象。

H E A L T H F U L

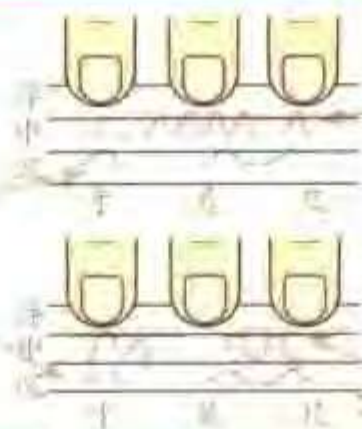


中医师解说

脉象的差别:

1. 代脉比促脉迟滞，每到一定时间就突然歇止，每次歇止的时间较长。
2. 结脉的脉象迟滞，每次歇止的间隔没有一定的规律，歇止的时间比较短暂。
3. 促脉的脉象急数，每次歇止的间隔也没有一定的规律，歇止的时间比较短暂。

结脉没有一定的歇止规律。



促脉没有一定的歇止规律。

代脉有一定的歇止规律。

(4) 主病:

1. 代脉主脏气衰微，如久泻久痢，以致脾土衰败时，就会出现代脉。
2. 其他如伤风、痛极、惊恐、跌打损伤，偶尔也会出现代脉。



相关的原理

H E A L T H F U L

(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	代而缓弱	代而兼数
症状表现	脏气衰微	伤风、痛极或惊恐

23. 短脉



短脉主气病，
短而无力主气虚证，
短而有力主气实证。

★名词解释

气虚：是指人体由于先天禀赋不足，或是重病久病而耗元气，所出现身疲乏力、少气懒言、动辄汗出、心悸等症候。

气实证：即“实证”，是指由于外邪侵袭人体，入里而化热，或是由于气滞血瘀、痰饮、食积等壅塞于胃肠，临床表现为壮热、烦渴、便秘等症候。

(1) 脉象：首尾俱短，不能满部。



中医师解说

HEALTHFUL

短脉比正常的脉象短小，脉形不超过寸关尺三部中的每一部。

(2) 脉理：

1. 短而无力：当阳气亏虚，推动血液运行的力量薄弱时，就会出现脉短而无力的短脉。

2. 短而有力：如果因为气滞、血瘀、痰饮、食积等因素，导致脉气受阻而难以升张时，此时就会出现短而有力的短脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



短脉与动脉类似，二者都具有短小的脉形。

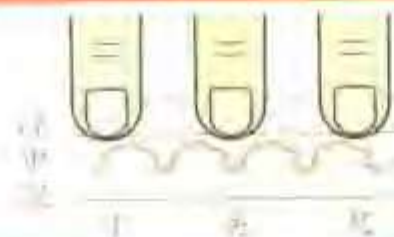
中医师解说



中医师解说

脉象的差别：

1. 短脉形体短小，不能满部。
2. 动脉如豆般圆滑，脉象滑数而有力，却幅度不定。



动脉滑数有力，
脉形如豆，掀掀动摇。

(4) 主病：

短脉主气病。

1. 短而无力：主气虚证，比如心悸、自汗、气短懒言、身疲乏力等症候。
2. 短而有力：主气实证，比如体内有气滞、血瘀、痰饮、食积等所导致的症候。



相关值原理

H E A L T H F U L

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	短而浮	短而涩	短而沉	短而迟
症状表现	肺气虚或血涩	心气虚或血涩	痞证或心脉瘀阻	虚寒

★名词解释

痞证：指胸膈腹部的闷胀不适所引起的一种病。最易有脘腹痞满的，称为“痞满”，其邪热郁滞在上焦。胸部闷塞者，简称“胸痞”。若失有痞满，则病情较重，如伴有堵闷的，称为“胸中痞硬”。

24. 实脉



★名词解释

实证：是指由于外邪侵袭人体，入里而化热，或是由于气滞血瘀，痰饮、食积等壅聚于胃肠，临床表现为壮热、烦躁、便秘等症状。

(1) 脉象：浮、中、沉三部脉举按均有力。



(2) 脉理：



(3) 鉴别：



H E A L T H F U L



脉象的差别：

1. 实脉虽然不如洪脉狂急，但不论浮取或沉取时，都极为有力，来去十分旺盛。
2. 紧脉绷急有力，如转绳索。
3. 洪脉轻取时就能感受到如波涛般汹涌，来盛去衰的脉势，沉取时反而略为虚弱。



紧脉脉来绷急，状如牵绳转索。



洪脉极大，来盛去衰。

(4) 主病：

1. 实脉主实证，凡是体内的火热实邪充盛有余时，表现为发狂谵语，或是气机壅结，便秘，或是脏腑气机不畅，三焦火盛等症候，都会出现实脉。
2. 实脉也可出现于阴寒厥冷的病证；这是因为，如果患了阴寒厥冷的病证而久病不愈，导致气弱血虚时，本应出现虚微脉，如今却反而出现实脉，此时表示为脉象与证候相反的反常脉象。
3. 正常人也会出现实脉，这是代表体内正气充足，脏腑功能良好的表现。



相关的原理

H E A L T H F U L

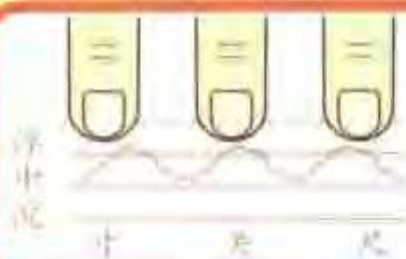
★名词解释

谵语：由于痰饮壅阻，或是邪热炽盛等因素，阻遏心脉气血的输布，表现为神志不清，低声细语，重复语句的症状。

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	浮实	沉实	洪实	滑实
症状表现	表邪实	里邪实、胀满、闭结、积滞	实热	痰凝

25. 长脉



长脉主阳证，如肝阳有余，
或阳盛内热之证。

★名词解释

肝阳：肝与肝阳皆为肝的重要组成，肝阳在某种意义上，涵盖了肝气的成分，具有温煦气脉、温通经脉的作用。

(1) 脉象：首尾端长，超过本位。



中医师解说

HEALTHFUL

长脉比正常脉象长直，脉形远远超过寸关尺三部的每一部。

(2) 脉理：

长脉有两种形态：

1. 正常人的长脉表现为脉气畅通，脉象长而柔缓，此时称为平脉（正常脉）。
2. 如果体内的肝阳亢盛有余，或是阳盛而内热时，邪气与正气会相互搏击，此时就会出现脉象长直而强硬的长脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

长脉与弦脉类似，二者的脉象都显得直直长长。

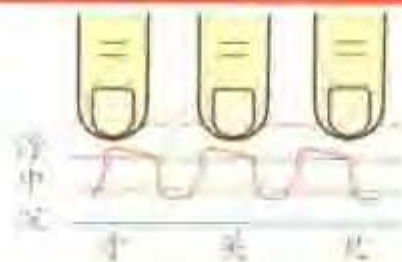
HEALTHFUL



中医师解说

脉象的差别：

1. 长脉超过本位，远远超过寸关尺三部的每一部。
2. 弦脉的脉管如同绷紧的琴弦，虽然缺少圆滑的流畅感，却不超过本位。



弦脉端直而长，
如按琴弦。

(4) 主病：

长脉主阳证，比如体内的肝阳亢盛有余，或是阳气偏盛所引起的内热蕴积等症候，都会出现长脉。



相关的原理

HEALTHFUL

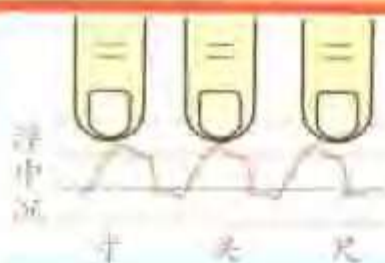
(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	长弦	长洪有力	长实	长滑	长而沉细
症状表现	肝病	阳明热盛	邪气内结	痰热壅盛	积聚

★名词解释

阳明热盛：阳明即十二正经中的阳明经，阳明热盛，指的是胃腑热盛。

26. 滑脉



滑脉主痰饮、宿食、
实热、蓄血。

★名词解释

蓄血证：主要病因为邪热入里，与血相搏，瘀血与邪热阻于少腹，上扰于心神所致。表现为身热，烦躁不安，发狂，少腹硬满急结，瘀血结等症候。

(1) 脉象：往来流利，如珠子在盘中滑，跳动圆滑。



中医师解说

HEALTHFUL

滑脉跳动圆滑如珠，
搏动较其流利，给人一种
反复滑动、圆滑自如的感
觉。

(2) 脉理：

1. 当体内邪气壅盛时，如果人体的正气并不因此而衰减，邪气与正气相互搏击，以至于气机实盛而血脉奔涌，因此脉象表现为往来极为流利，指下圆滑流畅。
2. 当正常人出现滑脉时，脉象必定表现为滑而和缓，这是由于气血充盛，血脉流畅，因此脉来滑而和缓。
3. 如果妇女于怀孕时出现滑脉，则是体内气血充盛且调和的表现。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

滑脉与数脉类似，二者的脉率都比较快。

HEALTHFUL

HEALTHY



中医师解说

脉象的鉴别：

1. 滑脉往来十分流畅，脉形圆滑流利，如圆珠般反复旋转。
2. 数脉在一息之间，脉率超过5次以上。



数脉主热，
数脉亦主虚证。

(4) 主病：

滑脉主痰饮、宿食、实热、蓄血。

1. 凡是痰涎壅滞于肺，以至于喘咳气逆、痰鸣；或是宿食停滞，以至于腹胀、便秘；或是邪热内蕴于体内，以至于产生发热或热厥，或是湿热下注，以至于小便涩痛，下焦蓄血等症候，都会出现滑脉。
2. 滑脉亦主元气虚衰，这是因为当人体气血衰微时，剩余的气血仍然会留连脏腑经络之间，此时气血虚衰至极却反而出现滑脉，表示体内元气外泄的症候。



相关的原理

HEALTHY

★名词解释

热厥：为外邪入里化热，或是里热炽盛，致使气机梗阻，所引起蒙闭心神的症状。主要表现为突然昏倒，不省人事，四肢厥冷等症候。

(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	浮滑	沉滑	滑数	滑弦
症状表现	风痰	痰食	痰火或为湿热, 或为热盛	痰聚

★名词解释

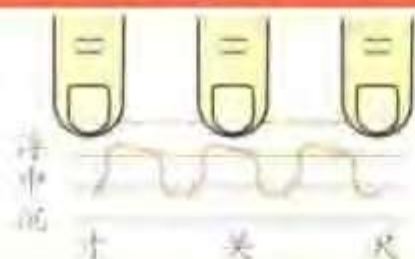
风痰: 指风邪与痰浊相结合而侵入人体的病邪。

痰食: 痰浊与食积相互结聚而为病。

痰火: 痰浊与火热之邪相互结聚而为病。

痰聚: 痰浊结聚体内而为病。

27. 弦脉



弦脉主肝胆病，主痰饮，
主诸痛，主疟疾；弦脉亦主虚。

(1) 脉象：端直而长，如按琴弦。



中医师解说

HEALTHFUL

弦脉形直体长，弛张度较大，若以琴弦为别，则鸣咽紧之后，弦的紧张度便增加了。弦脉不受脉位、气息至数所限制，既可兼浮兼沉，又可兼迟兼数。

(2) 脉理：

弦脉是脉气紧张的表现。

1. 肝的功能主要为疏泄与调畅气机，本应以柔和为贵，如果因为邪气壅滞于体内，以至于肝的疏泄功能失常，气机壅塞不畅时，就会出现弦脉。
2. 如果是因里有瘀血痛证，或是痰饮壅结，导致气机阻滞，阴阳不和时，脉气因而紧张不畅，此时也会出现弦脉。



相关的脉理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：

HEALTHFUL



中医师解说

弦脉与紧脉类似，二者脉气均紧张。

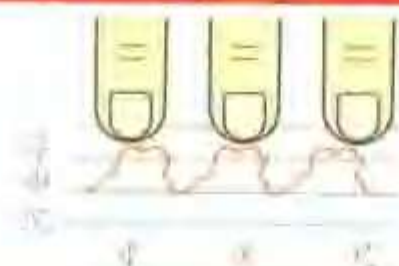


中医师解说

H E A L T H F U L

脉象的差别：

1. 弦脉端直而长，如按在琴弦上，无弛急之势。
2. 紧脉如按在绷紧的绳索上，脉绷急有力。



紧脉脉来绷急，
状如牵绳转索。

(4) 主病：

1. 弦脉主肝胆实证。比如气机上逆于头面所引起的眩目头痛，或是胸胁疼痛，四肢拘急等症候。
2. 弦脉主痰饮。比如喘满咳逆，心悸短气等症候。
3. 弦脉主诸痛。比如脘腹胀痛，寒疝疼痛，痹证疼痛等症候。
4. 主疟疾。凡是疟疾发病时，所引起的寒热交替，或是少阳病证等症候。
5. 弦脉亦主虚证，当体内气弱血虚，元气不足时，也会出现弦脉。



相关的原理

H E A L T H F U L

★名词解释

痹证：为风寒湿三邪气侵袭人体的筋脉或经络而引起的病症，主要症状为关节或肌肉肿胀，疼痛等症状。类似于风湿关节炎或类风湿关节炎等病。

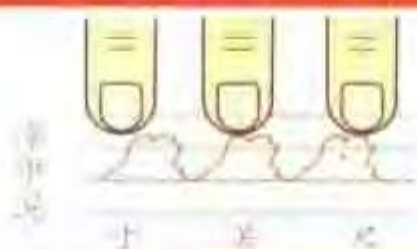
(5) 兼脉主病:

兼脉脉象	弦数	弦迟	弦紧	弦细	浮弦	弦滑	弦大无力
症状表现	肝胆实火	虚寒	诸痛 或疝气	拘急	支饮 风邪头痛	痰饮	虚证

★名词解释

支饮：指水湿或痰饮停留于胸膈胃脘等部位所引起的病症，主要症状为咳嗽、气喘、呼吸气短、胸膈满闷等症状，严重时甚至会导致身体浮肿。

28. 紧脉



紧脉主寒，主痛，主宿食。

(1) 脉象：脉来绷急，状若牵绳转索。



中医师解说

HEALTHFUL

紧脉的脉形紧张而有力，如同拉紧的绳索般弹指而绞转不定。

(2) 脉理：

当寒邪侵袭人体后，由于寒邪的特性为收引凝滞，以至于导致脉管紧缩而拘急，因此出现脉来绷急的紧脉。



相关的原理

HEALTHFUL

(3) 鉴别：



中医师解说

HEALTHFUL

紧脉与弦脉类似，二者的脉象都很紧张。

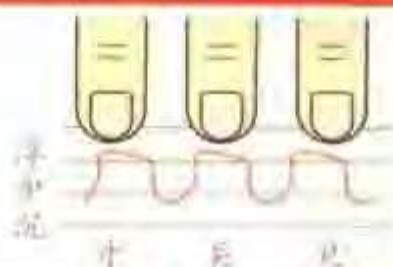
HEALTHFUL



中医师解说

脉象的鉴别：

1. 紧脉的脉形紧张而有力，如同拉紧的绳索般弹指而较转不定。
2. 弦脉如同绷紧的琴弦，虽然缺少圆滑的流畅感，却不像紧脉弹指而较转不定。



弦脉端直而长，
如按琴弦。

(4) 主病：

1. 紧脉主寒证。
2. 紧脉主痛证，主要是由于寒邪所引起的痛证。
3. 紧脉主宿食积滞，比如腹中有宿食不化。



相关的原理

HEALTHFUL

(5) 兼脉主病：

兼脉脉象	浮紧	沉紧	紧弦
症状表现	表寒实证	里寒或痰饮宿食	主痛或疟病

三、实例说明



中医师解说

中国认为所有疾病的病因，不外是六淫（风、寒、暑、湿、燥、火）与七情（喜、怒、忧、思、悲、恐、惊），以及外伤、瘀血、误饮、食积与房室所伤等病因，但是由于疾病在传变的过程中，病证存在有表与里、虚与实、寒与热的区别，因此，即使不同的病人同时患上相同的病证，但其所表现出来的脉象亦不见得会完全相同，因此初学者于临床辨证时，不可不慎。

举个例来说，就以外感发热的症状为例，虽然同样为发热，但是，如果体质较虚的病人出现的发热，大都属于表虚证，脉象应表现为浮缓脉或浮弱脉；如果是体质较实的病人出现的发热，则大都属于表实证，脉象则表现为浮紧脉或浮数脉。



中医师解说

再以慢性肝炎为例，如果是体质较实的病人患上慢性肝炎，则大都属于肝郁气滞的实证，此时的脉象表现为弦脉；但是，如果因为慢性肝炎拖延日久而不愈，以至于导致气弱血虚，或是损伤脾肾的元阳，则病情将会传变为寒湿阻中的虚实夹杂证，脉象则表现为沉弦脉或沉迟脉。

肝郁气滞之实证

寒湿阻中的虚实夹杂证



弦脉

沉弦脉或沉迟脉

慢性肝炎之脉象



中医师解说

学者的印象。

本篇列举临床常见的病证，用来说明各种脉象的变化，以加深初学者的印象。

(1) 头身发热

类型1: 风寒表虚之“头身发热虚证”

证候: 发热恶寒, 头痛, 汗出恶风, 舌淡, 苔白, 脉浮缓或浮弱。

类型2: 风寒表实之“头身发热实证”

证候: 发热, 恶寒, 头痛, 无汗, 身疼骨痛, 舌淡, 苔白, 脉浮紧或浮数。

类型3: 实热内结之“头身发热实证”

证候: 脘腹胀满, 大便不通, 潮热谵语, 舌苔焦黄起刺, 舌红, 苔黄干焦, 脉沉迟有力。

类型4: 肝郁气滞之“头身发热实证”

证候: 肋肋疼痛, 寒热往来, 暖气太息, 脘腹胀满, 苔黄, 脉弦。

类型5: 脾虚水停之“头身发热虚证”

证候: 眩晕, 喘咳, 心悸, 心下逆满, 便溏纳呆, 舌淡白胖大, 齿痕明显, 苔白滑而腻, 脉沉紧或沉弦。

类型6: 阳虚感寒之“头身发热虚证”

证候: 发热, 恶寒, 无汗, 头痛, 肢体酸痛, 舌淡, 苔白, 脉沉弱。

(2) 咳嗽

类型1: 痰热壅肺之“咳嗽实证”

证候: 咳嗽, 喘咳气粗, 痰黄稠黏, 发热或无热, 舌质稍红, 苔黄或黄略干, 脉滑数。

类型2: 脾虚水停之“咳嗽虚证”

证候: 眩晕, 喘咳, 心悸, 心下逆满, 便溏纳呆, 舌淡白胖大, 齿痕明显, 苔白滑而腻, 脉沉紧或沉弦。

类型3: 湿邪阻肺之“咳嗽实证”

证候: 头痛目眩, 咳嗽喘促, 胸背疼痛, 干呕, 舌淡, 苔白腻, 脉沉紧。

(3) 支气管炎

类型1: 痰热壅肺之“支气管炎实证”

证候: 面色晦暗, 口唇紫暗, 胸痛气喘, 咳嗽剧烈甚则不得平卧, 痰黏稠或黄或白, 舌质红, 苔黄, 脉滑数。

类型2: 肝郁气滞之“支气管炎实证”

证候: 胸胁苦满, 心烦易怒, 眩晕耳鸣, 口干便燥, 小便短赤, 舌红, 苔黄, 脉弦数。

类型3: 寒饮阻肺之“支气管炎虚证”

证候: 头痛, 咳嗽喘息, 甚则不得平卧, 昼轻夜甚, 胸闷心悸, 痰多稀白, 舌淡苔白或滑腻, 脉浮滑或沉紧。

(4) 高血压

类型1: 虚寒内盛, 痰浊上逆之“高血压虚证”

证候: 头痛(巅顶尤甚), 烦躁, 手足厥冷, 干呕或吐涎沫, 舌淡白胖大, 齿痕, 苔白滑而腻, 脉沉弦或沉迟。

类型2: 肝郁胆滞, 气机失调之“高血压实证”

证候: 胸胁苦满, 心烦易怒, 眩晕耳鸣, 口干便燥, 小便短赤, 舌红, 苔黄, 脉弦数。

(5) 心脏病

类型1: 水气凌心之“心脏病虚实夹杂证”

证候: 胸闷隐痛或胸背剧痛, 心悸, 目眩, 舌体淡白胖大, 齿痕明显, 苔白润, 脉沉紧或弦。

类型2: 肾阳虚衰, 寒水上泛之“心脏病虚证”

证候: 眩晕, 心悸, 胸痛彻背, 形寒肢冷, 舌淡白润, 苔白滑, 脉沉微或结代。

类型3: 痰热互结, 心阳被遏之“心脏病实证”

证候: 胸脘痞满, 痰鸣心悸, 便秘, 舌尖红, 苔黄腻, 脉弦滑或弦数。

类型4: 气血不足, 阴阳两虚之“心脏病虚证”

证候: 胸闷而痛, 心悸, 少气乏力, 舌淡白, 苔白润, 脉结代。

(6) 胃溃疡

类型1: 肝胃阴虚之“胃溃疡虚证”

证候: 口燥咽干, 胃脘胀痛, 四肢拘急而痛, 大便燥结, 舌尖红嫩, 欠润, 脉弦细。

类型2: 脾胃虚寒之“胃溃疡虚证”

证候: 胸脘痞满胀痛, 喜按喜温, 泛吐清水, 口淡纳呆, 手足不温, 大便溏烂, 舌质淡白, 舌胖大而有齿痕, 苔白润略腻, 脉缓弱。

类型3: 寒热夹杂之“胃溃疡虚实夹杂证”

证候: 呕吐, 胃脘痞满或胀痛, 嘈杂泛酸, 饥不欲食, 肠鸣下利, 舌淡而胖大, 苔白腻或黄白腻, 脉沉或细弱或弦细。

(7) 肝硬化

类型1: 肝郁湿阻之“肝硬化虚实夹杂证”

证候: 头晕目眩, 心烦易怒, 胁肋疼痛, 胸膈痞满, 纳食减少, 食后作胀, 小便短赤, 苔白滑, 脉弦。

类型2: 湿热内蕴之“肝硬化实证”

证候: 恶心呕吐, 发热口渴, 身目发黄如橘子色, 腹部胀满, 尿少色黄, 大便秘结, 舌边尖红, 舌苔黄腻, 脉弦滑数。

类型3: 水饮停结之“肝硬化虚实夹杂证”

证候: 胸胁闷痛, 腹大痞满, 食后腹胀加重, 恶心呕吐, 呼吸气短, 小便短赤, 舌苔白滑, 脉沉弦。

(8) 慢性肝炎

类型1: 肝郁气滞之“慢性肝炎实证”

证候: 口苦, 胁肋胀痛, 肝脏肿大, 脘痞腹胀, 舌苔白黄, 脉弦。

类型2: 寒湿阻中之“慢性肝炎虚实夹杂证”

证候: 身黄晦暗, 色如烟熏, 纳少脘闷, 畏寒肢冷, 大便溏泄, 尿黄, 舌淡, 苔白滑, 脉沉弦或沉迟。

(9) 糖尿病

类型1: 胃热炽盛之“糖尿病实证”

证候: 大渴引饮, 多食易饥, 汗出, 小便色赤, 心烦, 舌红苔黄燥, 脉洪大或滑数。

类型2: 阴液亏损之“糖尿病虚证”

证候: 口渴多饮, 咽干, 烦躁, 四肢拘挛, 疼痛, 大便干, 小便短少, 舌红干苔少, 脉弦细或细数无力。

类型3: 湿热互结之“糖尿病虚实夹杂证”

证候: 口渴多饮, 多食易饥, 心烦不得眠, 小便不利, 下利, 舌红少苔或无苔, 脉浮数或细数。

类型4: 里热痞聚之“糖尿病实证”

证候: 烦渴引饮, 口干舌燥, 多食易饥, 潮热汗出, 腹满胀痛, 大便秘结, 小便短赤, 舌质红, 苔黄干或焦躁起刺, 脉滑数或沉实有力。

类型5: 血瘀胃热之“糖尿病实证”

证候: 口渴, 但饮水不多, 疲乏无力, 四肢麻痺, 大便硬或秘结不通, 舌质紫黯, 苔薄黄或白, 脉弦滑或沉细。

(10) 慢性肾炎

类型1: 肾虚湿郁, 水热互结之“慢性肾炎虚实夹杂证”

证候: 头晕耳鸣, 腰膝酸软, 面浮足肿, 小便频数, 欲出不尽, 入夜为甚, 低热, 或五心烦热, 舌红少苔或舌淡苔, 脉弦细而数。

类型2: 下焦湿热, 水蓄膀胱之“慢性肾炎实证”

证候: 口渴, 发热畏寒, 尿频, 尿急, 尿痛或淋沥不尽, 少腹胀痛, 腰酸痛, 苔薄黄, 脉濡数或滑数。

(11) 坐骨神经痛

类型1: 久痹入络之“坐骨神经痛虚证”

证候: 腰腿疼痛迁延不愈, 肌肉渐消, 麻木不仁, 屈伸不利, 行动艰难, 疲乏无力, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。

类型2: 寒湿侵袭之“坐骨神经痛实证”

证候: 腰腿疼痛僵硬, 屈伸不利, 遇冷痛增, 得热则缓, 苔薄白, 脉弦紧。

类型3: 痰湿凝滞之“坐骨神经痛实证”

证候: 腰痛固定不移, 入夜尤重, 麻木不仁, 腰腿困重, 苔厚腻, 脉迟涩或滑。

(12) 妇女痛经

类型1: 肝郁气滞之“妇女痛经实证”

证候: 经前或经期有小腹胀痛, 经量少或经行不畅, 胸胁胀闷, 善叹息, 经前烦躁易怒, 乳房作胀, 舌质暗滞, 苔白, 脉弦。

类型2: 瘀血内阻之“妇女痛经实证”

证候: 经前或经期小腹硬痛拒按, 经色紫暗, 内挟瘀块, 血块排出后痛减, 面色黧黑, 甚或肌肤甲错, 舌质青紫瘀斑, 或舌下静脉粗黑, 苔薄白, 脉沉涩或脉沉结。

类型3: 血虚寒凝之“妇女痛经虚证”

证候: 经前或经行小腹疼痛, 喜温喜按, 经量少, 色淡, 痛时手足冷, 或麻木不仁, 舌质淡, 苔白, 脉沉细迟。

(13) 妇女带下

类型1: 阳虚湿盛之“妇女带下虚证”

证候: 白带稀薄, 清冷量多, 淋漓不断, 腰痛如折, 小腹冷痛, 小便频数清长, 大便溏泄, 舌质淡, 苔白润或白滑, 脉沉迟弱。

类型2: 湿热内盛之“妇女带下实证”

证候: 带下粘腻腥臭, 色黄或黄白相兼, 胸闷, 口腻, 纳呆, 或小腹隐痛绵绵, 小便短赤, 舌质红, 苔黄腻, 脉濡数。

(14) 更年期综合征

类型1: 阴阳虚损之“更年期综合征虚证”

证候: 绝经前后, 发热汗出, 头晕耳鸣, 烦躁, 失眠, 腰膝酸软, 四肢冷, 舌淡, 苔薄白, 脉沉细。

类型2: 肝肾阴虚之“更年期综合征虚证”

证候: 绝经前后, 腰膝酸软, 午后潮热, 手足心热, 胸肋满闷, 烦躁失眠, 口苦咽干, 或月经紊乱, 量稀少, 舌红, 苔少, 脉弦细数。

★名词解释

【1】虚证: 指的是正气虚损所出现的临床病证, 当外邪亢盛时, 如果正气已经虚衰, 不足以抵抗邪气, 这时就称为“虚”证。虚证的形成, 主要病因为先天不足, 后天失养与疾病耗损等有关。

临床常见虚证的症状为: 面色苍白, 精神萎靡, 身疲乏力, 形寒肢冷, 大便滑脱, 小便失禁, 舌淡胖嫩, 脉虚沉迟, 或为五心烦热, 口咽干燥, 盗汗潮热, 舌红少苔, 脉虚细数。

【2】实证: 指的是外邪侵袭, 或体内病理产物堆积所形成的临床病证, 当外邪亢盛时, 如果正气仍未虚衰, 正气与邪气相互斗争, 这时就称为“实”证。

实证的形成, 主要病因为外邪侵袭, 或是脏腑功能失调导致痰饮、水湿、瘀血等病理产物停滞等有关。

临床常见实证的症状为: 发热, 烦躁, 甚至神昏谵语, 呼吸气粗, 痰涎壅盛, 腹胀满拒按, 大便秘结, 或下利, 里急后重, 小便不利, 淋沥涩痛, 舌苔厚腻, 脉实有力。

【3】虚实错杂: 疾病发展的过程中, 由于受到体质差异与病邪传变途径的不同等因素所影响, 虚证与实证常会出现虚实转化与虚实错杂等证候。如果不加以细察, 就容易误诊。

虚实错杂的证候又可以分为虚证夹实、实证夹虚、虚实并重三种。

虚证夹实: 病证的特点主要是以正气虚损为主要的病因, 而兼有实邪侵扰的证候。

实证夹虚: 病证的特点主要是以实邪侵扰为主要的病因, 而兼有正气虚损的证候。

虚实并重: 病证的特点为正气虚损与实邪侵扰均十分明显, 因此病情比较沉重。

【4】表虚: 是指由于人体的阳气(卫气)不足, 不能护卫肌表腠理, 因而出现在除了表证的症状之外, 特别是以自汗或汗出恶风、脉缓无力为表虚症状的特点。

【5】卫气: 卫气是人体阳气的一部分, 具有保卫肌表, 抗御外邪的作用。

1. 头身发热

类型1: 风寒表虚之“头身发热虚证”

证候: 发热恶寒, 头痛, 汗出恶风, 舌淡, 苔白, 脉浮缓或浮弱。

发热
卫气与邪气于体内互相搏击, 邪气欲寻找出路却无路可出, 因此传变为热邪而出。

恶寒
寒邪侵犯人体的肌表, 损伤卫气对于肌表的温煦作用。

浮脉主表证 | 脉必浮而有力 | 也可见于风水。

头痛
头面的经脉遭受寒邪的侵袭, 导致气血瘀阻不通, 气血不通则产生疼痛。

汗出恶风
当人体出汗时, 卫气也会随着汗液而溢出体外, 卫气不能起到温煦肌表的作用, 因而恶风。

脉浮缓或浮弱。

缓脉主湿, 或主脾虚。



弱脉主气血亏虚。



中医师解说

分析:
浮脉轻取即得, 重按稍减而不空。
缓脉比迟脉稍快, 一息四至, 脉来怠慢。
弱脉沉而柔细。

类型2: 风寒表实之“头身发热实证”

证候: 发热, 恶寒, 头痛, 无汗, 身疼骨痛, 舌淡, 苔白, 脉浮紧或浮数。

发热:

卫气与邪气于体内互相搏击, 邪气欲寻找出路却无路可出, 因此传变为热邪而出。

头痛

头面的经脉遭受寒邪的侵袭, 导致气血瘀阻不通, 气血不通则产生疼痛。

恶寒:

寒邪侵犯人体的肌表, 损伤卫气对于肌表的温煦作用。

身疼骨痛

全身经脉遭受寒邪的侵袭, 导致气血瘀阻不通, 气血不通则身疼骨痛。

无汗

风寒之邪束缚于人体的肌表, 阻遏气机的正常宣发, 腠理也因而闭塞不通, 以至于汗液难以释出, 因此无汗可出。

脉浮紧或浮数。

紧脉主寒, 主痛, 主宿食。

浮脉主表证(脉必浮而有力)也可见于风水。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

分析:

浮脉轻取而得, 重按稍减而不空; 紧脉脉来绷急, 状如牵绳转索; 数脉一息五至以上。

★名词解释

表实: 是指由于外邪侵袭人体后, 邪气与人体正气于肌表腠理间相互搏击, 因而出现除了表证的症状, 特别是以无汗、头痛、身痛、脉浮有力为表实症状的特点。

类型3：实热内结之“头身发热实证”

证候：脘腹痞满，大便不通，潮热谵语，舌苔焦黄起刺，舌红，苔黄干焦，脉沉迟有力。

脘腹痞满
痞满或食积等郁结于胃肠，阻遏胃肠气机的升降，因此脘腹痞满。

大便不通
痰浊或食积等久瘀难消而化生为热，当热邪蕴阻于肠道时，容易阻遏肠道气机，甚至会灼伤肠道津液，以至于肠道传导失常，大便不通。

舌苔焦黄起刺
当体内的热邪炽盛时，热邪不仅会耗伤津液，使得舌苔焦黄，严重时，如果热邪欲传变从舌体而出，则会导致舌苔起刺。

潮热谵语
由于体内的积滞郁久而化生为热，当正气与热邪相互搏击时，如果热邪损伤阴液，导致阴液亏损，则热邪没有阴液可以依附而传变为潮热。如果热邪壅塞于心室，扰乱心神，则产生谵语。

沉脉主里证，沉而有力为里实，沉而无力为里虚。



迟脉主寒证
迟而有力为寒实证（注：或为实热证），迟而无力为虚寒证。



中医师解说

分析：
沉脉轻取不应，重按始得；迟脉来去迟慢，一息三至。

★名词解释

实热：是指由于外邪侵袭人体，入里而化热，此时由于邪气亢盛而人体的正气亦充足，邪气与正气相互搏击，因而引起的发热症状，临床表现为高热、口渴、烦躁、口苦、便秘、舌苔厚黄、干燥或起芒刺，脉洪数有力等。

潮热：指人体每天到了一定时候，就会如潮水般定时产生发热。

潮热的病因可以分为三种类型：

阴虚潮热：因体内的阴液亏虚不足，每于入夜时产生发热且伴有盗汗。

湿温潮热：因阳气受湿邪所阻遏，通常于下午时产生发热。

日晡潮热：因热邪结聚于肠道，亦可于每天产生发热。

谵语：由于痰饮壅阻，或是邪热炽盛等因素，阻遏心脉气血的输布，表现为神志不清，低声细语，重复语句的症状。

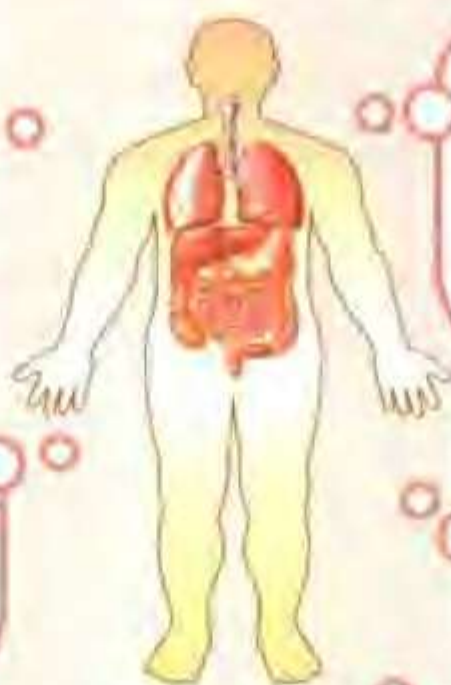
痞证：指胸膈脘腹的气机阻塞不舒所引起的症状。若兼有胀满感觉的，称为“痞满”；邪热阻滞在上焦，胸部痞塞者，简称为“胸痞”；若夹有痰湿，胸痞程度较严重，如有物堵住的，称为“胸中痞硬”。

类型4: 肝郁气滞之“头身发热实证”

证候: 胁肋疼痛, 寒热往来, 暖气太息, 脘腹胀满, 苔黄, 脉弦。

胁肋疼痛: 肝经循行经过胁肋的部位, 如果经脉的气血瘀阻不通, 肝气不畅, 则会导致胁肋疼痛。

脘腹胀满: 肝经循行通过少腹的部位, 如果肝经的气血瘀阻不通, 则脘腹的气机亦同样运行不畅, 因而脘腹胀满。



寒热往来

通常是属于少阳病正邪相争所出现的症状。当发作时, 患者产生恶寒时则不发热、发热时则不产生恶寒, 因此恶寒与发热交替出现, 定时或不定地发作。

暖气: 由于肝胃不和, 肝气郁结或是食积等因素所引起的气机不畅时, 表现为胃中似有气体上冲, 略有声响, 但与频频作呃的呃逆不同。

太息: 由于肺气不宣或是肝气郁结等因素所引起的气机不畅时, 表现为频频叹气, 称为“善太息”。



弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦。

★名词解释

肝郁气滞: 肝的功能为疏泄与调畅气机, 如果因情志不舒, 恼怒伤肝, 或是因其他因素影响气机正常的升发和疏泄, 就会引起肝郁的病证。表现为胁肋胀痛、呃逆、吐酸水、食欲不振、月经不调等症状。

类型5: 脾虚水停之“失身发热虚证”

证候: 眩暈, 喘咳, 心悸, 心下逆满, 便溏纳呆, 舌淡白胖大, 齿痕明显, 苔白滑而腻, 脉沉紧或沉弦。

眩暈

水饮或湿邪蒙闭于头目清窍, 阻遏清阳气机的升降, 因而导致眩暈的产生。

喘咳

当痰浊随着气机的升降而运行。虽欲出却不能出, 此时则会产生喘咳。

脉沉紧或沉弦。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。

心悸

水饮或湿邪侵犯于心, 阻遏气血正常的运行, 因而产生心悸。

心下逆满

当水饮停滞于胃口, 阻遏胃腑气机的升降, 以至于胃气上逆, 因而心下逆满。

便溏纳呆

由于脾气虚损, 不能正常运化水湿, 以至于水湿停聚于胃腑, 因此腹满而纳呆。如果水湿下注于肠道, 则会引起大便溏泄。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾。弦脉亦主虚。

紧脉主寒, 主痛, 主宿食。



中医师解说

分析:

沉脉轻取不应, 重按始得; 弦脉脉来端直而长, 状如牵绳转索; 紧脉脉直而长, 如转绳索。

类型6: 阳虚感寒之“头身发热虚证”

证候: 发热, 恶寒, 无汗, 头痛, 肢体酸痛, 舌淡, 苔白, 脉沉弱。

发热
卫气与邪气于体内互相搏击, 邪气欲寻找出路却无路可出, 因此传变为热邪而出。

恶寒
寒邪侵犯人体的肌表, 损伤卫气对于肌表的温解作用。

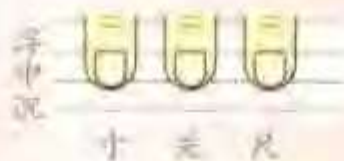


无汗
风寒之邪束缚于人体的肌表, 阻遏体内气机的正常宣发, 腠理也因此闭塞不通, 导致汗液难以释出, 因此无汗可出。

头痛
头面的经脉遭受寒邪的侵袭, 导致气血瘀阻不通, 气血不通则产生疼痛。

肢体酸痛
寒邪束缚四肢肌表, 阻滞经脉气血运行, 造成经脉瘀阻, 不通则痛。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。



弱脉主气血亏虚。



中医师解说

分析:
沉脉轻取不显, 重按始得, 因脉沉而柔细。

2. 咳嗽

类型1: 痰热壅肺之“咳嗽实证”

证候: 咳嗽, 喘咳气粗, 痰黄稠黏, 发热或无热, 舌质稍红, 苔黄或黄略干, 脉滑数。

咳嗽

痰浊与邪热壅阻于肺, 阻碍气机的正常升降, 因而咳嗽。

喘咳气粗

痰浊随着气机的升降而运行, 虽欲出却不能出, 因而喘咳而气粗。

脉滑数。

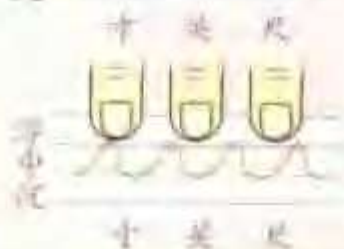
痰黄稠黏

邪热灼伤津液, 津液亏损不足, 因而痰黄稠黏。

发热或无热。

当邪热与卫气相互搏击时, 如果邪热能外透于肌表则产生发热; 如果此时因腠理紧闭, 邪热不易外透于肌表, 则不会产生发热。

滑脉主痰饮, 宿食, 实热, 蓄血。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

分析:

滑脉往来流利, 应指圆滑, 似走珠; 数脉一息五至以上。

★名词解释

痰热: 痰浊与邪热相互结合而为病。

类型2: 脾虚水停之“咳嗽虚证”

证候: 眩晕, 喘咳, 心悸, 心下逆满, 便溏纳呆, 舌淡白胖大, 齿痕明显, 苔白滑而腻, 脉沉紧或沉弦。

眩晕
水饮或湿邪蒙闭于头目清窍, 阻遏清阳气机的升降, 因而导致眩晕的产生。

喘咳
当痰浊随着气机的升降而运行, 虽欲出却不能出, 此时则会产生喘咳。

脉沉紧或沉弦。

心悸
水饮或湿邪侵犯于心, 阻遏气血正常的运行, 则会产生心悸。

心下逆满
指水饮停聚于中焦所引起的症状。表现为胃脘痞闷胀满, 胃气上逆的症状。

便溏
由于脾气虚损, 或肾阳不足所致, 泻下的粪便为清稀垢秽的成分。
纳呆
又称为“胃呆”。主要病因为胃的受纳与降浊的功能呆滞, 主要表现为消化不良, 食欲不振等症状。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。



弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。

紧脉主寒, 主痛, 主宿食。



中医师解说

分析
沉脉轻取不应, 重按始得; 紧脉脉来绷急, 状如牵绳转索; 弦脉端直而长, 沉按者弦。

类型3: 湿邪阻肺之“咳嗽实证”

证候: 头痛目眩, 咳嗽喘促, 胸背疼痛, 干呕, 舌淡, 苔白腻, 脉沉紧。

病因: 由于湿浊壅滞于体内, 阻遏肺气的正常宣发, 因而咳嗽。

头痛目眩

水饮或湿邪蒙闭于头目清窍, 容易阻遏清阳气机的升降, 因而导致目眩头痛的产生。

胸背疼痛

水饮停滞于胸胁, 阻遏经络气血的运行, 因而胸胁疼痛。

咳嗽喘促

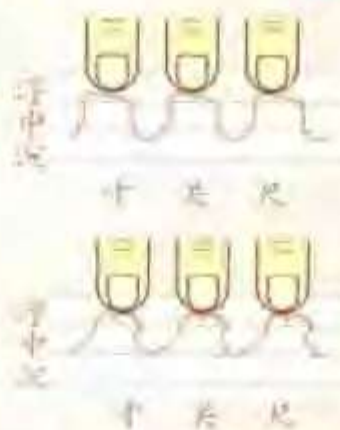
湿邪壅阻于肺, 阻碍气机正常的升降, 因而咳嗽喘促。

干呕

水饮停滞于胃脘, 扰乱脾胃气机的升降与降浊, 以至于胃气上逆, 因而呕吐。

脉沉紧。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。



紧脉主寒, 主痛, 主宿食。



中医师解说

脉象轻取不显, 重按始得; 紧脉脉来绷急, 状如牵绳转索。

分析: 沉脉轻取不显, 重按始得; 紧脉脉来绷急, 状如牵绳转索。

3. 支气管炎

类型1: 痰热壅肺之“支气管炎实证”

证候: 面色晦暗, 口唇紫暗, 胸痛气喘, 咳嗽剧烈甚则不得平卧, 痰黏稠或黄或白, 舌质红, 苔黄, 脉滑数。

反复咳嗽甚则不得平卧
痰浊与邪热相互壅阻于肺, 阻碍肺气正常的肃降, 因而咳嗽。

痰黏稠或黄或白
邪热灼伤津液, 津液亏损不足, 因而痰黏而稠。当邪热深时则色黄, 当邪热浅时则色白。

胸痛气喘
痰浊停聚于胸膈, 气血不畅, 因而胸痛。如果痰浊随着气机的升降而运行, 虽欲出却不能出, 此时则会产生喘咳而气粗。

面色晦暗, 口唇紫暗
痰浊阻滞经络, 以至于气滞血瘀, 气血不能正常上荣于头面, 因而面色晦暗, 口唇紫暗。

脉滑数。

滑脉主痰饮, 宿食, 实热, 蓄血。



数脉主热, 数脉亦主虚证



中医师解说

分期:
滑脉旺象满利, 促接圆滑, 如急走珠, 如珠一串五至以上。

类型2: 肝郁气滞之“支气管炎实证”

证候: 胸胁苦满, 心烦易怒, 眩晕耳鸣, 口干便燥, 小便短赤, 舌红, 苔黄, 脉弦数。

胸胁苦满
由于肝郁胆滞, 气机失调, 以至于胆气上泛于胸膈, 因而胸胁苦满。

心烦易怒
由于邪热内蕴于里, 扰乱心神, 因而心烦; 如果肝的疏泄失司, 肝气不畅, 则容易动怒。

眩晕耳鸣
由于邪热壅阻于内, 邪热循着经脉上扰, 蒙闭于头面的清窍, 影响气机正常的升降, 因而眩晕耳鸣。

小便短赤
由于邪热壅阻于内, 邪热欲由下焦而出, 因而小便短赤。

脉弦数。

口干便燥
由于邪热耗伤津液, 津液亏损不足则口干; 肠道没有津液的濡润, 因而大便干燥。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦, 越脉一息五至以上。

类型3: 寒饮阻肺之“支气管炎虚证”

证候: 头痛, 咳嗽喘息, 甚则不得平卧, 昼轻夜甚, 胸闷心悸, 痰多稀白。舌淡苔白或滑腻, 脉浮滑或沉紧。

头痛

寒邪或水饮凝滞经络的气血, 蒙闭头面的清窍, 阻遏清阳的正常升降, 因而头痛。

咳嗽喘息

寒饮壅阻于肺, 阻碍气机的正常升降, 因而咳嗽。当痰饮随着气机的升降而运行, 虽欲出而不能出, 则喘息。

浮脉主表证(脉必浮而有力); 也可见于风水。

咳嗽喘息……昼轻夜甚

白天阳气充足, 阳气充足则能胜过阴寒之邪, 因而白昼病情较轻; 夜晚阴气较重, 加重了阴寒之象, 因而夜晚则咳嗽更甚。

胸闷心悸

由于寒饮阻滞, 胸阳不振, 因而胸闷。如果寒饮侵犯于心, 阻遏心血正常的输布, 则会产生心悸。

痰多稀白

寒饮凝聚上泛于口, 故痰多稀白。

脉浮滑或沉紧。



滑脉主痰饮、宿食、实热、蓄血。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。

紧脉主寒, 主痛, 主宿食。



中医师解说

分析:

浮脉轻取即得, 重按稍减而不空, 滑脉往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠; 沉脉轻取不应, 重按始得; 紧脉脉来绷急, 状如牵绳转索。

4. 高血压

类型1: 虚寒内盛, 痰浊上逆之“高血压虚证”

证候: 头痛(巅顶尤甚), 烦躁, 手足厥冷, 干呕或吐涎沫, 舌淡白胖大, 齿痕, 苔白滑而腻, 脉沉弦或沉迟。

头痛(巅顶尤甚):
由于膀胱经与督脉都是运行阳气的经脉, 并且上会于巅顶, 当虚寒内盛时则阳气相对不足, 因此当痰浊上逆, 阻遏气血的运行时, 以巅顶头痛特别明显。

手足厥冷:
由于阳气虚衰, 无力运化气血到达四肢末端, 因而手足厥冷。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。

烦躁:
由于痰浊上扰于心神, 因而烦躁。

干呕或吐涎沫:
由痰浊阻滞气机正常的升降, 以至于胃气上逆, 因而干呕, 如果胃中寒饮随着气机上逆于口, 则口吐涎沫。

脉沉弦或沉迟。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



迟脉主寒证, 迟而有力为寒实证(注: 或为实热证), 迟而无力为虚寒证。



中医师解说

分析:
沉脉轻取不也, 重按始得; 弦脉端直而长, 如按琴弦; 迟脉来去迟慢, 一息三至。

★名词解释

手足厥冷, 又称为“手足逆冷”、“四逆”, 指人体的四肢发冷, 甚至要颈至肘腋以上的部位。

手足厥冷的病因又有寒热的区分: 寒证是由于体内的阴寒内盛, 阳气虚微, 四肢得不到阳气的温煦, 因而发冷; 热证是由于体内的阳热内盛, 热邪壅阻于内, 致使阳气不能外达于四肢, 因而发冷。

类型2: 肝郁胆滞, 气机失调之“高血压实证”

证候: 胸胁苦满, 心烦易怒, 眩晕耳鸣, 口干便燥, 小便短赤, 舌红, 苔黄, 脉弦数。

病因: 此症是由于肝郁胆滞, 肝的藏血与疏布气机的功能失调, 致使气血的运行不畅, 因而导致高血压的产生。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦; 数脉一息五至以上。

5. 心脏病

类型1: 水气凌心之“心脏病虚实夹杂证”

证候: 胸闷隐痛或胸背剧痛, 心悸, 目眩, 舌体淡白胖大, 齿痕明显, 苔白润, 脉沉紧或弦。

胸闷隐痛或胸背剧痛
由于水气上凌于胸膈, 心脉气血瘀阻。

目眩
水饮或湿邪蒙闭于头目清窍, 阻遏清阳气机的升降, 因而导致目眩的产生。

沉脉主里证。
沉而有力为里实; 沉而无力为里虚。

心悸
水饮或湿邪侵犯于心, 阻遏心血正常的输布, 则会产生心悸。

脉沉紧或弦。

紧脉主寒, 主痛主宿食。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



中医师解说

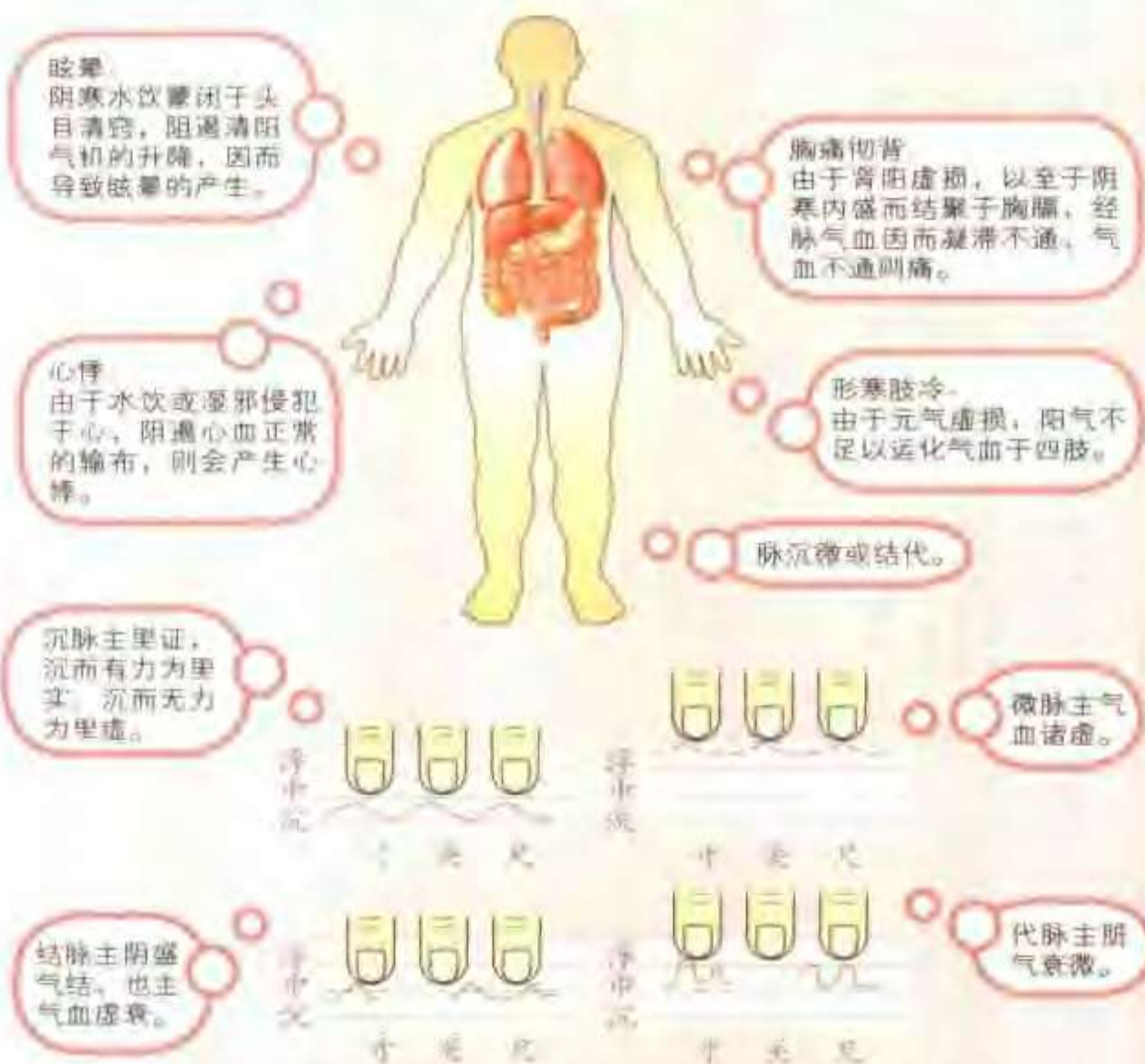
HEALTHFUL

分析:
沉脉轻取不应, 重按始得; 紧脉脉来绷急, 状如牵绳转索; 弦脉端直而长, 如按琴弦。

类型2: 肾阳虚衰, 寒水上泛之“心脏病虚证”

证候: 眩晕, 心悸, 胸痛彻背, 形寒肢冷, 舌淡白润, 苔白滑, 脉沉微或结代。

病因: 由于肾阳虚衰, 肾阳不足以温化水湿, 致使水湿上泛于胸膈, 阻碍气血的正常运化。



中医师解说

分析:

沉脉轻取不应, 重按始得。微脉极细极软, 似有似无, 至数不明; 结脉迟滞而中止, 止无定数; 代脉脉来而中止, 止有定数, 良久方来。

★名词解释

肾阳: 肾阳与肾阴统称为肾的重要组成, 肾阳在某种意义上, 涵盖了肾气的成分, 具有温煦气血, 温通经脉的作用。

类型3: 痰热互结, 心阳被遏之“心脏病实证”

证候: 胸脘痞满, 痰鸣心悸, 便秘, 舌尖红, 苔黄腻, 脉弦滑或弦数。

病因: 由于痰湿与邪热相互搏结于心室, 阻碍气血的运化, 因此属于实证。

胸脘痞满
由于痰热壅阻于胸脘, 阻遏胃肠气机的升降, 因而胸脘痞满。

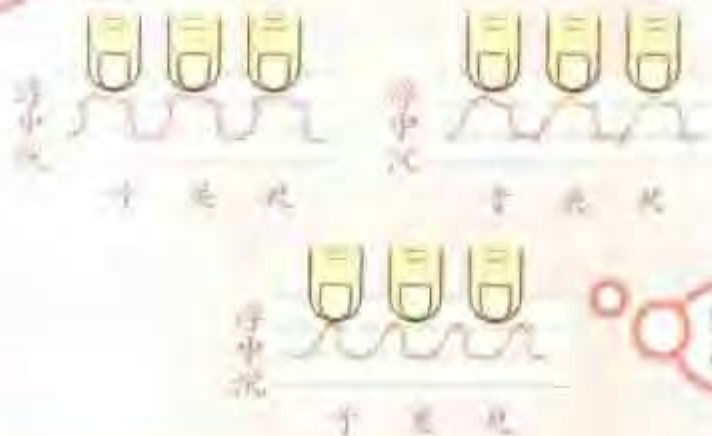
痰鸣心悸
由于痰热壅阻于心肺, 当心阳的运行受阻时, 则会产生心悸。如果痰浊随着气机或升或降, 则会产生痰喘。

便秘
由于痰热壅滞于胃肠, 阻遏肠道气机的升降, 以至于肠道传导失常而便秘。

脉弦滑或弦数。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。

滑脉主痰饮、宿食、实热、蓄血。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦; 滑脉往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠; 数脉一息五至以上。

★名词解释

痰热: 痰湿与邪热相互搏结所形成的病邪。

心阳: 心阳与心阴皆为心的重要组成, 心阳在某种意义上, 涵盖了心气的成分, 具有温煦气血, 温通经脉的作用。

实证: 是指由于外邪侵袭人体, 入里而化热, 或是由于气滞血瘀、痰饮、食积等壅塞于胃肠, 临床表现为壮热、烦渴、便秘等征状。

类型4: 气血不足, 阴阳两虚之“心脏病虚证”

证候: 胸闷而痛, 心悸, 少气乏力, 舌淡白, 苔白润, 脉结代。

胸闷而痛。
由于阴阳气血不足, 心肺无力运行气血, 以至于气机的升降失调, 壅滞于胸膈, 因而胸闷而痛。

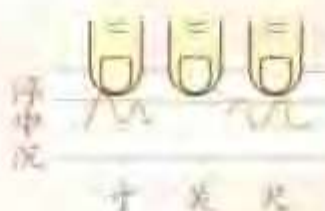


心悸。
由于气血不足, 心阳虚损, 无力濡养心脏, 因而心悸。

脉结代。

少气乏力。
由于气血的生化不足, 以至于气弱血虚, 因而少气乏力。

结脉主阴盛气结,
也主气血虚衰。



代脉主脏气
衰微。



中医师解说

分析
结脉迟缓而时止, 止无定数;
代脉脉来动而一止, 止有定
数, 良久方来。

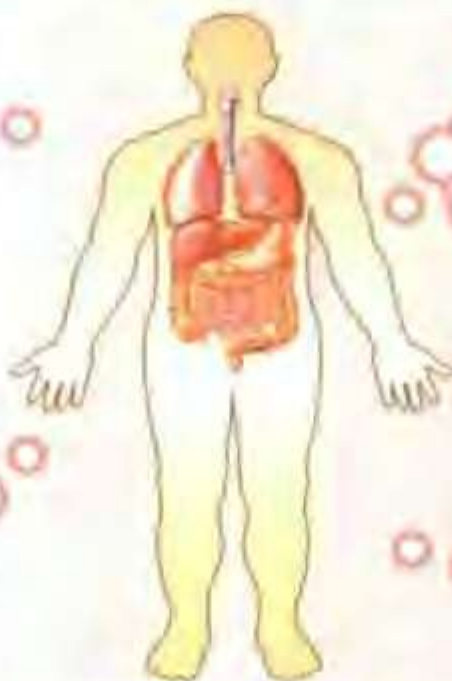
6. 胃溃疡

类型1: 肝胃阴虚之“胃溃疡虚证”

证候: 口燥咽干, 胃脘胀痛, 四肢拘急而痛, 大便燥结, 舌尖红嫩, 欠润, 脉弦细。

口燥咽干
由于体内的阴液亏虚, 津液不足以上承于咽口, 因而口干咽燥。

胃脘胀痛
由于胃津的生成不足, 以至于气血经络失于濡养, 气血凝滞而不畅, 因而胃脘胀痛。



四肢拘急而痛
由于气滞血瘀, 气血不足以濡养筋脉, 因而四肢拘急而痛。

大便燥结
由于肠道阴液亏损, 因而大便燥结。

脉弦细。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



细脉主气血两虚, 诸虚劳损。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦; 细脉脉细如线, 但应指明显。

类型2: 脾胃虚寒之“胃脘痛虚证”

证候: 胸脘痞满胀痛, 喜按喜温, 泛吐清水, 口淡纳呆, 手足不温, 大便溏烂, 舌质淡白, 舌胖大而有齿痕, 苔白润略腻, 脉缓弱。

胸脘痞满胀痛, 喜按喜温
脾胃虚寒, 阴寒之邪凝聚于脘腹, 以至于气血经络凝滞不畅, 因而胃脘胀痛, 又因属于寒虚之邪, 因而喜按喜温。

口淡纳呆
由于寒气凝滞于内, 以至于阳气亏虚, 不能运化水湿, 因而口淡。又因脾胃本属虚寒, 加上水湿停聚于胃脘, 因而纳呆。

缓脉主湿, 或主脾虚。

泛吐清水
脾胃虚寒, 脾的健运功能失调, 以至于水饮内停于胃, 当水饮随着胃气上逆, 则泛吐清水。

手足不温
阳气不足, 经络气血凝滞而不畅, 无力运化气血于四肢。

大便溏烂
由于虚寒之邪内盛, 损伤阳气, 以至于肠胃传导失司, 因而大便溏烂。

脉缓弱。



弱脉主气血亏虚。



中医师解说

分析:
缓脉比迟脉稍快, 一息四至, 往来悠缓; 弱脉沉而柔细。

★名词解释

大便溏烂: 由于脾气虚弱, 或肾阳不足所致。因下痢重便为清稀粘秽的混汁。

类型3: 寒热夹杂之“胃痞满虚实夹杂证”

证候: 呃逆, 胃脘痞满或胀痛, 嘈杂泛酸, 饥不欲食, 肠鸣下利, 舌淡而胖大, 苔白腻或黄白腻, 脉沉或细弱或弦细。

呃逆。
寒热夹杂于胃脘, 以至于胃失和降, 当胃气上逆时, 则呃逆。

嘈杂泛酸, 饥不欲食。
寒热之邪气错杂于胃脘, 以至于脾胃不和, 当肝气犯胃时, 则嘈杂泛酸。如果寒热之邪阻遏气机, 导致胃脘痞满, 则会产生饥不欲食。

胃脘痞满或胀痛。
寒热之邪互结痞阻于胃脘, 以至于脾胃的升降与脾胃功能失常, 则会出现胃脘痞满胀痛。

肠鸣下利。
脾胃的气机升降失调, 因而肠鸣, 当水湿下注于肠道时, 则下利。

脉沉或细弱或弦细。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。

弱脉主气血亏虚。



弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



细脉主气血两虚, 诸虚劳损。



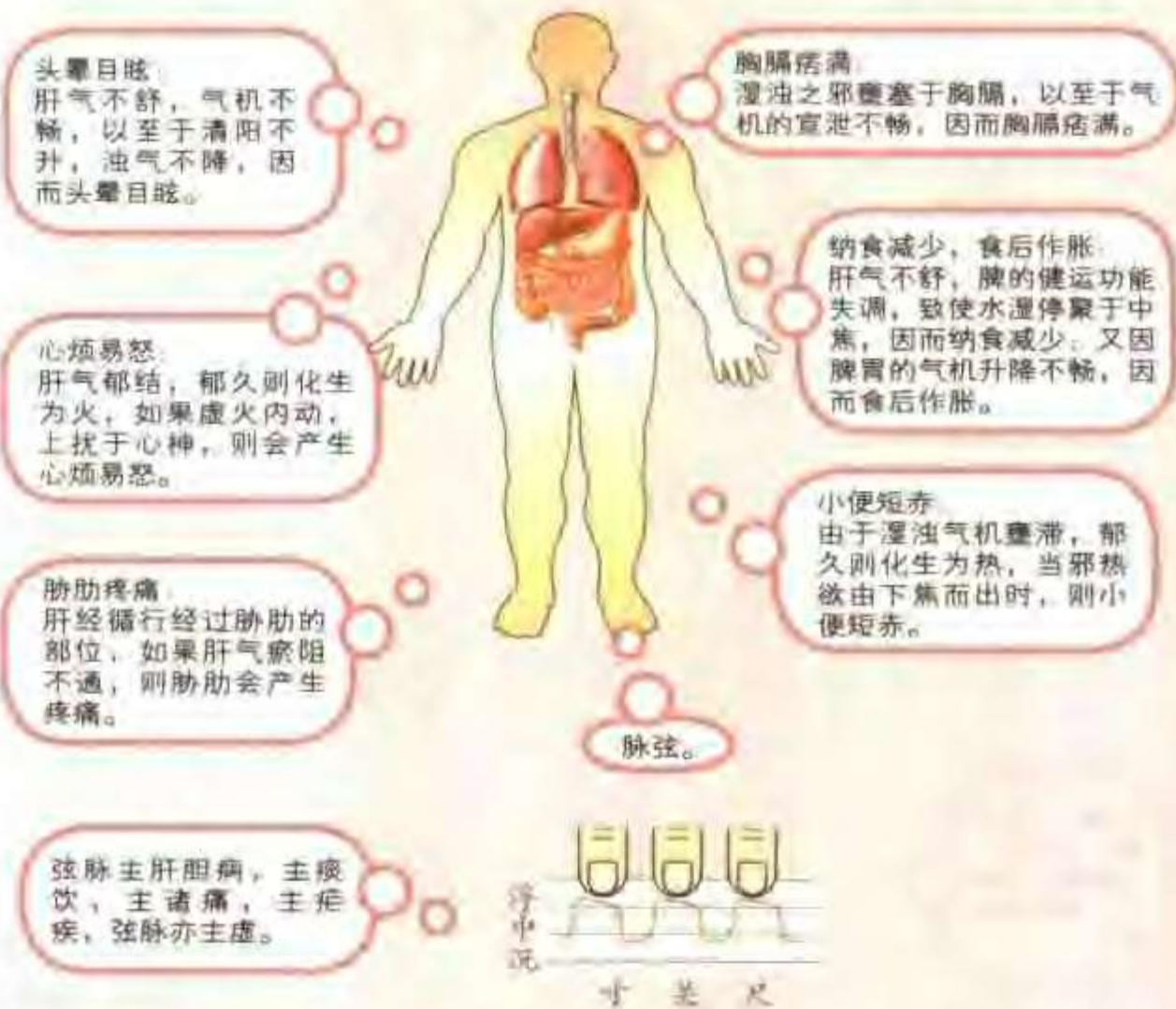
中医师解说

分析:
沉脉轻取不应, 重按始得; 细脉脉细如线, 但应指明显; 弱脉沉而柔软; 弦脉端直而长, 如按琴弦。

7. 肝硬化

类型1: 肝郁湿阻之“肝硬化虚实夹杂证”

证候: 头晕目眩, 心烦易怒, 胁肋疼痛, 胸膈痞满, 纳食减少, 食后作胀, 小便短赤, 苔白滑, 脉弦。





分析:

弦脉端直而长, 如按琴弦。

中医师解说

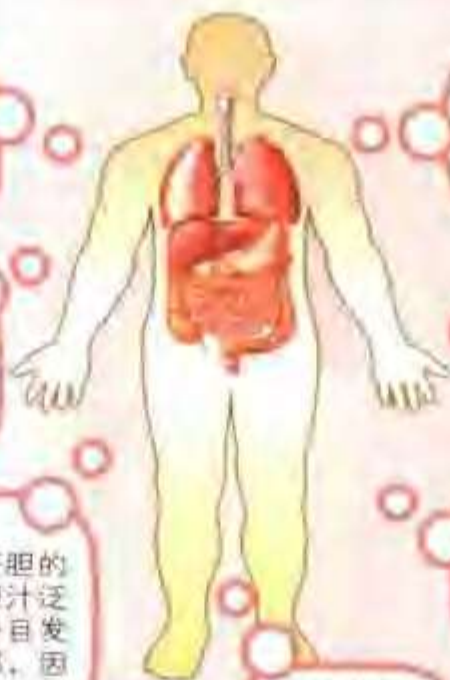
类型2: 湿热内蕴之“肝硬化实证”

证候: 恶心呕吐, 发热口渴, 身目发黄如橘子色, 腹部胀满, 尿少色黄, 大便秘结, 舌边尖红, 舌苔黄腻, 脉弦滑数。

恶心呕吐
湿热痞阻于胃脘, 以至于胃失和降, 当胃浊上逆时, 则恶心呕吐。

发热口渴
由于热邪炽盛于体内, 因而发热。如果湿热灼伤津液, 津液不足则口渴。

身目发黄如橘子色
由于湿热熏蒸于内, 肝胆的气机郁而化热, 于是胆汁泛溢于肌表, 因而出现身目发黄。又因热邪属于阳邪, 因而颜色鲜明。



腹部胀满
湿热痞阻于中焦, 阻遏胃肠气机的升降, 因此导致腹部痞满。

大便秘结
由于湿热停聚于内, 阻遏肠道气机的升降, 以至于肠腑的传导失常。

尿少色黄
由于湿热交蒸于内, 水湿难以排出, 因而尿少。且因邪热欲由下焦而出, 因而小便色黄。

脉弦滑数。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



滑脉主痰饮, 宿食, 实热, 蓄血。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦; 滑脉往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠; 数脉一息五至以上。

类型3: 水饮停结之“肝硬化虚实夹杂证”

证候: 胸胁闷痛, 腹大痞满, 食后腹胀加重, 恶心呕吐, 呼吸气短, 小便短赤, 舌苔白滑, 脉沉弦。

胸胁闷痛:

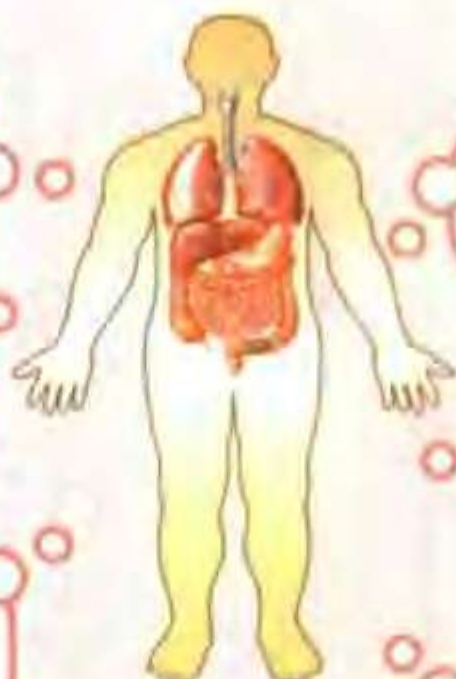
肝经循行经过肋肋的部位, 如果因水饮阻遏, 以至于肝的疏泄失常, 导致气血运行不畅, 则会产生胸胁闷痛。

恶心呕吐:

湿浊雍阻于胃脘, 以至于胃失和降, 当胃气上逆时, 则呕吐。

呼吸气短:

水饮停聚于体内, 当水饮上犯于肺, 导致肺失宣泄, 则会产生呼吸气短。



腹大痞满, 食后腹胀加重: 湿热郁结中焦, 因而腹部胀满, 又因气机的宣泄不畅, 因而食后腹胀加重。

小便短赤:

水湿内盛, 三焦的决渎功能失职, 以至于湿热内蕴, 因此小便短赤。

脉沉弦。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。



寸 关 尺



寸 关 尺

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



中医师解说

分析: 沉脉轻取不应, 重按始得。弦脉横直而长, 如按琴弦。

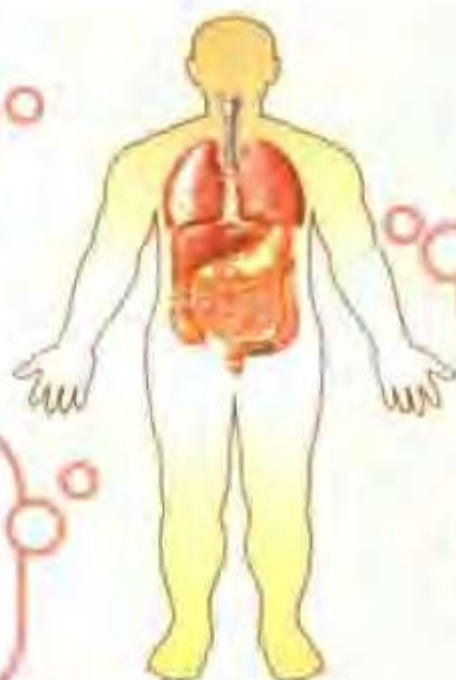
8. 慢性肝炎

类型1: 肝郁气滞之“慢性肝炎实证”

证候: 口苦, 胁肋胀痛, 肝脏肿大, 脘痞腹胀, 舌苔白黄, 脉弦。

口苦

肝的疏泄功能失调, 以至于肝气郁滞, 胆气上泛于口, 因而口苦。



脘痞腹胀

肝的疏泄功能失调, 脾胃的气机壅滞于脘腹, 因而脘部胀满。

胁肋胀痛, 肝脏肿大
肝经循行经过胁肋的部位, 如果因肝的疏泄失常, 以至于气血运行不畅, 导致肝郁而血瘀, 则会引起胁肋胀痛或肝脏肿大。

脉弦。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



中医师解说

脉弦主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。

分析:

弦脉端直而长, 如按琴弦。

类型2: 寒湿阻中之“慢性肝炎虚实夹杂证”

证候: 身黄晦暗, 色如烟熏, 纳少脘闷, 畏寒肢冷, 大便溏泄, 尿黄, 舌淡, 苔白滑, 脉沉弦或沉迟。

身黄晦暗, 色如烟熏:
寒湿之邪阻遏胆管, 以
至于胆汁外溢于肌表,
则身黄晦暗; 又因寒湿
之邪为阴邪, 因而色如
烟熏。

畏寒肢冷:
寒湿内盛, 致使阳气相对
不足, 不能运行气血于四
肢, 因而畏寒肢冷。

沉脉主里证, 沉而有
力为里实, 沉而无力
为里虚。

纳少脘闷:
寒湿痞阻于中焦, 脾
胃气机壅滞不通, 因
而纳少脘闷。

便溏:
寒湿痞阻于中焦,
致使脾胃虚寒, 脾
失健运, 以至于湿
浊下注于肠道, 因
而大便溏泄。

脉沉弦或沉迟。

弦脉主肝胆病, 主痰
饮, 主诸痛, 主疟
疾, 弦脉亦主虚。



迟脉主寒证。
迟而有力为寒实证
(注: 或为实热证),
迟而无力为虚寒证。



中医师解说

分析:
沉脉轻取不应, 重按始得
弦脉端直而长, 如按琴
弦; 迟脉来去迟慢, 一息
三至。

★名词解释

大便溏泄: 由于脾气虚弱,
或肾阳不足所致, 泻下的粪
便为清稀稀软的成分。

9. 糖尿病

类型1: 胃热炽盛之“糖尿病实证”

证候: 大渴引饮, 多食易饥, 汗出, 小便色赤, 心烦, 舌红苔黄燥, 脉洪大或滑数。

口大渴
胃热炽盛, 热邪灼伤津液, 津液亏损不足, 因而口大渴。

汗出
里热炽盛, 邪热逼迫体内的津液由肌表而溢出, 因而汗出。

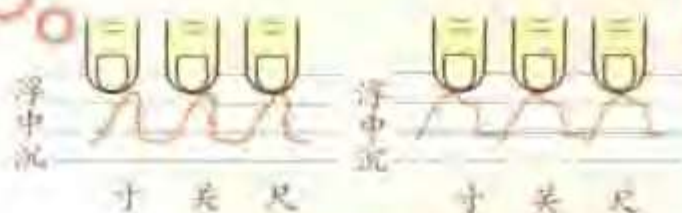
心烦
热邪上扰于心神, 因而心烦。

多食易饥
胃腑的邪热炽盛, 邪热盛则善于消化五谷, 因而多食易饥。

小便短赤
邪热壅阻于内, 邪热欲由下焦而出, 因而小便短赤。

脉洪大或滑数。

洪脉主热证。



滑脉主痰饮, 宿食, 实热, 蓄血。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

分析:
洪脉极大, 来盛去衰; 滑脉往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠; 数脉一息五至以上。

类型2: 阴液亏损之“糖尿病虚证”

证候: 口渴多饮, 咽干, 烦躁, 四肢拘挛, 疼痛, 大便干, 小便短少, 舌红干苔少, 脉弦细或细数无力。

口渴多饮, 咽干
由于阴液亏损, 津液不足以上布于咽口, 因而口渴多饮, 咽干。

烦躁
体内的阴液血少, 致使虚热内生, 虚热扰动心神, 心失所养, 因而烦躁。

四肢拘挛、疼痛
体内的阴液亏虚, 气血不足以濡养筋脉, 因而四肢拘挛而疼痛。

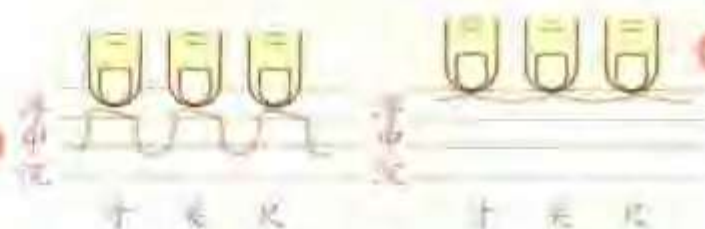
大便干
体内的阴液不足, 致使虚火内生, 虚火灼伤津液, 导致肠液枯竭, 因而大便干。

小便短少
体内的阴液亏虚不足, 膀胱的气化功能没有津液可以化生, 因而小便短少。

脉弦细或细数无力。

细脉主气血两虚, 诸虚劳损。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

脉色病证与脉形关系

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦;
细脉脉细如线, 但应指明显;
数脉一息五至以上。

类型3: 湿热互结之“糖尿病虚实夹杂证”

证候: 口渴多饮, 多食易饥, 心烦不得眠, 小便不利, 下利, 舌红少苔或无苔, 脉浮数或细数。

口渴多饮:
湿热之邪相互搏结, 邪热灼伤津液, 因而口渴多饮。

多食易饥:
邪热壅滞于胃腑, 里热炽盛, 则消谷易饥。

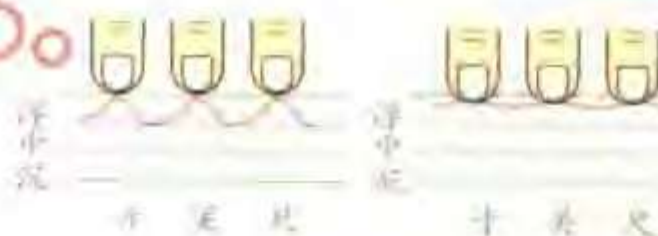
心烦不得眠:
肝血不足, 血虚则虚热内生, 虚热扰动心神, 因而心烦; 如果又因肾阴亏损, 以至于心神与肾阴不能相互交融, 则会引起失眠。

小便不利:
湿热之邪相互搏结且壅阻于下焦, 致使下焦气机与水道不利, 则会引起小便不利。

下利:
湿热停聚于内, 当湿浊下注于大肠时, 则会导致下利。

脉浮数或细数。

浮脉主表证(脉必浮而有力)。也可见于风水。



细脉主气血两虚, 诸虚劳损。



数脉主热; 数脉亦主虚证。



中医师解说

HEALTHY PEOPLE

分析:
浮脉轻取即得, 重按稍减而不空; 数脉一息五至以上; 细脉脉细如线, 但应指明显。

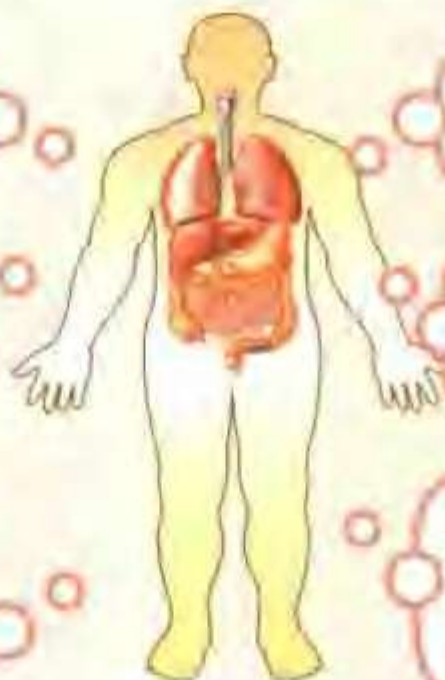
类型4：里热痞聚之“糖尿病实证”

证候：烦渴引饮，口干舌燥，多食易饥，潮热汗出，腹满胀痛，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔黄干或焦燥起刺，脉滑数或沉实有力。

烦渴引饮，口干舌燥。
热邪灼伤津液，津液亏损不足，因而烦渴引饮，口干舌燥。

潮热汗出。
由于里热炽盛，逼迫体内的津液由肌表而出，致使阴液亏损不足，因而出现潮热、汗出。

脉滑数或沉实有力。



多食易饥。
邪热痞阻于胃肠，邪热盛则善于消化五谷，因而多食易饥。

腹满胀痛。
津液亏损不足，燥屎内结于肠道，阻滞胃肠气机正常的升降，因而腹满胀痛。

大便秘结，小便短赤。
邪热灼伤津液，致使肠道的津液不足，津液不足则虚热内生，津液挟着邪热下渗于膀胱，因而大便秘结，小便短赤。

滑脉主痰饮，宿食，实热，蓄血。



数脉主热。
数脉亦主虚证。

沉脉主里证，沉而有力为里实，沉而无力为里虚。



实脉主实证，实脉也可见于阴寒厥冷之证。



中医师解说

分析

滑脉往来流利，应指圆滑，如盘走珠；数脉一息五至以上；沉脉轻取不度，重按始得；实脉浮中沉三部举按均有力。

★名词解释

潮热：指人体每天到了一定时候，就会如潮水般定时产生发热。

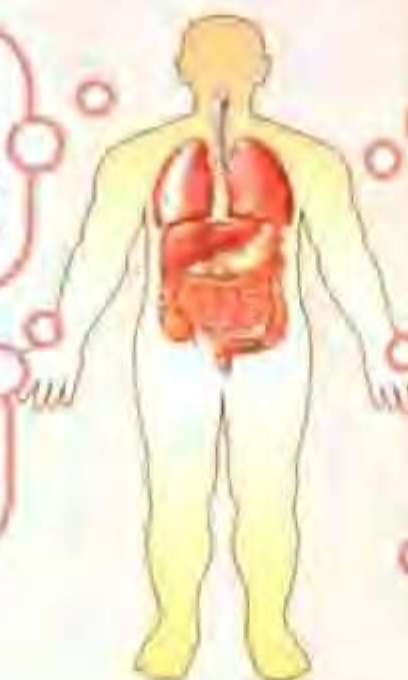
盗汗：阴虚潮热。因阳气受虚邪所阻遏，通常于下午时产生发热。日晡潮热。因热邪结聚于肠道，亦可于每天产生发热。

类型5: 血瘀胃热之“糖尿病实证”

证候: 口渴, 但饮水不多, 疲乏无力, 四肢麻痹, 大便硬或秘结不通, 舌质紫黯, 苔薄黄或白, 脉弦滑或沉细。

口渴, 但饮水不多
邪热灼伤津液, 因而口渴。邪热蕴积日久则会伤及营血, 又因邪热与瘀血相互搏结, 传变入于阴分而形成痹证, 因此口渴而饮水不多。

疲乏无力
湿邪的性质重浊, 邪热蕴结于胃肠, 致使脾的健运功能失调, 气血生化不足, 因而疲乏无力。



四肢麻痹
邪热与瘀血相互搏结, 致使气血运行不畅, 筋脉失于濡养, 因而四肢麻痹。

大便硬或秘结不通
邪热内蕴, 邪热灼伤阴液, 津液不足则大便硬, 如果肠道的津液枯竭, 则大便将会秘结不通。

脉弦滑或沉细。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



滑脉主痰饮, 宿食, 实热, 蓄血。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。



细脉主气血两虚, 诸虚劳损。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦; 滑脉往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠; 沉脉轻取不应, 重按始得; 细脉脉细如线, 但应指明显。

10. 慢性肾炎

类型1: 肾虚湿郁, 水热互结之“慢性肾炎虚实夹杂证”

证候: 头晕耳鸣, 腰膝酸软, 面浮足肿, 小便频数, 欲出无尽, 入夜为甚, 低热, 或五心烦热, 舌红少苔或舌淡苔, 脉弦细而数。

腰膝酸软

腰为肾之府, 由于肾虚而元气不足, 致使气血筋脉失于濡养, 因而腰膝酸软。

五心烦热

肾阴亏损, 致使虚火上炎, 虚火灼伤阴液, 因而出现手足四肢与心窝处的五心烦热。

小便频数, 欲出无尽

湿热壅结于下焦, 致使膀胱的气化功能失调, 导致水道不利, 因而出现小便频数, 欲出无尽。

头晕耳鸣

肾精不足, 不能充养髓海, 因而头晕耳鸣。

低热

湿热阻遏气机正常的宣泄, 湿热之邪凝聚于体内而不散, 因而出现低热缠绵而难愈。

面浮足肿

肾阳虚损, 膀胱的气化功能失调, 致使湿浊停滞于内, 水饮泛滥于头面四肢, 因而面浮足肿。

脉弦细而数。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



细脉主气血两虚, 诸虚劳损。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

分析:

弦脉挺直而长, 如按琴弦, 细脉纤细如线, 但应指明显; 数脉一息五至以上。

类型2: 下焦湿热, 水蓄膀胱之“慢性肾炎实证”

证候: 口渴, 发热畏寒, 尿频, 尿急, 尿痛或淋漓不尽, 少腹胀痛, 腰酸痛, 苔薄黄, 脉濡数或滑数。

口渴
湿热蕴结于内, 致使津液难以输布于上, 因而口渴。

尿频, 尿急, 尿痛或淋漓不尽
湿热结聚于下焦, 膀胱的气化功能失调, 水道不利, 因而出现尿频、尿急、尿痛、淋漓不尽。

发热畏寒
湿热内蕴, 湿热久郁则化生为火。当火热之邪蒸腾于内时, 则发热。又因火热之邪容易耗耗气阴, 当火热之邪损伤卫气时, 卫气不足则不能温煦肌表, 因而畏寒。

少腹胀痛, 腰酸痛
湿热蕴结于膀胱, 致使脾胃的升清与降浊作用失调, 因而少腹胀痛。

脉濡数或滑数。

濡脉主阴阳, 气血诸虚。



数脉主热, 数脉亦主虚证。



滑脉主痰饮, 宿食, 实热, 蓄血。



分析:
数脉一息五至以上: 主热证而脉数; 滑脉往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠。

★名词解释

三焦: 三焦分为上焦、中焦与下焦, 主要功能为通调水道, 运行水液。

11. 坐骨神经痛

类型1: 久痹入络之“坐骨神经痛虚证”

证候: 腰腿疼痛迁延不愈, 肌肉渐消, 麻木不仁, 屈伸不利, 行动艰难, 疲乏无力, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。

腰腿疼痛:

气弱血虚, 筋骨失于濡养, 致使风寒湿邪留滞于筋骨而不去, 因而疼痛迁延不愈。

屈伸不利, 行动艰难
风寒湿邪阻遏经络气血的运行, 肢体与血脉失于濡养, 因而屈伸不利, 行动艰难。

肌肉渐消, 麻木不仁
脾主肌肉, 如果风寒湿邪停滞于体内而形成痹证, 阻遏脾的运化功能, 日久则气血更为虚弱, 因而肌肉渐消, 麻木不仁。

肢冷无力
风寒湿邪凝滞于内, 致使气血得运行不畅, 气血不能温养四肢, 因而肢冷无力。

脉细弱。

细脉主气血两虚; 诸虚劳损。



弱脉主气血亏虚。



中医师解说

脉象为细弱脉。

分析:
细脉脉细如线, 但应指明显; 弱脉沉而柔细。

类型2: 寒湿侵袭之“坐骨神经痛实证”

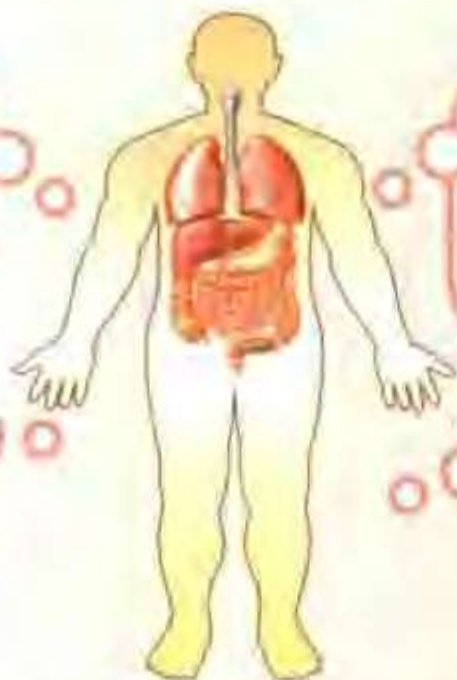
证候: 腰腿疼痛僵硬, 屈伸不利; 遇冷痛增, 得热则缓, 苔薄白, 脉弦缓。

腰腿疼痛僵硬。

寒邪为阴邪, 性质凝滞, 当气血为寒邪所阻遏时, 经脉气血运行不利, 因而腰腿疼痛僵硬。

屈伸不利。

寒邪阻遏气血经络的运行, 气血不能温养肢体, 因而腰腿屈伸不利。



遇冷痛增, 得热则缓。

当寒邪遇热后自然可以温散, 气血也能恢复流通, 因而疼痛可以暂减; 如果遇寒则血气的运行更为凝滞, 因而疼痛加剧。

脉弦缓。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



缓脉主湿, 或主脾虚。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦;
缓脉比迟脉稍快, 一息四至, 来去怠慢。

类型3: 痰湿凝滞之“坐骨神经痛实证”

证候: 腰痛固定不移, 入夜尤重, 麻木不仁, 腰腿困重, 苔厚腻, 脉迟涩或滑。

腰痛固定不移, 入夜尤重。当痰与湿相互凝结后, 容易阻滞气血的运行, 气血不通则产生疼痛。又因湿邪的性质重浊, 因而腰痛固定不移。湿邪为阴邪, 入夜时, 阴寒之气更重, 因而疼痛加剧。

迟脉主寒证。迟而有力为寒实证(证), 或为实热证(证); 迟而无力为虚寒证。脉迟涩或滑。

麻木不仁。痰与湿相互凝结后, 致使气血运行不畅, 筋脉失于濡养, 因而产生四肢麻木不仁。

腰腿困重。湿邪的性质重浊, 当经络气血为湿邪所阻滞时, 气血运行不利, 因而腰腿困重。

脉迟涩或滑。



涩脉主精伤、血少、气滞、血瘀。



滑脉主痰饮、宿食、实热、蓄血。



中医师解说

分析:
迟脉来去迟慢, 一息三至; 涩脉迟细而短, 往来艰涩; 滑脉往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠。

12. 妇女痛经

类型1: 肝郁气滞之“妇女痛经实证”

证候: 经前或经期有小腹胀痛, 经量少或经行不畅, 胸胁胀闷, 善叹息, 经前烦躁易怒, 乳房作胀, 舌质暗滞, 苔白, 脉弦。

小腹胀痛, 经量少或经行不畅
肝经循行经过小腹的部位, 当肝气瘀阻时, 脾胃的升清与降浊作用失调, 因而小腹胀痛, 经量少或经行不畅。

胸胁胀闷
肝经循行经过胸胁的部位, 当肝气瘀阻时, 肝的疏泄功能失调, 因而胸胁胀闷。

善叹息
肝气瘀阻, 致使气机的升降不畅, 当叹息时可舒缓气机之壅滞, 因而肝郁者善叹息。

经前烦躁易怒, 乳房作胀
妇女于行经前的气血即将推陈出新, 如果因平素血虚或是气郁血滞, 则血液不足以濡养心肝, 因而烦躁易怒, 乳房作胀。

脉弦。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



中医师解说

分析:
弦脉端直而长, 如按琴弦。

★名词解释

善叹息: 由于肺气不宜或是肝气郁结等因素所引起的气机不畅时, 表现为频频叹气, 因此又称为“善太息”。

类型2: 瘀血内阻之“妇女痛经实证”

证候: 经前或经期小腹硬痛拒按, 经色紫暗, 内挟瘀块, 血块排出后痛减。面色黧黑, 甚或肌肤甲错, 舌质青紫瘀斑, 或舌下静脉粗黑, 苔薄白, 脉沉涩或脉沉结。

经前或经期小腹硬痛拒按
由于瘀血停滞于体内, 甚至形成痞块, 阻遏气血的运行, 因而经前或经期小腹硬痛拒按。

血块排出后痛减
当血块排出体外后, 体内血瘀的程度自然减轻, 因而疼痛亦随之而减弱。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。

面色黧黑, 甚或肌肤甲错
由于血瘀阻滞, 致使气血的运行不畅, 难以濡养于头面肌表, 因而面色黧黑, 甚或肌肤甲错。

脉沉涩或脉沉结。

涩脉主精伤, 血少, 气滞, 血瘀。

浮中沉



寸 关 尺

浮中沉



寸 关 尺

浮中沉



寸 关 尺

结脉主阴盛气结, 也主气血虚衰。



中医师解说

分析:
沉脉轻取不应, 重按始得; 涩脉迟滞而简, 往来艰涩; 结脉迟滞而时止, 止无定数。

类型3: 血虚寒凝之“妇女痛经虚证”

证候: 经前或经行小腹疼痛, 喜温喜按, 经量少, 色淡, 痛时手足冷, 或麻木不仁, 舌质淡, 苔白, 脉沉细迟。

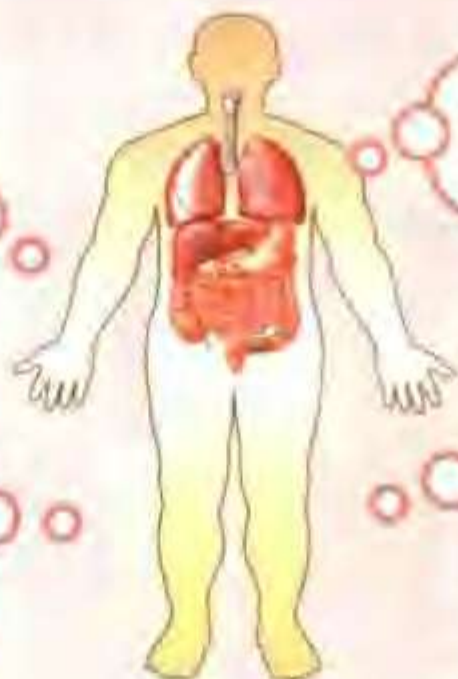
经前或经行小腹疼痛, 喜温喜按。妇女平素血虚, 又因感受寒邪, 寒邪停聚于胞宫, 阻滞气血正常的运行, 因而经前或经行小腹疼痛, 喜温喜按。

痛时手足冷, 或麻木不仁。血虚则阴寒凝滞, 四肢失于温养, 故手足冷或麻木不仁。

经量少, 色淡。血虚不足, 不能充盈冲任的经脉, 因而月经量少而色淡。

脉沉细迟。

细脉主气血两虚, 诸虚劳损。



沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。



迟脉主寒证, 迟而有力为寒实证(注: 或为实热证), 迟而无力为虚寒证。



中医师解说

分析: 沉脉轻取不应, 重按始得; 细脉脉细如线, 但应指明显; 迟脉来去迟慢, 一息三至。

13. 妇女带下

类型1: 阳虚湿盛之“妇女带下虚证”

证候: 白带稀薄, 清冷量多, 淋漓不断, 腰痛如折, 小腹冷痛, 小便频数清长, 大便溏泄, 舌质淡, 苔白润或白滑, 脉沉迟弱。

白带稀薄、清冷量多、淋漓不断:
肾阳不足, 致使虚寒内生, 虚寒凝聚于下焦, 导致带脉失约, 任脉不固, 因而白带稀薄、清冷量多、淋漓不断。

腰痛如折:
腰为肾之府, 肾虚则不能化生为气血, 气血虚损不畅, 因而腰痛如折。

小腹冷痛:
肾阳不足, 以至于阴寒内盛, 当阴寒之气凝聚于下焦时, 则小腹冷痛。

小便频数清长:
肾阳不足, 膀胱的气化功能失司, 因而小便频数清长。

大便溏泄:
肾阳亏虚, 阳气不足则不能运化水湿, 水湿下注于大肠, 导致肠道传导失职, 因而大便溏泄。

脉沉迟弱。

迟而有力为寒实证(注: 或为实热证), 迟而无力为虚寒证。

沉脉主里证, 沉而有力为里实, 沉而无力为里虚。



弱脉主气血亏虚。



中医师解说

分析:
沉脉轻取不应, 重按始得; 迟脉来去迟慢, 一息三至; 弱脉沉而柔细。

类型2: 湿热内盛之“妇女带下实证”

证候: 带下黏腻腥臭, 色黄或黄白相兼, 胸闷, 口腻, 纳呆, 或小腹隐痛绵绵, 小便短赤, 舌质红, 苔黄腻, 脉濡数。

带下黏腻腥臭, 色黄或黄白相兼

湿邪的性质为重浊, 色白主湿, 色黄主热, 当湿热之邪蕴灼于体内, 以至于湿浊凝聚难消, 因而带下色黄或黄白相兼, 质黏腻而臭。

胸闷、口腻

湿热停滞于胸膈, 阻遏气机之升降, 因而胸闷, 且因湿热重浊, 当湿浊之邪上泛于口, 则产生口腻。

纳呆

湿热停聚于中焦, 脾的健运功能失调, 因而纳食减少。

小腹隐痛绵绵

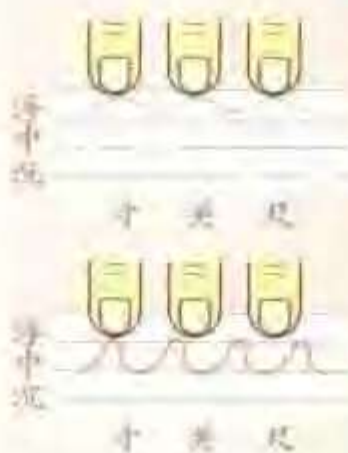
邪热停滞于下焦, 湿热相互搏结而缠绵不去, 阻遏气机的升降, 因而小腹隐痛绵绵。

小便短赤

湿热之邪停滞于下焦, 邪热欲由下焦而出, 因而小便短赤。

脉濡数。

濡脉主阴明
气血诸虚。



数脉主热, 数脉
亦主虚证。



中医师解说

分析:
濡脉浮而细软; 数脉一息
五至以上。

14. 更年期综合征

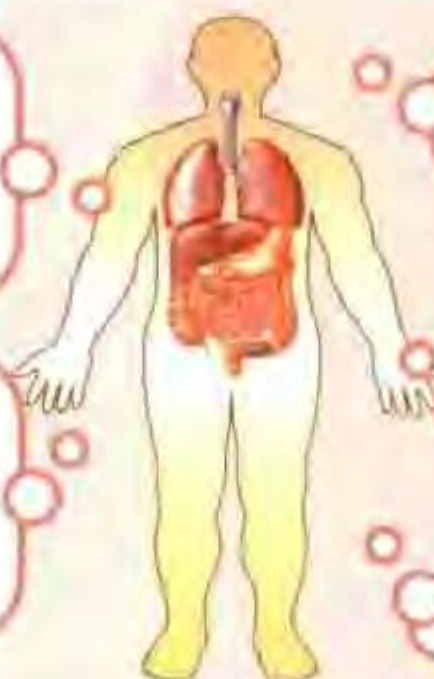
类型1：阴阳虚损之“更年期综合征虚证”

证候：绝经前后，发热汗出，头晕耳鸣，烦躁，失眠，腰膝酸软，四肢厥冷，舌淡，苔薄白，脉沉细。

绝经前后，发热汗出。
体内的阴阳气血两虚，
以至于虚热内生，此时
因卫阳不足，不能护卫
人体的肌表，导致营阴
不能内守，因而发热而
自汗而出。

腰膝酸软，四肢厥冷。
体内的阴阳气血两虚，
致使肾气不足，不能充
养筋骨，因而腰膝酸
软。又因阳气亏虚，不
能化生为气血以温煦
肢体，因而四肢厥冷。

沉而无力为里
虚。沉而有力
为里实。



头晕耳鸣：
肾气不足，不足以充
养髓海，因而头晕、
耳鸣。

烦躁，失眠
肝血不足，血虚则虚
热内生，虚热内扰，
魂不守舍，因而烦
躁。如果又因肾阴亏
损，以至于心神与肾
阴不能相互交融，则
会引起失眠。

脉沉细。



细脉主气血两虚，
诸虚劳损。



中医师解说

分析：
沉脉轻取不应，重按始
得；细脉脉细如线，但应
指明显。

类型2: 肝肾阴虚之“更年期综合征虚证”

证候: 绝经前后, 腰膝酸软, 午后潮热, 手足心热, 胸胁满闷, 烦躁失眠, 口苦咽干, 或月经紊乱, 量稀少, 舌红, 苔少, 脉弦细数。

绝经前后, 腰膝酸软:

由于平素肝肾阴虚, 妇女于绝经前后, 先天之气更为虚衰, 肾气不能充肾养骨, 因而腰膝酸软。

午后潮热:

人体于午后时分, 体内的阳气渐弱而阴气渐强, 但因平素阴液亏损, 阴液不足则虚热偏胜, 多余的虚热外透于肌表, 因而午后潮热。

胸胁满闷:

肝之疏泄失常, 以至于气机宣泄不畅, 虚火阻遏胸阳, 因而胸胁满闷。

手足心热:

阴液虚损, 致使虚火内生, 且因阴虚则水不能制火, 因而火热之势透达于四肢末端, 出现手足心热。

弦脉主肝胆病, 主痰饮, 主诸痛, 主疟疾, 弦脉亦主虚。



月经紊乱, 量稀少:

妇女于绝经前后, 由于气血不足, 冲脉与任脉虚衰, 因而月经紊乱, 量稀少。

口苦咽干:

阴液亏虚, 致使虚火内生, 虚火夹着肝胆之气上逆于咽, 因而口苦、咽干。

烦躁, 失眠:

虚热内生, 虚热扰动心神, 因而烦躁; 如果又因肾阴亏损, 以至于心神与肾阴不能相互交融, 则会引起失眠。

脉弦细数。

细脉主气血两虚, 诸虚劳损。

数脉主热, 数脉亦主虚证。



中医师解说

分析:

弦脉端直而长, 如按琴弦; 细脉脉细如线, 但应指明显; 数脉一息五至以上。

四、脉经《卷八》

《脉经》由晋朝王叔和所撰，是中医史上第一部最为完善的脉学专著，奠定了近2000年来脉学的基础。因此，读者学习脉学，不可不知脉经的内容。脉经共分为十卷，分别阐述阴阳表里，三部九候，二十四脉，与伤寒病、杂病等的脉证治法，足见当时所积累的脉学经验，已是何等的丰富！

本章节录《卷八》临床上较为常见的内容，以让读者能一窥脉学的真正精髓所在。

1. 平卒中厥脉证第一

★名词解释

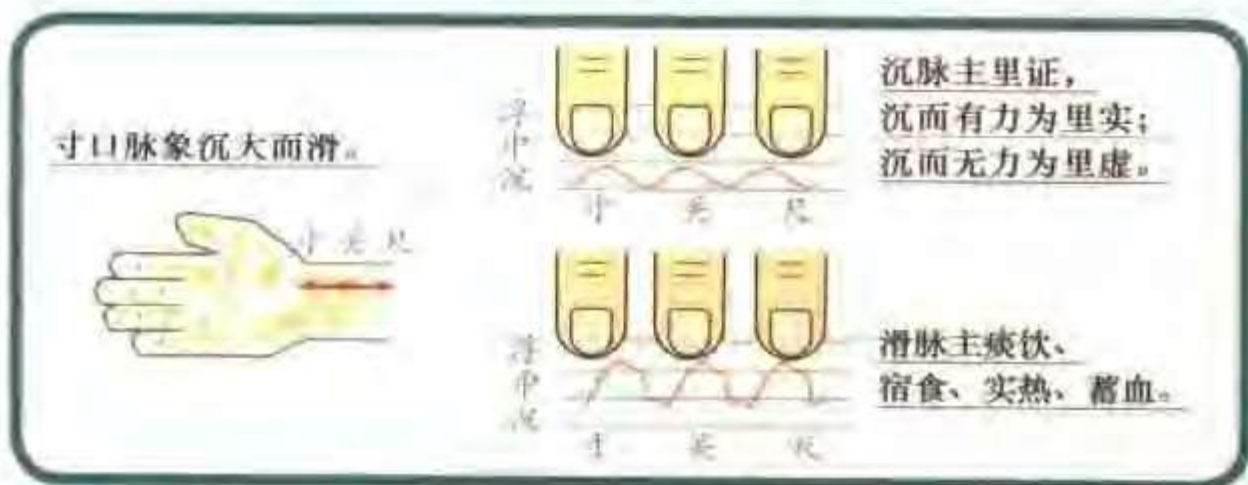
卒尸厥：卒，意为“突然”；厥，意为“厥证”。卒尸厥即为突然昏厥之意。

厥证：为平素因元气虚弱，或是因肝阳偏旺，或是因精神遭受过度刺激等因素，致使气机逆乱，所引起蒙闭心神的症状。主要表现为突然昏倒、不省人事、四肢厥冷等症状。

内容重点：论述卒尸厥（突然昏厥）的脉象与证候。

寸口脉象沉大而滑，脉沉大表示里有实邪，脉滑表示气机壅滞，因此表示为实邪与气机互相搏结。

突然昏厥的病证：如果邪气传变入于脏，病人就会死亡；如果邪气传变入于腑，病情就容易好转。



当病人突然昏厥后，出现唇口青紫，身体冰冷，这就是邪气入脏，病情较严重；如果出现周身温和，汗自出，这就是邪气入腑，病情较容易好转。

邪气入脏：

当病人突然昏厥后，出现唇口青紫，身体冰冷，这就是邪气入脏，病情较严重。



邪气入腑：

如果出现周身温和，汗自出，这就是邪气入腑，病情较容易好转。

2. 平痉湿喝脉证第二

★名词解释

痉病：主要病因为外邪侵袭人体后，从燥而化，或从风而化所致之症状。如果因热盛伤阴，或是误吐、误汗、误下时，也会引起痉病的产生。痉病的临床表现为身热足挛（恶寒时觉头热、面赤、目赤），颈项强急，背强反张，口噤不开，脉沉细或疾数等症状。

喝：（音“贺”）即中暑。指在夏季炎热气温中，因为中暑邪所引起的症状。表现为身热大汗（或无汗）、突然晕倒、恶心呕吐、烦躁、面色苍白、脉细数，或昏迷不醒、四肢抽搐、牙关紧闭等症状。

太阳病：六经病之一。主要是由于感受风寒，营卫失调所引起的病证，又可以分为表实和表虚二种证型。主要症状为恶寒、头痛项强，脉浮。

内容重点：论述痉病、湿病、喝病的脉象、证候与治疗用药。

风寒引起的太阳表实证，表现为发热，无汗反恶寒时，称为刚痉。

风寒引起的太阳表虚证，表现为发热，汗出而恶寒时，称为柔痉。

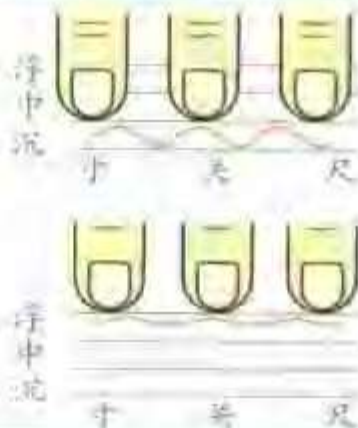
刚痉：
表现为发热，无汗，
反恶寒。



柔痉：
表现为发热，
汗出而恶寒。

太阳病发热，脉象应为浮脉，如果反而出现沉而细的脉象，表示为正气不足，邪盛正虚的痉病。

痉病：
正气不足，
邪盛正虚，
反而出现沉
而细的脉象。



沉脉主里证，
沉而有力为里实；
沉而无力为里虚。

细脉主气血两虚；
诸虚劳损。

太阳病表证，不可发汗太过。

太阳病表证，不可发汗太过。若大发其汗，则耗伤津液，筋脉失养，而变生痉病。

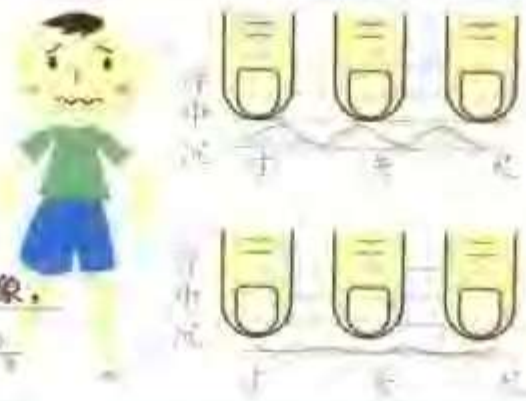
患太阳病表证者，表现为发热足寒，面赤，恶寒，颈项强直拘急，头部不由自主摇，称为痉病。

刚痉即将发作的征兆

太阳表实证，表现为无汗，小便反而减少，气逆上冲到胸部，牙关紧闭，不能开口讲话，这是刚痉即将发作的征兆，用葛根汤治之。

刚痉发病时，表现为胸部满闷，牙关紧闭，牙齿切磋有声，背部拱起不得卧床，两腿痉挛拘急，可以用大承气汤治疗。

痉病若经发汗后，如果脉象变得滑柔，如同蛇行一般，腹部不再因背强反张而凹陷，表示病情好转。如果脉象没有任何变化，反而变为沉伏的脉象时，表示病情没有改善。



沉脉主里证，
沉而有力为里实；
沉而无力为里虚。

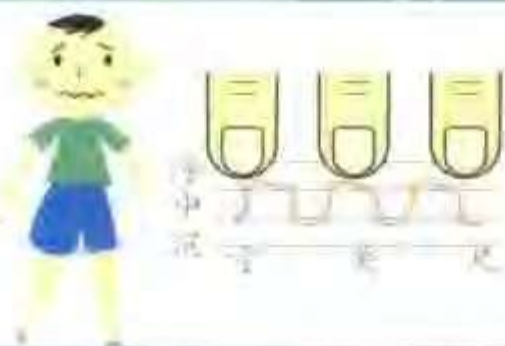
伏脉主邪闭，
厥证，痛证。

痉病若经发汗后，
反而变为沉伏的脉象，
表示病情没有改善。

痉病发病时，从寸部到尺部的脉象都表现得弦而有力。

痉病平时的脉象，从寸部到尺部都表现为沉伏而坚紧。

痉病发病时：
脉象弦而有力。



弦脉主肝胆病，主痰饮，主诸痛，主疟疾，弦脉亦主虚。

患风邪之病的人，如果误用泻下法，将会耗伤阴液，筋脉失其濡养而便生痉病。

患风邪之病的人，如果误用泻下法，将会耗伤阴液，筋脉失其濡养而便生痉病，如果再大发其汗，将会导致身体拘挛紧急。

太阳病表证，症状为发热汗出、恶风、头项强痛等证，身体颈项强直，脉象本应为浮脉，却出现沉迟的脉象，称为柔痉，用栝蒌桂枝汤治之。

患痉病的病人兼患有疮痍病，病情加重而难以治疗。

若患痉病的病人兼患有疮痍病，由于疮痍脓液浸渍，津血早已亏损，若再患痉病，则必血枯津伤，病情加重而难以治疗。

患疮痍病兼患有身体疼痛的太阳病时，不能用发汗法，否则会耗损津液，而变生痉病。

太阳病，如果出现关节疼痛，烦躁不安，脉象沉缓时，这是因为湿邪停滞而成为痹证。



如果浑身疼痛，发热，尤其在傍晚时更加严重，称为风湿，这是因为出汗时感受风湿所引起的。

患湿痹的病人，全身疼痛发热，皮肤颜色暗黄，好像被烟熏过一般。

患湿痹的人，如果误用泻下法，变生呃逆，或胸膈满闷。

患湿病的人，头部容易出汗，背部强直，恶寒而想盖被取暖。如果误用泻下法，将会变生为呃逆，或胸膈满闷。小便不利，舌苔湿润白滑，这是因为丹田有热，胸部上焦有寒，因此口虽渴却不想饮水，但又感到口燥，这是由于水湿内阻，邪热壅滞所引起的。

因为丹田有热，胸部上焦有寒，因此口虽渴却不想饮水，但又感到口燥，患湿病的人，如果误用泻下法，造成额头上出汗，微微喘气，小便不利，是阴阳逆脱的死证；如果下利清谷不止，也是阴阳两竭的死证。



中医师解说

M E A N I N G F U L

Q 风湿相搏，身体疼痛，应当用发汗法治之。但如果遇到阴雨天，老师曾说，此时虽然可用发汗法治疗，但病情却仍没有改善，这是什么原因呢？

A 这是因为大发其汗，虽然可以祛散风邪，但湿邪仍未除，因此病情不能痊愈。

治疗湿病，应当微微发汗，使其营卫畅通，才可以同时祛除风湿之邪。

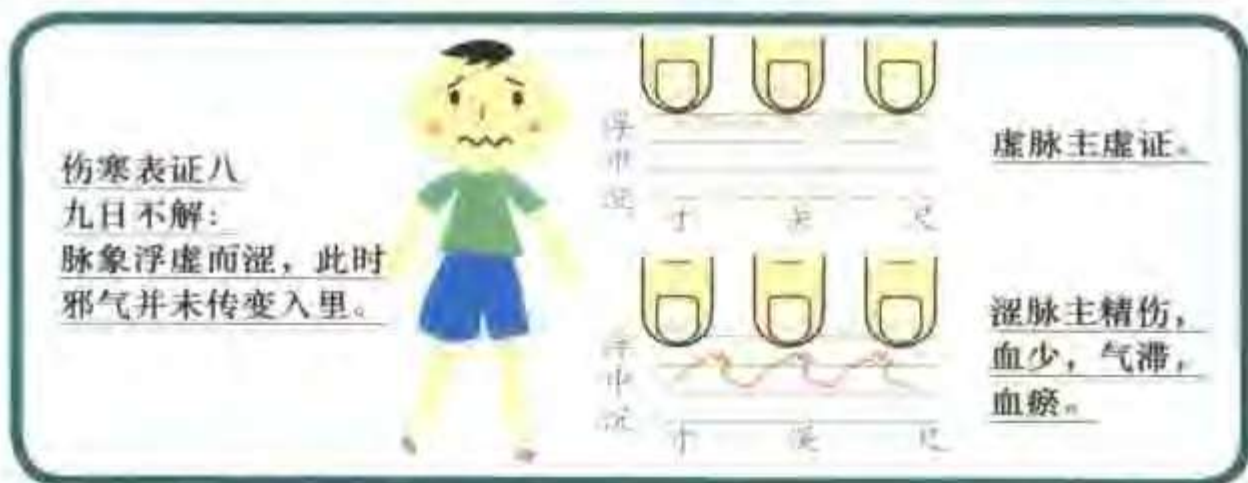
患湿痹的病人，不能使她发汗，大发其汗。

患湿痹的病人，身体疼痛，烦躁不安，可以用麻黄汤加白术200克治疗，使微微汗出；不能使用火攻，大发其汗。

风湿病，脉浮身重，汗出恶风，可用防己汤除湿治疗。

病人气喘，头痛，鼻塞而心烦，脉象大，饮食正常，肠胃和畅，表示疾病没有传变。如果寒湿之邪侵犯头部，引起鼻塞，可以将药放入鼻中，宣泄上焦，使肺气通利来治疗。

伤寒表证八九日不解，风湿互相搏聚，周身疼痛，不能自由转侧身体，但没有呕吐和口渴的症状，脉象浮虚而涩，此时邪气并未传变入里，用桂枝附子汤治疗。如果病人大便干燥，小便不利，可用白术附子汤治疗。



★名词解释

喝病：主要是因人体感受暑热所引起的病症。由于暑热熏蒸，汗出多而腠理空疏，因而感到恶寒，怕冷。由于暑热为火热之邪，因而患者出现身热。由于暑热伤津，因而患者出现口渴。喝病的脉象表现为弦细，或是芤迟，此时应用白虎汤治疗。

3. 平阳毒阴独百合狐惑脉证第三

★名词解释

阴阳毒：即“疫毒”，指具有传染性的致病邪气，当人感受之后，就可能发生疫病的流行。

疫毒可以分为阳毒和阴毒，阳毒因热邪壅滞于上，以面赤斑斑如锦纹、咽喉痛、吐脓血为主要症状。阴毒为阴邪阻滞经脉，以面目色青、身痛如被打伤、咽喉痛为主要症状。

百合病：由于心肺阴虚所引起的病证。临床表现为沉默少言，欲睡不能眠，欲行不能走，欲食又不能食，寒热似有似无，神志有时不安，或作自言自语，伴有口苦、尿赤，脉数等内热见症。类似于神经衰弱，或是某些热病后期所致的虚弱证。

狐惑病：主要是由于湿热毒邪侵袭人体，湿热内蕴所引起的病证。症状表现为咽喉部及前后阴溃腐，因患者通常伴有神情惑乱不定，躺卧不觉安稳等症状，因此称为“狐惑病”。

内容重点：论述阴阳毒病、百合病、狐惑病的脉象、证候与治疗用药。

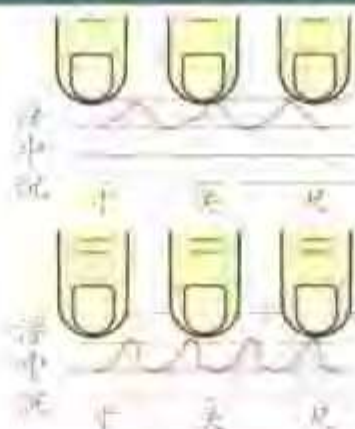
感受疫毒所引起的阳毒病，身体沉重，腰背疼痛，烦闷不宁，狂言乱语，或是到处走动，或是像见了鬼一般，或是吐血下利，脉象浮大而数，脸上起红斑，咽喉疼痛，口吐脓血。

感受阳毒病，如果患者正气未衰，在五天以内还可以治疗，若是超过了七天，阳毒炽盛而正气衰竭，就难以治疗。

有患伤寒病的病人，只一两天就传变成阳毒证，也有因服药或误吐或误下的病人，传变成阳毒证，可用升麻汤治疗。

伤寒病传变成阳毒证，因服药或误吐或误下传变成阳毒证。

阳毒病：
脉象浮大而数。



浮脉主表证
(脉必浮而有力)，
也可见于风水。

数脉主热；
数脉亦主虚证。

感受疫毒所引起的阴毒病，身体沉重，背部强直，腹中绞痛，咽喉疼痛。如果疫毒上攻于心，则心下痞硬，呼吸气短，呕逆，面色黧黑，口唇青紫，手足冰凉，脉象沉细紧数，周身疼痛像是被打一般。

如果患者正气未衰，在五天以内还可以治疗，若是超过了七天，阴毒炽盛而正气衰竭，就难以治疗。

有患伤寒病的病人，才只一两天就传变成阴毒证，也有因服药不对症的病人，六七天以上至十天以内，由于治疗不当，而传变成阴毒证，可以用甘草汤治疗。

伤寒病传变成阴毒证，疫毒或误吐误下传变成阴毒证。

阴毒病：
脉象沉细紧数。



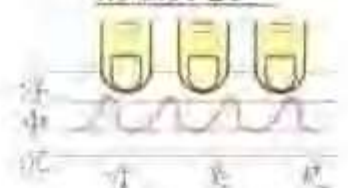
沉脉主里证，沉而有力为里实；
沉而无力为里虚。



紧脉主寒，
主痛，主宿食。



细脉主气血两虚；
诸虚劳损。

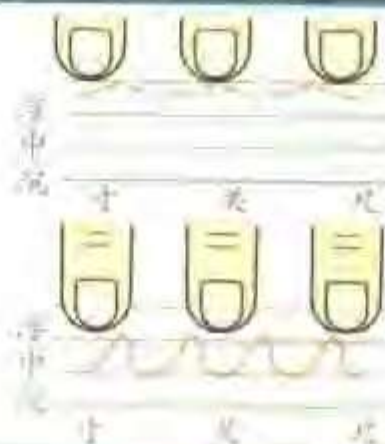


数脉主热；
数脉亦主虚证。

百合病的患者，经常沉默少言，想睡不能睡，外表看似健康，想走路又走不动，想吃又吃不下，有时食欲好，有时又怕闻到食物的味道，似乎怕冷却又不是真的发冷，似乎发热却又不是真的发热，早晨起床后口中发苦，小便黄赤，表面上似乎没有病证，但却出现微数的脉象，这是因为百合病主要为心肺受损，病及血脉，应当根据不同的证候来进行治疗。

百合病主要因心肺受损，病及血脉。

百合病：
脉象微数。



微脉主气血诸虚。

数脉主热，
数脉亦主虚证。

百合病若出现阴证，应用补阳法治疗；百合病若出现阳证，宜用养阴法治疗。

百合病若出现阴证，应用补阳法治疗；百合病若出现阳证，宜用养阴法治疗。如果出现阳证，反而用补阳法，又以发汗法治疗，将会重伤阴液，致使病情更难以治愈；若表现为阴证，而反用养阴法，又加用泻下法治疗，将会重伤阳气，致使病情更难以治愈。

★名词解释

阳证：凡与“阳”的属性具有相同特性的证候，称为阳证。如表证、热证、实证皆属于阳证的范畴。

临床常见阳证的症状：面色赤红，肌肤灼热，烦躁不安，大便秘结，小便短赤，舌质红绛，苔黄，脉象浮数或洪大。

阴证：凡与“阴”的属性具有相同特性的证候，称为阴证。如里证、寒证、虚证皆属于阴证的范畴。

临床常见阴证的症状：面色淡白，精神萎靡，形寒肢冷，倦怠无力，语音低弱，口淡不渴，小便清长，舌质淡红，苔白，脉沉迟或弱或细涩。

狐惑病是因为湿热毒邪侵袭，由于湿热内蕴所引起。

狐惑病的患者，出现恶寒发热，似乎像是伤寒证，精神不振而想睡，却又不能闭目而睡，躺卧不觉安稳，这是因为湿热毒邪侵袭，由于湿热内蕴所引起。如果喉部发生蚀烂的，称为惑病；前后二阴发生蚀烂的，称为狐病。

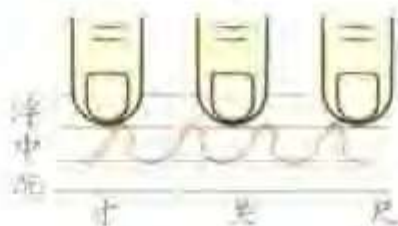
如果喉部发生蚀烂的，称为惑病；前后二阴发生蚀烂的，称为狐病。

狐惑病的病人，不仅不想吃东西，而且怕闻到食物的气味，面色发红或发白，或发黑。如果湿热毒邪侵蚀于咽喉，就会使声音嘶哑；如果湿热毒邪侵蚀于二阴，就会使咽喉干涸。

上部咽喉被侵蚀时，可以用**泻心汤**治疗；下阴部被侵蚀时，用**苦参汤**熏洗；肛门被侵蚀时，用**雄黄**熏患处治疗。

狐惑病的脓疱形成时，表现为脉数，不发热，烦闷不安，精神不振而想睡，汗出。在患病的三四天内，双目发红像是鸡的眼睛一样，在患病的七八天内，内、外眼角出现黄黑色，此时毒邪结聚于头目，对脾胃的影响较轻，因此病人食欲正常，应用**赤小豆当归散**治疗。

狐惑病：
脓疱形成时，
表现为脉数。



数脉主热；
数脉亦主虚证。

4. 平霍乱转筋脉证第四

内容重点：论述霍乱病、转筋的脉象、证候。



中医科解说

H E A L T H F U L

Q. 患霍乱病时，会出现什么症状？

A. 呕吐兼有泄泻，称为霍乱病。

Q. 如果病人出现发热、头痛、全身疼痛，是寒后，隔几天又出现呕吐下利的症状，这是什么病？

A. 这是霍乱病。霍乱病在吐泻停止之后，又会出现发热的症状。如果仅是感受寒邪的伤寒证，脉象本应浮紧，现在却出现微涩脉，这是因为霍乱病的病人，同时又感受寒邪，病邪经过四五天的时间，传变到四肢上，因此又出现呕吐下利的症状。

患转筋病的病人臂、腿筋脉挛急，脉象从寸部到尺部，皆为微弦的脉象，严重时从两胁肋筋牵引小腹作痛，用鸡屎白散治疗。

霍乱病的病人，
同时又感受寒邪，
出现微涩脉。



微脉主气血诸虚。

涩脉主精伤，血少，气滞，血瘀。

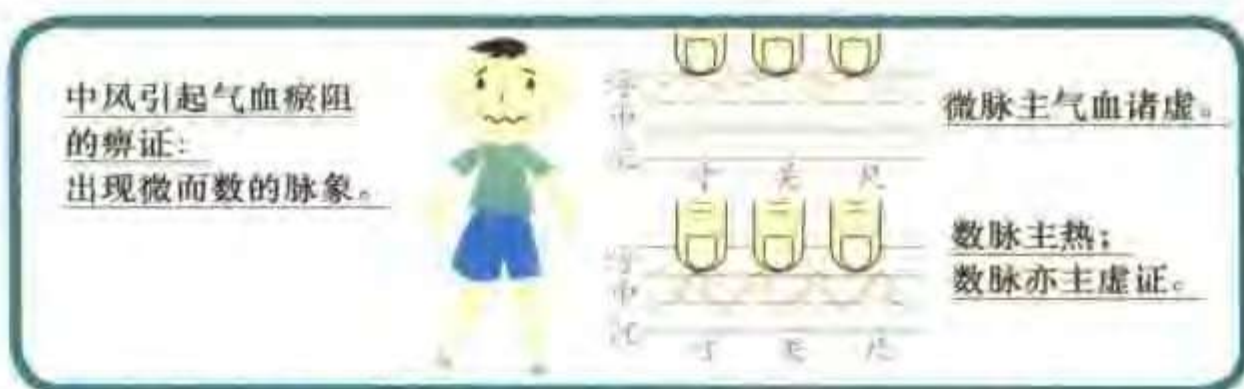
5. 平中风厉节脉证第五

★名词解释

厉节病：由于平素肝肾亏伤，又因感受外邪，病邪缠聚而生热，便成为厉节病。表现为身体消瘦，足胫肿大，关节疼痛，不能随意屈伸。

内容重点：论述中风、厉节病的脉证与治疗。

中风引起的病证，通常是身体某侧出现行动不便，或是某侧上肢不能活动，这是气血瘀阻的辨证，此时应出现微而数的脉象。



头痛且出现滑脉，是外感中风，应兼有表证；内伤中风的应该出现虚弱的脉象。

《金匮要略》：寸口脉浮而紧，紧主中风，浮主里虚。

寸口部出现浮紧的脉象，紧主中风寒，浮是里虚，虚与寒邪相互搏结，病邪停滞于皮肤。脉浮表示血气亏虚，血气亏虚则络脉空虚而不能抗邪，因此邪气无法外泄而停滞于左侧或右侧，受邪的一侧，因络脉闭塞，脉象呈现弛缓的现象，正常的一侧，则相对的反而是呈现筋脉拘紧的现象，由于健侧牵引患侧，所以表现出某一侧口眼歪斜，行动不便。

受邪的一侧，由于筋脉拘紧，因此是弛缓的现象，正常的一侧，则相对的反而是呈现筋脉拘紧的现象。

如果病邪中于络脉，致使营气不能濡养肌表，肌肤就会麻木不仁；

如果病邪中于经脉，致使血气不能濡养肢体，肢体就会沉重而不能抬举；

如果病邪中于腑，就会出现昏不识人的症状；

如果病邪中于脏，就会出现不能言语，口角流涎的症状。



迟脉主寒, 缓脉主湿。

寸口部出现迟缓的脉象, 迟脉属寒, 缓脉为虚, 营阴亏虚表示亡血, 卫气虚寒则易中风。

如果病邪中于经脉, 就会出现身体发痒, 皮肤隐疹; 如果心气不足而感受病邪, 就会出现胸膈满闷, 呼吸气短的症状。



★名词解释

趺阳脉:三部九候诊法的切诊部位之一, 位于足背踝关节前横纹的两筋之间, 约为解溪穴前1.5寸的动脉搏动处。

少阴脉:三部九候诊法的切诊部位之一, 位于足内踝关节横纹上1.5寸的动脉搏动处, 约为太溪穴上之1.5寸之处。

趺阳脉候胃气，少阴脉候心、肾之脉。

趺阳脉候胃气，如果趺阳脉浮而滑，滑脉为胃热炽盛，浮脉为表证，因此自汗而出。

少阴脉候心、肾之脉，如果少阴脉浮而弱，弱脉为阴血不足，浮脉浮为表证，邪气与血相互搏结，导致经脉痹阻，筋骨失养，因此肌腠疼痛剧烈。

邪气与血相互搏结，导致经脉痹阻，筋骨失养，因此肌腠疼痛剧烈。

肥胖之人的脉象通常涩小无力，容易呼吸气短，多汗，关节疼痛不能屈伸，这是因为饮酒出汗后又被风邪所伤，风与湿相互搏结所引起的。

沉为病在里，主肾气不足，弱为肝血不足。

寸口部出现沉弱的脉象，沉为病在里，主肾气不足，肾主骨；弱为肝血不足，肝主筋，肝肾不足，是历节病的病因。

历节病：
寸口部出现沉弱的脉象。



沉脉主里证，
沉而有力为里实；
沉而无力为里虚。

弱脉主气血亏虚。

过食酸味则伤肝，肝伤则筋伤弛缓不用。

吃太多酸的食物则伤肝，肝伤则筋伤弛缓不用，因此不能随意运动，称为“泄”。

过食咸味则伤肾，肾伤则骨伤髓枯。

吃太多咸食则伤肾，肾伤则骨伤髓枯，因此瘦弱不能行立，称为“枯”。

历节病，肝肾俱伤，如果再感受外邪，病邪壅聚而生热，便成为历节病。

肝肾俱伤，营血卫气衰竭，三焦不能运行气血，四肢失于濡养，因此身体消瘦，只有足胫肿大，流出黄汗，足胫发冷。

如果再感受外邪，病邪壅聚而生热，便成为历节病。历节病的病人，关节疼痛，不能随意屈伸，可用**乌头汤**治疗。

历节病的病人，如果周身肢节疼痛，身体逐渐消瘦，脚肿得似乎要脱离一般，头目昏眩，呼吸气短，胃气上逆而欲呕吐，可用**桂枝芍药知母汤**治之。

6. 平血痹虚劳脉证第六

★ 名词解释

痹证：为风寒湿三气侵袭人体的脏腑或经络而引起的病症，主要症状为关节或肌肉肿胀、疼痛等症狀。类似于风湿性关节炎或类风湿性关节炎等病。

内容重点：论述血痹、虚劳病的证候、脉象及治疗。



中医师解说

H E A L T H Y H P U L

Q. 血痹病是如何得的?

A. 凡是养尊处优的人，肌肉虽然丰腴，筋骨却很脆弱，由于疲劳汗出，睡眠时又辗转反侧，难以入睡，加上风寒侵袭，因此容易得血痹病。表面上血痹病似乎与中风一样，但血痹病的脉象微涩，在寸口、关上出现微紧的脉象，此时应当用针刺来接引阳气，调和血脉以祛寒湿之气，病就能痊愈。

注：中风引起的气血凝阻的痹证，出现微而数的脉象，不同于血痹病的脉象。

血痹病的脉象微涩，在寸口、关上出现微紧的脉象。



湿脉主精伤，血少，气滞，血瘀。

紧脉主寒，主痛，主宿食。

血痹病的病人，阴阳虚衰，寸口、关上的脉象微弱，尺中的脉象小而紧，肌肉麻木不仁，与风痹病证有点类似，用黄芪桂枝五物汤治之。

男子在表面上并没有异常的病证，但是脉象大而无方，是阴虚阳浮的虚劳病；如果脉象极虚，表示为精气内损的虚劳病。

虚劳病：
脉象大而无力的。



芤脉主失血或阴伤。

虚劳病，脉象浮大无力，是阴虚而阳浮越于外。

男子患虚劳病，脉象浮大无力，是阴虚而阳浮越于外，阴虚则生内热，因此手足烦热，在春夏火盛时，病情会加重，在秋冬时，阳气内藏，病情会减轻。由于阴寒内盛，精关不固，因此精液自出，两腿酸痛消瘦而难以行走，并且少腹虚满。

人到了五六十岁时，脉象浮大无力，脊背由于血痹而麻木，腹中肠鸣，腋下或颈的两旁结聚成瘰核，这是因为劳伤而引起的虚劳病。

脉象微细的脉象，表示容易盗汗。

男子在表面上并没有异常的病证，但却出现虚弱微细的脉象，表示容易盗汗。

男子面色无华，表示漏和失血过多，如果呼吸急促而心悸，脉象浮大无力，乃是里虚的缘故。

男子出现虚、沉、弦的脉象，是虚劳病引起的气血两虚。男子出现虚、沉、弦的脉象，虽没有外感寒热的症状，却出现短气腹痛，小便不利，面色苍白，眼睛昏花，容易衄血，小腹胀满，这是虚劳病引起的气血两虚。

男子出现虚、沉、弦的脉象，是虚劳病引起的气血两虚。

男子出现微弱而涩的脉象，表示不能生子，这是因为精气不足，精液清稀冰冷的缘故。

男子出现微弱而涩的脉象，表示不能生子。

经常遗精的病人，由于精液损耗太过，因此小腹部疼痛，外阴部寒冷，眼眶疼痛，头发脱落，脉象极为虚弱，如果出现芤迟的脉象，表示失精、亡血，或下利清谷。

遗精：
男子出现微弱而涩的脉象，表示不能生子。



弱脉主气血亏虚。

涩脉主精伤，血少，气滞，血瘀。

第二站：微紧的脉象，表示阴阳两虚。

如果出现芤、动、微紧的脉象，表示阴阳两虚，男子容易遗精，女子则容易梦见与人交合，此时用桂枝龙骨牡蛎汤治之。

第三站：沉小而迟的脉象，表示脾肾虚衰。

如果出现沉小而迟的脉象，表示脾肾虚衰，称为脱气，患脱气的病人走路就会气喘，手脚发冷，腹部胀满，大便稀溏，吃东西也不能消化。

脱气：
沉小而迟的脉象，表示脾肾虚衰。



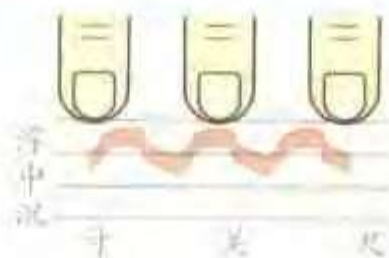
沉脉主里证，沉而有力为里实；沉而无力为里虚。

迟脉主寒证。迟而有力为寒实证（注：或为实热证）。迟而无力为虚寒证。

弦大的脉象，是精血亏损的虚劳脉。

如果出现弦大的脉象，是精血亏损的虚劳脉象。脉象虽弦，但重按则减弱；脉象虽大却大而中空。重按则减弱为寒，大而中空为虚，是虚寒相搏结，称为革脉。妇人出现革脉则容易小产或月经淋漓不断，男子则为失血或失精。

革脉：
精血亏损的虚
劳脉象。



革脉主亡血，失精。

7. 平消渴小便利淋脉证第七

★名词解释

消渴病：即糖尿病，主要是由于嗜酒和恣食甘肥，脾胃湿热，或是因五志过极，郁而化火，或是因纵欲过度，虚火妄动，肾精耗损，表现为口渴多饮，吃多，尿多的症状，根据症状的不同，又可以分为上消、中消、下消。

内容重点：论述消渴、小便利、淋证的证候、脉象及治疗。



如果寸口部出现浮而迟的脉象，浮为阳虚气浮，卫气不足，迟为血脉不充，营阴亏虚。营卫两虚，燥热内生，于是形成消渴病。



如果趺阳脉出现浮而数的现象，浮为胃气有余，数为胃热亢盛，胃热气盛则虽吃得多却容易饥饿，气有余便是火，水为火迫而偏渗膀胱，则出现小便频数，胃热与胃气互相搏结，于是形成食多、饮多、小便频数的消渴证。

水太多而偏渗膀胱，则出现小便频数。

男子患消渴病，口渴喜饮，由于肾阳虚损，不能蒸腾津液以化水，因此虽饮水一斗，亦小便一斗，可用肾气丸治之。

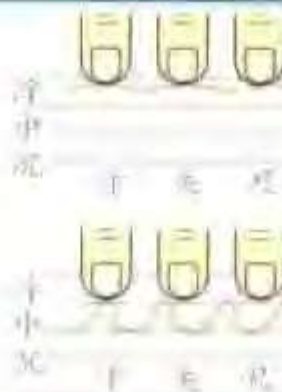


中医解释说

邪热结滞在下焦，就会出现尿血，小便淋沥不通，由于膀胱热盛，甚至会转变为石淋病，也就是俗称的“尿路结石”，煎熬尿液而形成砂石，形如小米粒，梗阻尿道，使小便涩滞难出，小腹拘急疼痛而牵引至脐部。

如果寸口部出现细而数的脉象，脉数主热，脉细主寒，这是由于呕吐所引起的脾虚胃热证。

脾虚胃热证：
寸口部出现细而数的脉象。



细脉主气血两虚；
诸虚劳损。

数脉主热；
数脉亦主虚证。

如果趺阳脉出现浮而迟的脉象，是胃中有邪热。

如果趺阳脉出现浮而迟的脉象，浮为阳虚气浮，卫气不足，迟为血脉不充，营阴亏虚。营卫两虚，燥热内生，于是形成消渴病。

如果少阴脉出现数脉，是肾阴虚而邪热客于下焦。

如果少阴脉出现数脉，是肾阴虚而邪热客于下焦。妇人容易阴部生疮，男子容易患小便涩滞不利而疼痛的气淋病。

淋病的病人，不可使用发汗法。

淋病的病人，不可使用发汗法，因为淋病多由于肾阴虚损，膀胱热盛所引起，若大发其汗，则会耗伤阴血，而引起尿血。

8. 平黄疸寒热疟脉证第九

★名词解释

黄疸：由于脾胃湿邪内蕴，胃腑失调，胆液外溢于肌表所引起的病症。以身黄、目黄、小便黄为主要症状。临床上又分为阳黄和阴黄两大类。

内容重点：论述黄疸、疟疾、疟母病的证候、脉象及治疗。

黄疸病的病人，如果寸口部没有脉象，口唇鼻部发冷，是心脾气绝的证候，难以治疗。

脉沉，口渴想喝水，小便不利，是湿热蕴结于中焦，因此出现发黄。腹部胀满，身体发黄晦暗不明，烦躁不能安眠，为黄疸病的症状。

患黄疸的病人，发热，烦躁气喘，胸胁满闷，病因为湿热所引起，如果误用大攻使其发汗，反使热不得外解，两热相加，反而加重发热。然而，黄疸病是因湿邪所致，周身发热发黄，特别是腹内发热，为里热，应当用泻下法。

黄疸病，以18天作为痊愈的时间，治疗在10天时，病情应当好转，如果病情反而加重，就很难治疗。

黄疸病，出现口渴症状的，为湿热化燥，表示病邪入里，所以难治；如果口不渴，是病邪尚未深入，为热不盛，因此可以治疗。如果病邪传变入于营血阴分，会发生呕吐；如果病邪传变入于卫气阳分，表现为寒颤而发热。

黄疸病，应当以通利小便为主。如果脉浮者，是病邪还在肌表，应当用发汗法，以桂枝加茵陈汤治疗。

如果男子出现周身发黄，并且小便通利，这种发黄，并非湿热所致，而是阴阳两虚的虚劳发黄，应用小建中汤治疗。

黄疸病、腹部胀满，小便不利而赤黄，自汗出，这表示表证已解而里热仍炽的实证，应当用泻下法治疗，以**大黄黄柏栀子芒硝汤**。

黄疸病，小便颜色正常而且通利，腹部胀满，气喘短气，为中焦虚寒，寒湿内蕴所致，不可误以为实热而清热，否则伤及中阳，必会变生呃逆，若已出现呃逆，应当以用**小半夏汤**治疗。

患酒疸病的病人，病因为嗜酒伤中，湿热内蕴。

患酒疸病的病人，病因为嗜酒伤中，湿热内蕴，因此小便不利，心中烦闷不安，足下发热，胃气上逆而不能饮食，时常恶心欲吐，称为酒疸。

患酒疸病的病人，有些不会出现发热，而是神情安静，言语不错乱，腹部胀满，想呕吐，鼻腔干燥。如果脉象为浮脉者，说明病势在上，可以用吐法，脉象为沉弦脉者，说明病势在下，可以用下法。

患酒疸的病人，如果脉象为浮脉者，说明病势在上，可以用吐法，脉象为沉弦脉者，说明病势在下，可以用下法。

酒疸病的病人，心中烦热，想呕吐的，为病邪上逆，应当使用吐法，引邪而出。

酒疸病的病人，周身皮肤发黄，心下痞阻而烦满。

酒疸病，如果以泻下法治疗，时间久了传变为黑疸，面色黧黑，双目发青，心中灼热，像是吃了腌蒜，大便色黑如柏油，皮肤麻木不仁，脉象浮弱，面目虽黑仍带黄色，这是由于误下后所引起的黑疸。

各虚弱的病人，寸口脉微而弱，微脉主阳气微，弱脉主血虚。

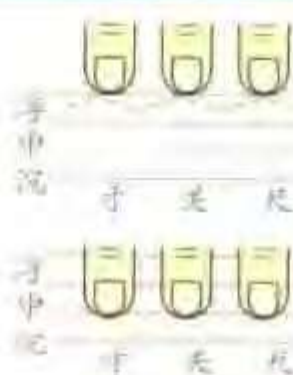
如果寸口脉微而弱，微脉主阳气微，就会恶寒，弱脉主血虚，血虚就会发热，应该发热时而不发热，就会出现骨节酸痛，应该烦躁而不烦躁，就会出现大汗出的症状。如果趺阳脉缓而迟，表示脾气虚弱，而胃气反强。

因为邪热善于消化食物，而不是胃气强盛。

如果少阴脉微，微脉主伤精，精血不足，肾阳衰微，因此阴寒内盛，原本病人的脾胃会虚弱，但是病人反而食欲好，吃饱后却感到腹部烦闷，胀满而发热。这是因为邪热善于消化食物，而不是胃气强盛，所以才会在发病时，感到饥饿，吃饱后却发热腹满，这是因为肾精、脾阳受损，因此越吃却越瘦，称为谷寒热。

因为胃弱，脾阳受损，所以越吃却越瘦，称为谷寒热。

谷寒热：
寸口脉微而弱。



微脉主气血诸虚。

弱脉主气血亏虚。

谷疸的病人，出现迟脉，吃了东西却吃不饱，吃饱了却感觉烦闷。

阳明病患会出现迟脉，吃了东西却吃不饱，吃饱了却感觉烦闷。如果出现脉重者，也会有小便不利的症状，这种病称为谷疸。如果以泻下法治疗，腹胀仍不能改善，这是因为脾胃虚寒，不能运化水谷精微的缘故。

★名词解释

阳明病：六经病之一。主要是由于热盛伤津，热结胃肠所引起的病证，主要症状为腹满拒按、大便闭、潮热、甚则谵语。脉沉且有力。



中风脉解

H E A L T H F U L

如果寸口脉浮而慢，浮脉主风邪，缓脉主痹证。痹证并不是中风，而是湿热内蕴于脾，因此四肢烦善不安，如果湿热蕴久就会变生黄疸，湿热溢于肌表就会发黄。

如果跌阳脉紧而数，数脉主热，胃热炽盛就会消谷善饥，紧脉主寒，寒盛则伤脾。因此吃饱后就感到腹部胀满，尺部出现浮脉主伤肾；跌阳脉紧主脾伤。由于风邪与寒邪相互搏结，吃东西后，邪气上冲就会感到晕眩，这是因为食物不得运化，痞阻于胃中，胃中浊气壅聚于下焦，致使小便不利，湿热带下注于膀胱，湿热带外溢于肌肤，因此周身发黄，称为谷疸。

女劳疸的病人，是由于房劳伤肾，虚劳所致。

如果病人额头发黑，微微汗出，手脚心发热，到傍晚时发病，膀胱憋急，小便通利，这是由于房劳伤肾，虚劳所致，并不是湿热带引起的，称为女劳疸。如果病情严重，出现腹部肿胀如水一般，表示脾肾俱衰，因此说“不治”。

黄疸病的病人，如果在傍晚时发热，病因为湿热带内蕴。

如果病人在傍晚时不发热，反而恶寒，就是患了女劳疸病。

黄疸病的病人，如果在傍晚时发热，病因为湿热带内蕴。如果病人在傍晚时不发热，反而恶寒，就是患了女劳疸病。表现为膀胱憋急，小腹胀满，周身发黄，额头发黑，足下发热，如果日久不愈，就会传变为黑疸，腹部肿胀如水一般，大便必然是黑色，并且时常溏泻稀薄，这都是因为房劳所引起的，而不是水肿病。如果腹部胀满的病人，很难治愈，可以用**硝石矾石散**治疗。

疟病的脉象大多为弦脉，如果为弦数脉，表示邪热重，如果为弦迟脉，表示寒邪盛。

如果出现弦而微紧的脉象，表示里有食滞，可用泻下法治疗；如果出现弦迟的脉象，应当用温法治疗；如果出现紧数的脉象，表示外感风寒，可以用汗法，针灸治疗；如果出现浮大的脉象，可以用吐法；如果出现弦数的脉象，表示热极而生风，应当用甘寒饮食来治疗。

弦数脉，表示邪热重。

弦迟脉，表示寒邪盛。

微紧的脉象，表示里有食滞，可用泻下法治疗。

弦迟脉，应当用温法治疗。

紧数脉，表示外感风寒，可以用汗法，针灸治疗。

浮大脉，可以用催吐。

弦数脉，表示热极而生风，应当用甘寒饮食来治疗。



弦脉主肝胆病，
主痰饮，主诸痛，
主疟疾，弦脉亦
主虚。

紧脉主寒，
主痛、主宿食。



迟脉主寒证。
迟而有力为寒实证
(注：或为实热证)。
迟而无力为虚寒证。

数脉主热；
数脉亦主虚证。



浮脉主表证（脉必浮
而有力），也可见于风水。

如果疟病日久不愈，疟邪与瘀血痰浊结聚于胁下，而形成疟瘕癥瘤，称为疟母，应以鳖甲煎丸治疗。

患疟病而发热者，称为温疟，表现为脉象平和，发热，不恶寒，关节疼痛，时常作呕，早晨发热而到傍晚时缓解，或傍晚时发热而次晨时缓解，温疟应当以白虎加桂枝汤治疗。

患疟病而恶寒者，大都由于阳虚寒盛，致使疟邪留滞于阴分，称为牡疟，应当以蜀漆散治之。

9. 平胸痹心痛短气贲豚脉证第十

★名词解释

贲豚病：贲，音 biān，同“奔”字，主要是因为受到惊恐刺激所引起的病症。患者自觉有股气从小腹直上冲到咽喉，胸腹疼痛，往来寒热，发病时疼痛像要死一样，但过后又恢复正常。

内容重点：论述胸痹、心痛短气、贲豚病的证候、脉象及治疗。



中医师解说

诊断时应当留意脉象的大过和不至，出现脉微阳弦的脉象，为上焦阳气不足，下焦阴寒太盛，凌厥胸中阳气痹阻不通，因此形成胸痹病。

胸痹病的病人，喘息短气，咳嗽，胸背痛，寸口脉沉而迟，关上稍微紧数，是胸阳不振，中焦停饮，阴寒上乘于胸中所致，用枳实薤白桂枝汤治之。

寸口脉沉而迟，
关上稍微紧数。



紧脉主寒，
主痛主宿食。



沉脉主里证，
沉而有力为里实，
沉而无力为里虚。

迟脉主寒证。
迟而有力为寒实证
(注：或为实热证)，
迟而无力为虚寒证。

数脉主热，
数脉亦主虚证。

胸痹病未发作时，与正常人一样，但发病时胸痛，短气，是阴寒阻滞胸中所致，属于实证。

贲豚病的病人，自觉有股气从小腹直上冲到咽喉，发病时疼痛像要死一样，但过后又恢复正常。这是因为受到惊恐刺激所引起的。

贲豚病发病时，表现为气逆上冲，胸腹疼痛，往来寒热，用贲豚汤治之。



W E A L T H I S I

病证中有贲豚、吐衄血、惊怖、火邪，这四种病，都是由于受到惊恐刺激所引起的。

10. 平腹满寒疝宿食脉证第十一

内容重点：论述腹满、寒疝、宿食病的证候、脉象及治疗。

如果趺阳脉出现弦脉，应当脘腹胀满，如果脘腹不胀满，就会大便艰难，胁部疼痛。这是因为虚寒从下往上逆行的缘故，应当用温药治疗。

腹部胀满的病人，如果按压不时痛者属虚证，如果按压时疼痛者属实证。

腹部胀满的病人，如果按压不时痛者属虚证；如果按压时疼痛者属实证，可以用泻下法治疗，如果舌苔黄说明里有实热，用泻下法下之，黄苔就会退去。

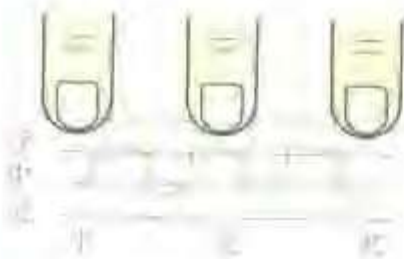
腹部胀满的病人，有时感觉减轻，有时又胀满不适，这是因为脾胃虚寒的缘故，应当以温药治疗。

如果趺阳脉出现紧而浮的脉象，脉紧为寒邪，主痛；脉浮主虚，为脾阳气虚，因此出现肠鸣，紧脉还可表示腹部坚硬胀满。

脉象有力是阳证，表示心下坚硬，如果脉象大而紧，为阳中有阴，虚实夹杂。

腹部胀满的病人，如果两侧的脉象皆为弦而迟，表示心下坚硬。如果脉象大而紧，为阳中有阴，虚实夹杂，可以用泻下法。如果腹部胀满，兼有疼痛的，为里实证，应当用泻下法治疗。

如果两侧的脉象为弦而迟，表示心下坚硬。

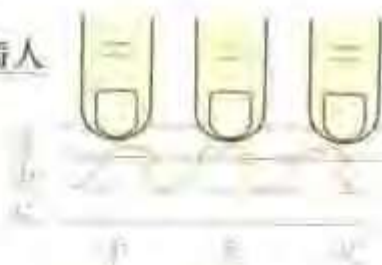


弦脉主肝胆病，主痰饮，主诸痛，主疟疾；弦脉亦主虚。



腹部胀满的病人

如果脉象大而紧，为阳中有阴，虚实夹杂。



紧脉脉来绷急，状如牵绳转索。

腹部胀满而没有改善，或是仅有稍有减轻而不能真正改善，说明里实之邪未去，应当以泻下法治疗。

腹满病的病人，发热10日后，脉象浮而数，饮食像从前一样，说明病邪已从表入里。

腹满病的病人，发热10日后，脉象浮而数，饮食像从前一样，说明病邪已从表入里，太阳、阳明并病，应以**厚朴三物汤**泻下肠胃之邪热。如果腹胀满疼痛较甚，应以**厚朴七物汤**表里双解。

如果寸口脉出现迟而缓的脉象，就会导致腹中绞痛。

腹满病的病人，如果寸口脉出现迟而缓的脉象，迟脉主阴寒，缓脉主气滞，寒邪与气滞相互搏结，就会导致腹中绞痛。

如果寸口脉出现迟而涩的脉象，迟脉主阴寒，涩脉主营血不足。

★名词解释

寒疝：由于脾胃虚寒，或是产后血虚，又因感受风寒之邪，邪气入里而结聚于脘腹中所引起的急性腹痛。表现为冷汗、四肢厥逆、腹中绞痛、四肢麻木，脉沉紧。

寸口脉出现迟而缓的脉象，就会导致腹中绞痛。



腹部胀满的病人

迟脉主寒证。
迟而有力为寒实证
(注：或为实热证)，
迟而无力为虚寒证。

缓脉主湿，或
主脾虚。

中焦虚寒的病人，喜欢打呵欠，以舒畅阳气，如果兼有流清涕、发热、面色平和的，为新感外邪，容易打喷嚏。

中焦虚寒的病人，因为中阳亏虚，阳气无力外达，因此虽想打喷嚏，又打不出来。

瘦弱的人，肚脐周围疼痛，这是因为感受风寒，脾胃功能失职，大便秘结不通，属于寒结证，如果误用苦寒攻下法治疗，将更伤中阳，致使胃气上冲，如果气不上冲，阻塞于中焦，就会发生心下痞满。

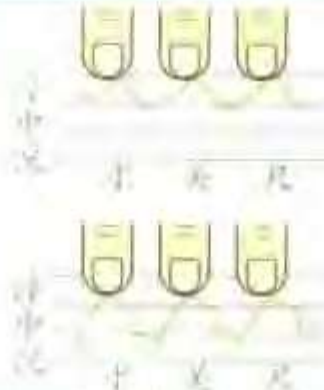
如果误用苦寒攻下法治疗，将更伤中阳，就会发生心下痞满。

此时，中焦虚寒的病人，如果寸口脉出现弦脉的脉象，就会出现胁下拘急而痛，特别恶寒的症状。

如果寸口脉出现浮而滑的脉象，为风热上扰清阳，会产生头痛。

寸口脉出现浮而滑的脉象，为风热上扰清阳，会产生头痛。





中焦虚寒的病人

浮脉主表证（脉必浮而有力），也可见于风水。

滑脉主痰饮，宿食，实热，蓄血。

如果趺阳脉缓而迟，缓脉主虚寒，迟脉主气虚，虚寒相互搏结在中焦，病人喜欢吃热食，如果吃生冷饮食，就会阻塞气机，产生咽膈。

虚寒相互搏结在中焦，如果吃生冷饮食，就会阻塞气机，产生咽膈。

如果寸口部出现微脉，尺中部出现紧而涩的脉象，这是误汗后其邪因下结所引起的。

如果寸口部出现微脉，尺中部出现紧而涩的脉象，紧脉主寒，微脉主气虚，涩脉主血虚。当出现这种脉象时，说明这是误汗后又用泻下法所引起的。趺阳脉出现紧脉，是中焦有寒，应当用温法，为何以发汗法和泻下法治疗呢？

中焦虚寒的病人

寸口部出现微脉。尺中部出现紧而涩的脉象。



这是误汗后又用泻下法所引起的。



如果出现数弦的脉象时，应当以温下法来祛其寒象。

如果脉象浮而紧，就像弦脉一样，好像弓弦般绷直，重按也不会移动。如果出现数弦的脉象时，应当以温下法来祛其寒象。表现为胁下疼痛，或在左侧，或在右侧，脉象紧张，这是寒实结聚于中焦，应以温药来攻下，用大黄附子汤。

寸口脉出现弦而紧的脉象，弦紧相互搏结，就会产生寒疝病。

如果寸口脉出现弦而紧的脉象，弦脉是因外邪阻遏卫阳，卫气不行，紧脉主寒，中阳虚弱，所以不想吃饭，弦紧相互搏结，就会产生寒疝病。

如果趺阳脉出现浮而迟的脉象，浮脉主风主虚，迟脉主寒疝，寒气内结，就会绕脐部疼痛，若寒疝病发病时，则自汗出，手足冰冷，脉象沉弦，应以大乌头汤治疗。

病起微恶寒时，则自汗出，手足冰冷，脉象沉弦。



中医知识

HEALTHFUL

Q.如果肠胃有宿食积滞，应如何辨别呢？

A.如果寸口脉象浮大，重按时反见涩象，尺部亦出现微而涩的脉象，这是胃肠食积，气滞不通所引起的。

如果寸口脉紧，像转动的绳索般坚紧，并且左右不定，表示是有宿食。

如果寸口脉紧，若是为浮紧脉，主外感风寒头痛；若是为沉紧脉，则主腹中有宿食不化。

如果出现滑而数的脉象，为里实证，表示胃肠有宿食，应当以泄下法来治疗。

寸口脉紧，表示是有宿食。

若是为浮紧脉，主外感风寒头痛。

若是为沉紧脉，则主腹中有宿食不化。

如果出现滑而数的脉象，为里实证，表示胃肠有宿食。



浮脉主表证（脉必浮而有力），也可见于风水。



紧脉主寒、主痛、主宿食。



沉脉主里证，沉而有力为里实，沉而无力为里虚。



滑脉主痰饮，宿食，实热，蓄血。



数脉主热；数脉亦主虚证。

下利后反而不喜欢吃东西，这是因为胃肠有宿食，应当以泄下法来治疗。

用泻下法治疗，大泻后六七天，出现大便不通，心腹不解，腹胀疼痛，这是因为有燥屎黏滞于肠道，主要病因还是由于宿食所引起的。

如果宿食停滞于上，有欲吐的症状，应当以吐法来治疗。

11. 平惊悸衄吐下血胸满瘀血脉证第十三

内容重点 论述惊、悸、衄血、吐血、下血、胸满、瘀血病的证候、脉象及治疗。

如果寸口脉出现而动而弱的脉象，脉主惊证；弱脉主悸证。

寸口脉出现动而弱的脉象，动脉主惊证；弱脉主悸证。



动脉主痛，主惊。



弱脉主气血亏虚。

如果趺阳脉出现微而浮的脉象，浮而无为之脉象主胃气虚，微脉主不能食，这是恐惧症的脉象，由于病因为惊恐所引起，因此会出现止而复来的脉象，以及病人视物不清的症状。

如果寸口脉微，而趺阳脉浮而无方，主胃气虚。



中医师解说

HEALTHFUL

Q. 如果寸口脉微，而趺阳脉浮而无方，主胃气虚。而寸口出现沉紧的脉象，主寒实。寒邪侵于上焦，必定使胸膈胀满而喘气。至于胃气虚弱的病人，如果趺阳脉出现浮而无力的脉象，少阳脉出现紧弦的脉象，就会出现心悸，这是什么原因呢？

A. 这是因为心阳与水湿互相搏结，蕴结心胸，所以心悸不宁。如果诊脉出现沉、滑、弱的脉象，为大失血。

如果脉中出现沉、滑、弱的脉象，为大失血。

如果出现弦大的脉象，是精血亏损的虚劳脉象。

如果出现弦大的脉象，是精血亏损的虚劳脉象，脉象虽弦，但重按则减弱；脉象虽大却大而中空，重按则减弱为寒，大而中空为虚，是虚寒相搏结，称为芤脉，妇人出现芤脉则容易小产或月经淋漓不断，男子则为失血。

失血的病人，不可发汗解表，如果汗出重伤阳气和阴液，就会产生怕冷和全身震颤。



小医馆解惑

H E A L T H F U L

Q. 如果鼻子出血而数日不止，会出现怎样的脉象？

A. 当诊脉时，浮取、中取均见轻而无力的脉象，并且尺部出现浮大而无力的脉象，眼球颜色晦黄，表示出血仍未止，当眼球晦黄的颜色退去后，视物清晰，表示鼻出血已止。

从春季到夏季，发生鼻子出血的病证属于太阳，从秋季到冬季发生鼻子出血的属于阳明，这是因为春夏阳气初升，表热居多，而秋冬阳气已降，里热居多。

如果寸脉微弱，而尺脉涩，属于下虚而上实。

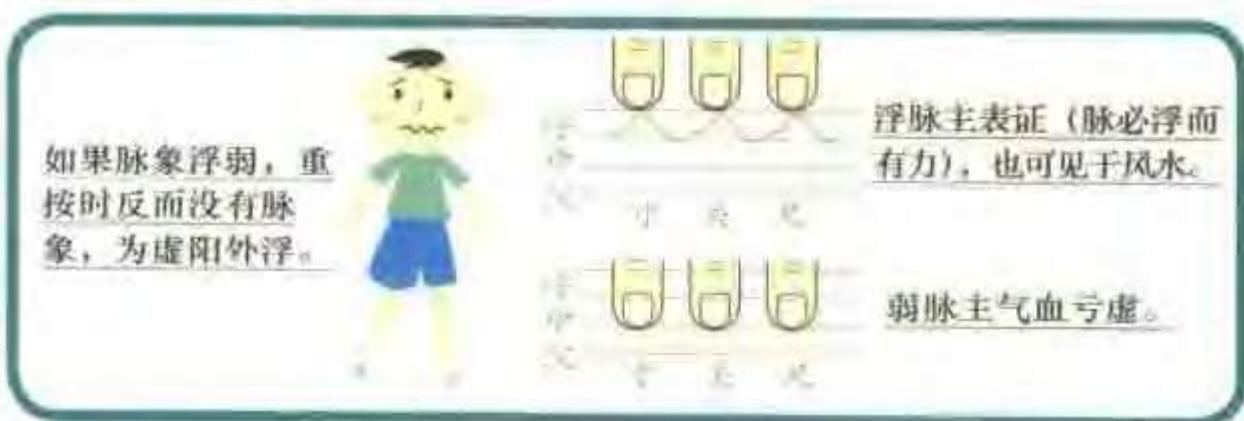
如果寸脉微弱，而尺脉涩，弱脉主发热，涩脉主血虚，病人会出现厥逆、微微欲呕的症状。此时应当自觉晕眩却不晕眩，而反出现头痛，疼痛表示实证，属于下虚而上实，因此会出现鼻子出血的症状。

如果太阳脉出现洪大而浮的脉象，必定会鼻子出血、吐血。

如果病人面无血色，也没有外感恶寒发热，脉象沉弦，为鼻子出血的病证。

鼻子出血的病人，不可发汗。若发汗则会伤阴耗血，致使额头上紧绷发急，双目直视而不能转动，不能安眠。

如果脉象浮弱，重按时反而没有脉象，为虚阳外浮，阳不能摄阴，因此血脱于下而下血；如果心阳而兼有干呕，则会吐血。

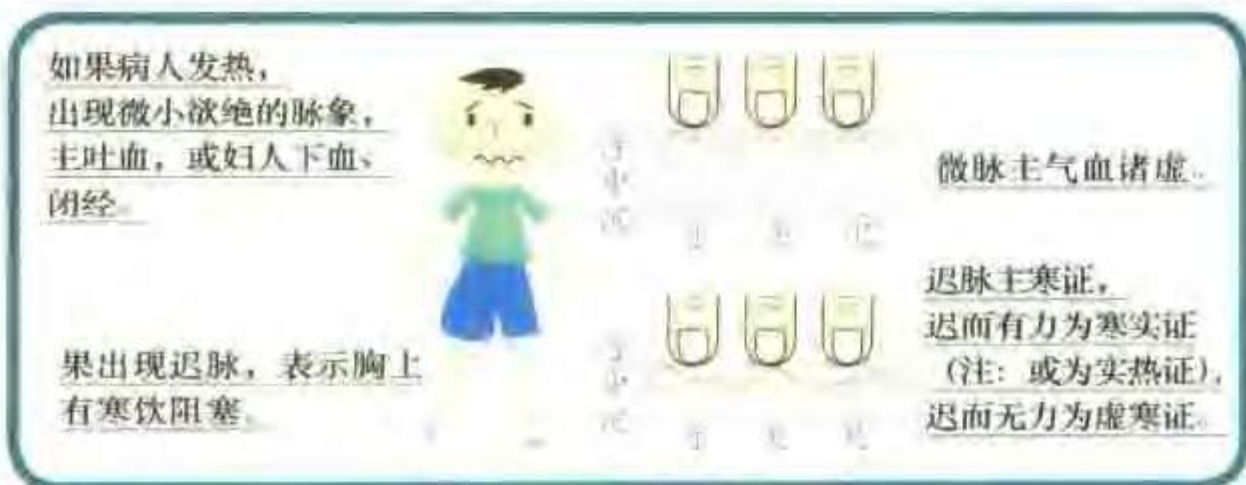


如果寸口脉出现微而弱的脉象，主气血俱虚。

如果寸口脉出现微而弱的脉象，主气血俱虚，男子容易出现吐血；女子则容易发生下血；如果兼有呕吐、汗出的症状，表示病情还可以治疗。

如果趺阳脉出现微而弱的脉象，在春天胃气开发时，患呕吐下利的病证，也比较容易治疗，否则，如果阳虚而水气停滞，病人必定腹部胀满，小便不利。

如果病人发热，出现微小欲绝的脉象，主吐血，或妇人下血、闭经。这是因为阳虚而寒盛。如果出现迟脉，表示胸上有寒饮阻塞，因此噎气频频，而吐痰涎。



如果趺阳脉与少阴脉皆出现微弱的脉象，而病人并没有呕吐、下利，那就是失血而引起的。

脉沉主病在脏，血分。营阴与卫气壅结于里，如果兼有胸膈满闷，就会吐血。

如果男子身形肥大，脉象却微弱，趺阳脉亦微弱，只有少阴脉浮大而无力的，必然会出现便血、失精的症状；如果兼有小便疼痛急迫，就会出现小便不利的症状。

如果趺阳脉出现弦脉，必定会痔疮出血。

如果病人胸部胀满，嘴唇干枯，舌体青紫，口干舌燥，只想含水润口，却不想吞下，并且没有外感寒热病证，脉象微大无力而迟，按压腹部时并不觉胀满，病人却自觉腹满，这是因为内有瘀血的缘故。

如当发汗时却不发，病邪结聚于里，就会形成瘀血。

如果应当发汗时却不发，病邪结聚于里，就会形成瘀血。病人好像有发热的症状，并且心煩胸满，口干燥而渴，但脉象却并不是热证的脉象，这是因为邪热伏于阴分，瘀血内阻的缘故，应当用泻下法治疗。

如果下血病，先见出血，而后见大便，表示患瘀血病未久；如果先见大便，而后见血，表示患瘀血病较久。